



Handbook delle

Competenze Infermieristiche

ASST Cremona

DAPSS • sviluppo professionale

Mappatura, descrizione e progressione
delle competenze infermieristiche

Edizione 2026

Handbook delle Competenze Infermieristiche

Guida alla lettura, descrizione e progressione
dei livelli di competenza

Prima edizione • Manuale operativo

Le competenze infermieristiche non rappresentano soltanto un elenco di attività da svolgere o di abilità da possedere. Rappresentano, prima di tutto, il modo in cui la professionalità infermieristica prende forma nella pratica quotidiana: nel giudizio clinico, nella capacità di leggere i bisogni della persona, nella responsabilità verso la sicurezza delle cure, nella relazione con i pazienti, le famiglie e il team, nella disponibilità a crescere insieme ai cambiamenti dell'assistenza. In questa prospettiva, parlare di competenze significa parlare di identità professionale, di qualità organizzativa e di sviluppo continuo.

Questo Handbook nasce per accompagnare e rendere più leggibile il percorso di **mappatura, aggiornamento e valutazione delle competenze infermieristiche** promosso in ASST Cremona. Il protocollo aziendale definisce infatti la necessità di identificare le competenze richieste nei diversi contesti assistenziali, di monitorarle nel tempo e di utilizzare i risultati per orientare sviluppo professionale, formazione e programmazione organizzativa. Questo documento si colloca dentro quella cornice: non sostituisce lo strumento valutativo, ma lo rende più chiaro, più concreto e più vicino alla pratica.

L'obiettivo di questo Handbook è offrire una guida interpretativa condivisa. Ogni competenza qui descritta non è presentata come una formula astratta, ma come una capacità professionale situata, che assume significato nel contesto reale del lavoro infermieristico. Per questo, accanto al titolo, all'area e al codice identificativo, ogni scheda esplicita il **razionale** della competenza, chiarisce i suoi **descrittori** e ne interpreta i livelli di sviluppo professionale. In questo modo, la competenza diventa osservabile, discutibile, formabile e valutabile in maniera più trasparente e coerente.

All'interno del Handbook il lettore troverà, per ogni competenza, alcuni elementi fondamentali. Anzitutto il **perché**: il razionale clinico, assistenziale, etico o organizzativo che rende quella competenza rilevante. Poi il **che cosa**: i descrittori che ne compongono la sostanza professionale, intesi come integrazione di attitudini, motivazioni, abilità pratiche e conoscenze specifiche. Infine il **come evolve**: una lettura dei livelli di sviluppo ispirata al modello di Benner, così da riconoscere non solo se una competenza è presente, ma anche con quale profondità, autonomia, consapevolezza e capacità di adattamento viene espressa nella pratica. Il protocollo aziendale richiama infatti esplicitamente una valutazione progressiva delle competenze lungo i livelli da novizio a esperto, inserendola in un sistema più ampio di autovalutazione, valutazione organizzativa e pianificazione dello sviluppo individuale.

Questo Handbook ha anche un valore culturale. Non serve soltanto a classificare o misurare, ma a costruire un linguaggio comune tra professionisti, coordinatori, tutor e organizzazione. Rendere esplicite le competenze significa riconoscere ciò che spesso, nella pratica quotidiana, rimane implicito: il ragionamento clinico che precede un'azione, la sensibilità che consente di cogliere precocemente un rischio, la motivazione che sostiene la qualità del lavoro anche nei contesti più complessi, la capacità di integrare conoscenze, esperienza e responsabilità nelle decisioni assistenziali. Significa, in altre parole, valorizzare il sapere professionale infermieristico nella sua interezza.

In questa prospettiva, il Handbook è pensato come uno strumento vivo. Può sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti, favorire il confronto valutativo, orientare la formazione continua, rendere più leggibili i bisogni di sviluppo e accompagnare nel tempo l'evoluzione dei profili professionali. Il protocollo stesso prevede che la valutazione delle competenze contribuisca alla definizione di piani individuali di sviluppo, al monitoraggio delle aree di miglioramento e alla costruzione di priorità formative a livello aziendale. Questo documento vuole offrire una base concreta per farlo in modo più consapevole, condiviso e rigoroso.

Questo Handbook, dunque, non è semplicemente una raccolta di competenze. È una guida per leggere la complessità del lavoro infermieristico, per riconoscerne il valore, per sostenere la crescita professionale e per collegare in modo più stretto pratica clinica, sviluppo delle persone e qualità dell'organizzazione. Ogni competenza descritta nelle pagine che seguono è un tassello di questo disegno: non un punto d'arrivo statico, ma una traiettoria di sviluppo che mette al centro il professionista, la sicurezza delle cure e la capacità del sistema di apprendere e migliorare.

Competenze Infermieristiche Trasversali

Collaborazione e comunicazione

COL1 — Coordinare le attività assistenziali con l'équipe multidisciplinare dimostrando flessibilità

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Collaborazione e comunicazione

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di coordinare le attività assistenziali con l'équipe multidisciplinare dimostrando flessibilità nell'ambito di collaborazione e comunicazione. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura
- Riconoscere la dignità della persona anche nelle condizioni di vulnerabilità o conflitto

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di coordinare le attività assistenziali con l'équipe multidisciplinare dimostrando flessibilità
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona
- Adattare linguaggio, tono, postura e tempi comunicativi al contesto

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- SBAR e altre strutture di handover/comunicazione clinica
- Dinamiche di team, ruoli e gestione costruttiva dei conflitti
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio

- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

COL2 — Coordinarsi con i membri dell'équipe nella distribuzione del carico di lavoro

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Collaborazione e comunicazione

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di coordinarsi con i membri dell'équipe nella distribuzione del carico di lavoro nell'ambito di collaborazione e comunicazione. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura
- Riconoscere la dignità della persona anche nelle condizioni di vulnerabilità o conflitto

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di coordinarsi con i membri dell'équipe nella distribuzione del carico di lavoro
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona
- Adattare linguaggio, tono, postura e tempi comunicativi al contesto

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- SBAR e altre strutture di handover/comunicazione clinica
- Dinamiche di team, ruoli e gestione costruttiva dei conflitti
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel mantenere un setting terapeutico chiaro, rispettoso e funzionale; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.

- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

COL3 — Contribuire a sviluppare un clima di lavoro positivo

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Collaborazione e comunicazione

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di contribuire a sviluppare un clima di lavoro positivo nell'ambito di collaborazione e comunicazione. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale
- Attenzione ai significati emotivi e relazionali della situazione assistenziale
- Coerenza tra comunicazione verbale, non verbale e intenzionalità terapeutica

Motivazioni

- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura
- Riconoscere la dignità della persona anche nelle condizioni di vulnerabilità o conflitto
- Utilizzare la relazione come strumento clinico e non come semplice scambio informativo

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di contribuire a sviluppare un clima di lavoro positivo
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona
- Adattare linguaggio, tono, postura e tempi comunicativi al contesto
- Gestire colloqui difficili mantenendo contenimento emotivo e chiarezza professionale

Conoscenze

- SBAR e altre strutture di handover/comunicazione clinica
- Dinamiche di team, ruoli e gestione costruttiva dei conflitti
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica
- Aspetti etici e di privacy connessi alla relazione di cura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel mantenere un setting terapeutico chiaro, rispettoso e funzionale; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.

- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

COL4 — Fornire una comunicazione chiara, rispettosa e centrata sull'assistito con pazienti, caregiver e operatori sanitari

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Collaborazione e comunicazione

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di fornire una comunicazione chiara, rispettosa e centrata sull'assistito con pazienti, caregiver e operatori sanitari nell'ambito di collaborazione e comunicazione. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Sensibilità ai bisogni emotivi e informativi espressi o impliciti
- Capacità di mantenere coerenza tra contenuto, tono e postura professionale
- Orientamento a valorizzare risorse, priorità e tempi di apprendimento della persona

Motivazioni

- Rendere comprensibile il percorso di cura e favorire scelte realmente consapevoli
- Favorire autonomia sostenibile e ridurre dipendenza evitabile dal sistema sanitario
- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di fornire una comunicazione chiara, rispettosa e centrata sull'assistito con pazienti, caregiver e operatori sanitari
- Verificare comprensione, dubbi, consenso e necessità di rinforzo informativo
- Strutturare messaggi prioritari, rinforzi educativi e verifica del ritorno informativo
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona

Conoscenze

- Principi di comunicazione efficace, decisione condivisa, consenso e adattamento del linguaggio
- Health literacy, teach-back, aderenza terapeutica e strategie di rinforzo dell'autogestione
- SBAR e altre strutture di handover/comunicazione clinica
- Dinamiche di team, ruoli e gestione costruttiva dei conflitti
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nella personalizzazione dei messaggi, nella verifica della comprensione e nel sostegno all'autonomia; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.

- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

COL5 — Comunicare con il team interprofessionale sullo stato di salute dell'assistito e sulle strategie di gestione per ottimizzare gli esiti

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Collaborazione e comunicazione

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di comunicare con il team interprofessionale sullo stato di salute dell'assistito e sulle strategie di gestione per ottimizzare gli esiti nell'ambito di collaborazione e comunicazione. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura
- Riconoscere la dignità della persona anche nelle condizioni di vulnerabilità o conflitto

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di comunicare con il team interprofessionale sullo stato di salute dell'assistito e sulle strategie di gestione per ottimizzare gli esiti
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona
- Adattare linguaggio, tono, postura e tempi comunicativi al contesto

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- SBAR e altre strutture di handover/comunicazione clinica
- Dinamiche di team, ruoli e gestione costruttiva dei conflitti
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel mantenere un setting terapeutico chiaro, rispettoso e funzionale; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

Evidence Based Practice

EBP1 — Conoscere e utilizzare fonti di letteratura scientifica per aggiornare protocolli e procedure assistenziali

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Evidence based practice

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di conoscere e utilizzare fonti di letteratura scientifica per aggiornare protocolli e procedure assistenziali nell'ambito di evidence based practice. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni poco fondate, perdita di qualità dei dati e ridotta trasferibilità delle evidenze. La sua corretta espressione produce aggiornamento della pratica, innovazione controllata e miglioramento guidato da dati e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Atteggiamento critico verso routine non supportate da evidenze
- Curiosità scientifica e disponibilità a mettere in discussione routine consolidate
- Rigore nel trattamento dei dati, nella verifica delle fonti e nella documentazione

Motivazioni

- Trasformare l'aggiornamento professionale in miglioramento concreto della pratica
- Migliorare la pratica assistenziale attraverso decisioni informate da prove affidabili
- Sostenere innovazione e qualità senza separare ricerca e assistenza

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di conoscere e utilizzare fonti di letteratura scientifica per aggiornare protocolli e procedure assistenziali
- Valutare affidabilità delle fonti e trasferibilità delle evidenze al contesto locale
- Ricercare, selezionare e utilizzare fonti affidabili in modo sistematico
- Applicare protocolli e procedure di raccolta dati con accuratezza e tracciabilità

Conoscenze

- Quesiti clinico-assistenziali, PICO, criteri di qualità metodologica e applicabilità dei risultati
- Banche dati bibliografiche, strategie di ricerca e criteri di selezione degli studi
- Principi di implementazione delle evidenze in protocolli e procedure
- Principi di metodologia della ricerca, gerarchia delle evidenze e critical appraisal
- Indicatori clinici, esiti sensibili all'assistenza e principi base di audit

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Usa strumenti, procedure o fonti secondo istruzioni definite nell'uso rigoroso delle evidenze, dei protocolli e della documentazione; necessita di supervisione per valutare qualità metodologica, coerenza documentale o implicazioni dei dati.
- **Principiante avanzato:** Ricerca e utilizza fonti/protocolli con discreta autonomia nei casi più frequenti; riconosce criticità comuni ma richiede confronto per analisi e decisioni più complesse.
- **Competente:** Gestisce in autonomia attività ordinarie di ricerca/EBP/documentazione, garantisce accuratezza dei dati e trasferisce risultati rilevanti alla pratica clinica.
- **Abile:** Interpreta criticamente dati ed evidenze, individua limiti/applicabilità e orienta miglioramenti clinico-organizzativi fondati su prove e indicatori.
- **Esperto:** Agisce come riferimento metodologico locale: sostiene colleghi, anticipa criticità di qualità del dato/protocollo e contribuisce allo sviluppo di pratiche innovative e rigorose.

EBP2 — Identificare aree di approfondimento e di ricerca nell'assistenza

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Evidence based practice

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di identificare aree di approfondimento e di ricerca nell'assistenza nell'ambito di evidence based practice. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni poco fondate, perdita di qualità dei dati e ridotta trasferibilità delle evidenze. La sua corretta espressione produce aggiornamento della pratica, innovazione controllata e miglioramento guidato da dati e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Atteggiamento critico verso routine non supportate da evidenze
- Curiosità scientifica e disponibilità a mettere in discussione routine consolidate
- Rigore nel trattamento dei dati, nella verifica delle fonti e nella documentazione

Motivazioni

- Trasformare l'aggiornamento professionale in miglioramento concreto della pratica
- Migliorare la pratica assistenziale attraverso decisioni informate da prove affidabili
- Sostenere innovazione e qualità senza separare ricerca e assistenza

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di identificare aree di approfondimento e di ricerca nell'assistenza
- Valutare affidabilità delle fonti e trasferibilità delle evidenze al contesto locale
- Ricercare, selezionare e utilizzare fonti affidabili in modo sistematico
- Applicare protocolli e procedure di raccolta dati con accuratezza e tracciabilità

Conoscenze

- Quesiti clinico-assistenziali, PICO, criteri di qualità metodologica e applicabilità dei risultati
- Banche dati bibliografiche, strategie di ricerca e criteri di selezione degli studi
- Principi di implementazione delle evidenze in protocolli e procedure
- Principi di metodologia della ricerca, gerarchia delle evidenze e critical appraisal
- Indicatori clinici, esiti sensibili all'assistenza e principi base di audit

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Usa strumenti, procedure o fonti secondo istruzioni definite nell'uso rigoroso delle evidenze, dei protocolli e della documentazione; necessita di supervisione per valutare qualità metodologica, coerenza documentale o implicazioni dei dati.

- **Principiante avanzato:** Ricerca e utilizza fonti/protocolli con discreta autonomia nei casi più frequenti; riconosce criticità comuni ma richiede confronto per analisi e decisioni più complesse.
- **Competente:** Gestisce in autonomia attività ordinarie di ricerca/EBP/documentazione, garantisce accuratezza dei dati e trasferisce risultati rilevanti alla pratica clinica.
- **Abile:** Interpreta criticamente dati ed evidenze, individua limiti/applicabilità e orienta miglioramenti clinico-organizzativi fondati su prove e indicatori.
- **Esperto:** Agisce come riferimento metodologico locale: sostiene colleghi, anticipa criticità di qualità del dato/protocollo e contribuisce allo sviluppo di pratiche innovative e rigorose.

EBP3 — Utilizzare i risultati della ricerca per supportare decisioni condivise e personalizzate

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Evidence based practice

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di utilizzare i risultati della ricerca per supportare decisioni condivise e personalizzate nell'ambito di evidence based practice. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni poco fondate, perdita di qualità dei dati e ridotta trasferibilità delle evidenze. La sua corretta espressione produce aggiornamento della pratica, innovazione controllata e miglioramento guidato da dati e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Atteggiamento critico verso routine non supportate da evidenze
- Curiosità scientifica e disponibilità a mettere in discussione routine consolidate
- Rigore nel trattamento dei dati, nella verifica delle fonti e nella documentazione

Motivazioni

- Trasformare l'aggiornamento professionale in miglioramento concreto della pratica
- Migliorare la pratica assistenziale attraverso decisioni informate da prove affidabili
- Sostenere innovazione e qualità senza separare ricerca e assistenza

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di utilizzare i risultati della ricerca per supportare decisioni condivise e personalizzate
- Valutare affidabilità delle fonti e trasferibilità delle evidenze al contesto locale
- Ricercare, selezionare e utilizzare fonti affidabili in modo sistematico
- Applicare protocolli e procedure di raccolta dati con accuratezza e tracciabilità

Conoscenze

- Quesiti clinico-assistenziali, PICO, criteri di qualità metodologica e applicabilità dei risultati
- Banche dati bibliografiche, strategie di ricerca e criteri di selezione degli studi
- Principi di implementazione delle evidenze in protocolli e procedure
- Principi di metodologia della ricerca, gerarchia delle evidenze e critical appraisal
- Indicatori clinici, esiti sensibili all'assistenza e principi base di audit

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Usa strumenti, procedure o fonti secondo istruzioni definite nell'uso rigoroso delle evidenze, dei protocolli e della documentazione; necessita di supervisione per valutare qualità metodologica, coerenza documentale o implicazioni dei dati.

- **Principiante avanzato:** Ricerca e utilizza fonti/protocolli con discreta autonomia nei casi più frequenti; riconosce criticità comuni ma richiede confronto per analisi e decisioni più complesse.
- **Competente:** Gestisce in autonomia attività ordinarie di ricerca/EBP/documentazione, garantisce accuratezza dei dati e trasferisce risultati rilevanti alla pratica clinica.
- **Abile:** Interpreta criticamente dati ed evidenze, individua limiti/applicabilità e orienta miglioramenti clinico-organizzativi fondati su prove e indicatori.
- **Esperto:** Agisce come riferimento metodologico locale: sostiene colleghi, anticipa criticità di qualità del dato/protocollo e contribuisce allo sviluppo di pratiche innovative e rigorose.

Educazione terapeutica

EDU1 — Riconoscere e soddisfare i bisogni educativi dell'assistito e dei caregiver

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Educazione terapeutica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere e soddisfare i bisogni educativi dell'assistito e dei caregiver nell'ambito di educazione terapeutica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare scarsa comprensione, bassa aderenza e difficoltà nell'autogestione. La sua corretta espressione produce maggiore autonomia, aderenza e partecipazione informata alle cure e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Orientamento a valorizzare risorse, priorità e tempi di apprendimento della persona
- Ascolto attivo e rispetto del livello di comprensione della persona e della famiglia
- Flessibilità comunicativa nel modulare linguaggio, tempi e strumenti educativi

Motivazioni

- Favorire autonomia sostenibile e ridurre dipendenza evitabile dal sistema sanitario
- Favorire consapevolezza e partecipazione attiva della persona al percorso di cura
- Ridurre errori, riacutizzazioni e dipendenza evitabile attraverso un apprendimento efficace

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere e soddisfare i bisogni educativi dell'assistito e dei caregiver
- Strutturare messaggi prioritari, rinforzi educativi e verifica del ritorno informativo
- Accertare bisogni educativi, barriere e risorse di apprendimento
- Pianificare interventi educativi graduati e verificare comprensione e trasferibilità

Conoscenze

- Health literacy, teach-back, aderenza terapeutica e strategie di rinforzo dell'autogestione
- Pianificazione educativa personalizzata, teach-back e valutazione degli esiti educativi
- Principi di educazione terapeutica, health literacy e apprendimento degli adulti
- Strumenti di teaching, teach-back e rinforzo dell'aderenza/autogestione
- Fattori culturali, cognitivi ed emotivi che influenzano la comprensione e l'autocura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Fornisce informazioni essenziali seguendo indicazioni e materiali disponibili nella personalizzazione dei messaggi, nella verifica della comprensione e nel sostegno all'autonomia; verifica in modo ancora limitato comprensione e trasferibilità dei contenuti.

- **Principiante avanzato:** Adatta parzialmente linguaggio e tempi ai bisogni più evidenti; riconosce barriere frequenti ma necessita di supporto per pianificare interventi educativi più complessi.
- **Competente:** Accerta bisogni educativi, pianifica interventi graduati, utilizza verifiche di comprensione e rivaluta gli esiti nei casi ordinari con buona autonomia.
- **Abile:** Personalizza in profondità l'educazione in base a literacy, motivazione, fragilità, credenze e contesto familiare; trasforma il colloquio educativo in leva di aderenza e autonomia.
- **Esperto:** Costruisce veri percorsi educativi complessi, supporta colleghi nel gestire situazioni difficili e contribuisce a materiali, strumenti e modelli educativi del servizio.

EDU2 — Valutare gli esiti degli interventi educativi con l'assistito e l'équipe multidisciplinare

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Educazione terapeutica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare gli esiti degli interventi educativi con l'assistito e l'équipe multidisciplinare nell'ambito di educazione terapeutica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare scarsa comprensione, bassa aderenza e difficoltà nell'autogestione. La sua corretta espressione produce maggiore autonomia, aderenza e partecipazione informata alle cure e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Ascolto attivo e rispetto del livello di comprensione della persona e della famiglia

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Favorire consapevolezza e partecipazione attiva della persona al percorso di cura
- Ridurre errori, riacutizzazioni e dipendenza evitabile attraverso un apprendimento efficace

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare gli esiti degli interventi educativi con l'assistito e l'équipe multidisciplinare
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro
- Accertare bisogni educativi, barriere e risorse di apprendimento
- Pianificare interventi educativi graduati e verificare comprensione e trasferibilità

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- Pianificazione educativa personalizzata, teach-back e valutazione degli esiti educativi
- Principi di educazione terapeutica, health literacy e apprendimento degli adulti
- Strumenti di teaching, teach-back e rinforzo dell'aderenza/autogestione
- Fattori culturali, cognitivi ed emotivi che influenzano la comprensione e l'autocura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Fornisce informazioni essenziali seguendo indicazioni e materiali disponibili nella costruzione di comprensione, aderenza e partecipazione attiva; verifica in modo ancora limitato comprensione e trasferibilità dei contenuti.

- **Principiante avanzato:** Adatta parzialmente linguaggio e tempi ai bisogni più evidenti; riconosce barriere frequenti ma necessita di supporto per pianificare interventi educativi più complessi.
- **Competente:** Accerta bisogni educativi, pianifica interventi graduati, utilizza verifiche di comprensione e rivaluta gli esiti nei casi ordinari con buona autonomia.
- **Abile:** Personalizza in profondità l'educazione in base a literacy, motivazione, fragilità, credenze e contesto familiare; trasforma il colloquio educativo in leva di aderenza e autonomia.
- **Esperto:** Costruisce veri percorsi educativi complessi, supporta colleghi nel gestire situazioni difficili e contribuisce a materiali, strumenti e modelli educativi del servizio.

Etica e Responsabilità Professionale

ETI1 — Ottenere il consenso informato garantendo comunicazione chiara e rispetto dei principi etici

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Etica e responsabilità professionale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di ottenere il consenso informato garantendo comunicazione chiara e rispetto dei principi etici nell'ambito di etica e responsabilità professionale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni non proporzionate, tutela insufficiente dei diritti e criticità documentali. La sua corretta espressione produce sicurezza, trasparenza e tutela bilanciata di persona, équipe e organizzazione e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Sensibilità ai bisogni emotivi e informativi espressi o impliciti
- Capacità di mantenere coerenza tra contenuto, tono e postura professionale
- Fermezza professionale unita a rispetto dei diritti e della dignità della persona

Motivazioni

- Rendere comprensibile il percorso di cura e favorire scelte realmente consapevoli
- Garantire che gli interventi limitativi siano davvero necessari, proporzionati e tracciati
- Tutelare contemporaneamente sicurezza, diritti e trasparenza del percorso assistenziale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di ottenere il consenso informato garantendo comunicazione chiara e rispetto dei principi etici
- Garantire comunicazione chiara e rispetto dei principi etici
- Verificare comprensione, dubbi, consenso e necessità di rinforzo informativo
- Applicare riferimenti normativi e criteri clinici nelle decisioni a rilevanza legale

Conoscenze

- Principi di comunicazione efficace, decisione condivisa, consenso e adattamento del linguaggio
- Bioetica clinica, consenso informato, autodeterminazione e gestione dei dilemmi assistenziali
- Quadro normativo, procedure aziendali e responsabilità professionali pertinenti
- Criteri di proporzionalità, necessità, consenso/informazione e tutela dei diritti
- Requisiti documentali e di tracciabilità nelle situazioni a rilievo medico-legale

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica norme, procedure e criteri di base seguendo indicazioni definite nella personalizzazione dei messaggi, nella verifica della comprensione e nel sostegno all'autonomia; necessita di supervisione per valutare proporzionalità, documentazione o implicazioni etico-legali.

- **Principiante avanzato:** Riconosce i principali profili di tutela e rischio giuridico nei casi frequenti; richiede confronto quando la situazione presenta conflitti di diritti, rischio elevato o forte pressione emotiva.
- **Competente:** Gestisce in autonomia i casi ordinari, documenta in modo accurato motivazioni e rivalutazioni e coinvolge i soggetti competenti secondo procedura.
- **Abile:** Bilancia in modo maturo sicurezza, diritti, contesto e conseguenze organizzative; anticipa criticità documentali/legali e sostiene il team nelle decisioni complesse.
- **Esperto:** È punto di riferimento per la lettura etico-legale del caso, promuove scelte proporzionate e contribuisce a procedure, audit e cultura della tutela nel servizio.

ETI2 — Dimostrare empatia modulando gli interventi relazionali con assistito, caregiver e colleghi

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Etica e responsabilità professionale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di dimostrare empatia modulando gli interventi relazionali con assistito, caregiver e colleghi nell'ambito di etica e responsabilità professionale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni non proporzionate, tutela insufficiente dei diritti e criticità documentali. La sua corretta espressione produce sicurezza, trasparenza e tutela bilanciata di persona, équipe e organizzazione e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Sensibilità ai bisogni emotivi e informativi espressi o impliciti

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Rendere comprensibile il percorso di cura e favorire scelte realmente consapevoli
- Favorire autonomia sostenibile e ridurre dipendenza evitabile dal sistema sanitario

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di dimostrare empatia modulando gli interventi relazionali con assistito, caregiver e colleghi
- Modulare gli interventi relazionali con assistito, caregiver e colleghi
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro
- Verificare comprensione, dubbi, consenso e necessità di rinforzo informativo

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- Principi di comunicazione efficace, decisione condivisa, consenso e adattamento del linguaggio
- Health literacy, teach-back, aderenza terapeutica e strategie di rinforzo dell'autogestione
- Bioetica clinica, consenso informato, autodeterminazione e gestione dei dilemmi assistenziali
- Quadro normativo, procedure aziendali e responsabilità professionali pertinenti

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica norme, procedure e criteri di base seguendo indicazioni definite nella personalizzazione dei messaggi, nella verifica della comprensione e nel sostegno all'autonomia; necessita di supervisione per valutare proporzionalità, documentazione o implicazioni etico-legali.

- **Principiante avanzato:** Riconosce i principali profili di tutela e rischio giuridico nei casi frequenti; richiede confronto quando la situazione presenta conflitti di diritti, rischio elevato o forte pressione emotiva.
- **Competente:** Gestisce in autonomia i casi ordinari, documenta in modo accurato motivazioni e rivalutazioni e coinvolge i soggetti competenti secondo procedura.
- **Abile:** Bilancia in modo maturo sicurezza, diritti, contesto e conseguenze organizzative; anticipa criticità documentali/legali e sostiene il team nelle decisioni complesse.
- **Esperto:** È punto di riferimento per la lettura etico-legale del caso, promuove scelte proporzionate e contribuisce a procedure, audit e cultura della tutela nel servizio.

ET13 — Valutare criticamente la cultura professionale dell'unità operativa in relazione ai bisogni assistenziali

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Etica e responsabilità professionale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare criticamente la cultura professionale dell'unità operativa in relazione ai bisogni assistenziali nell'ambito di etica e responsabilità professionale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni non proporzionate, tutela insufficiente dei diritti e criticità documentali. La sua corretta espressione produce sicurezza, trasparenza e tutela bilanciata di persona, équipe e organizzazione e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Sensibilità ai bisogni emotivi e informativi espressi o impliciti
- Capacità di mantenere coerenza tra contenuto, tono e postura professionale
- Fermezza professionale unita a rispetto dei diritti e della dignità della persona

Motivazioni

- Rendere comprensibile il percorso di cura e favorire scelte realmente consapevoli
- Garantire che gli interventi limitativi siano davvero necessari, proporzionati e tracciati
- Tutelare contemporaneamente sicurezza, diritti e trasparenza del percorso assistenziale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare criticamente la cultura professionale dell'unità operativa in relazione ai bisogni assistenziali
- Verificare comprensione, dubbi, consenso e necessità di rinforzo informativo
- Applicare riferimenti normativi e criteri clinici nelle decisioni a rilevanza legale
- Documentare motivazioni, tempi, rivalutazioni ed esiti con precisione

Conoscenze

- Principi di comunicazione efficace, decisione condivisa, consenso e adattamento del linguaggio
- Bioetica clinica, consenso informato, autodeterminazione e gestione dei dilemmi assistenziali
- Quadro normativo, procedure aziendali e responsabilità professionali pertinenti
- Criteri di proporzionalità, necessità, consenso/informazione e tutela dei diritti
- Requisiti documentali e di tracciabilità nelle situazioni a rilievo medico-legale

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica norme, procedure e criteri di base seguendo indicazioni definite nel modulare la relazione, contenere il rischio e scegliere il livello di intervento più adeguato; necessita di supervisione per valutare proporzionalità, documentazione o implicazioni etico-legali.

- **Principiante avanzato:** Riconosce i principali profili di tutela e rischio giuridico nei casi frequenti; richiede confronto quando la situazione presenta conflitti di diritti, rischio elevato o forte pressione emotiva.
- **Competente:** Gestisce in autonomia i casi ordinari, documenta in modo accurato motivazioni e rivalutazioni e coinvolge i soggetti competenti secondo procedura.
- **Abile:** Bilancia in modo maturo sicurezza, diritti, contesto e conseguenze organizzative; anticipa criticità documentali/legali e sostiene il team nelle decisioni complesse.
- **Esperto:** È punto di riferimento per la lettura etico-legale del caso, promuove scelte proporzionate e contribuisce a procedure, audit e cultura della tutela nel servizio.

ETI4 — Fondare le decisioni assistenziali sui principi dell'etica professionale

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Etica e responsabilità professionale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di fondare le decisioni assistenziali sui principi dell'etica professionale nell'ambito di etica e responsabilità professionale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni non proporzionate, tutela insufficiente dei diritti e criticità documentali. La sua corretta espressione produce sicurezza, trasparenza e tutela bilanciata di persona, équipe e organizzazione e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Fermezza professionale unita a rispetto dei diritti e della dignità della persona
- Accuratezza documentale e consapevolezza del peso clinico-legale delle decisioni
- Capacità di mantenere lucidità e proporzionalità in situazioni ad alta tensione

Motivazioni

- Garantire che gli interventi limitativi siano davvero necessari, proporzionati e tracciati
- Tutelare contemporaneamente sicurezza, diritti e trasparenza del percorso assistenziale
- Agire con responsabilità etica anche quando il contesto è critico o conflittuale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di fondare le decisioni assistenziali sui principi dell'etica professionale
- Applicare riferimenti normativi e criteri clinici nelle decisioni a rilevanza legale
- Documentare motivazioni, tempi, rivalutazioni ed esiti con precisione
- Coinvolgere équipe, autorità o servizi competenti secondo le procedure previste

Conoscenze

- Bioetica clinica, consenso informato, autodeterminazione e gestione dei dilemmi assistenziali
- Quadro normativo, procedure aziendali e responsabilità professionali pertinenti
- Criteri di proporzionalità, necessità, consenso/informazione e tutela dei diritti
- Requisiti documentali e di tracciabilità nelle situazioni a rilievo medico-legale

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica norme, procedure e criteri di base seguendo indicazioni definite nel bilanciare tutela, sicurezza, diritti e requisiti documentali; necessita di supervisione per valutare proporzionalità, documentazione o implicazioni etico-legali.
- **Principiante avanzato:** Riconosce i principali profili di tutela e rischio giuridico nei casi frequenti; richiede confronto quando la situazione presenta conflitti di diritti, rischio elevato o forte pressione emotiva.

- **Competente:** Gestisce in autonomia i casi ordinari, documenta in modo accurato motivazioni e rivalutazioni e coinvolge i soggetti competenti secondo procedura.
- **Abile:** Bilancia in modo maturo sicurezza, diritti, contesto e conseguenze organizzative; anticipa criticità documentali/legali e sostiene il team nelle decisioni complesse.
- **Esperto:** È punto di riferimento per la lettura etico-legale del caso, promuove scelte proporzionate e contribuisce a procedure, audit e cultura della tutela nel servizio.

Leadership e sviluppo dell'équipe

LEAD1 — Promuovere il cambiamento sostenendo i membri dell'équipe

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Leadership e sviluppo dell'équipe

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di promuovere il cambiamento sostenendo i membri dell'équipe nell'ambito di leadership e sviluppo dell'équipe. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di promuovere il cambiamento sostenendo i membri dell'équipe
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- Leadership clinica, feedback, change management e sviluppo del gruppo di lavoro
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

LEAD2 — Assumersi la responsabilità della pianificazione assistenziale nel modello organizzativo adottato

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Leadership e sviluppo dell'équipe

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di assumersi la responsabilità della pianificazione assistenziale nel modello organizzativo adottato nell'ambito di leadership e sviluppo dell'équipe. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di assumersi la responsabilità della pianificazione assistenziale nel modello organizzativo adottato
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi
- Monitorare esiti di processo e correggere tempestivamente scostamenti o criticità

Conoscenze

- Leadership clinica, feedback, change management e sviluppo del gruppo di lavoro
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

LEAD3 — Contribuire all'identificazione di criticità nel modello assistenziale

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Leadership e sviluppo dell'équipe

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di contribuire all'identificazione di criticità nel modello assistenziale nell'ambito di leadership e sviluppo dell'équipe. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di contribuire all'identificazione di criticità nel modello assistenziale
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi
- Monitorare esiti di processo e correggere tempestivamente scostamenti o criticità

Conoscenze

- Leadership clinica, feedback, change management e sviluppo del gruppo di lavoro
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.

- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

LEAD4 — Riconoscere le necessità dei colleghi attuando strategie di supporto

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Leadership e sviluppo dell'équipe

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere le necessità dei colleghi attuando strategie di supporto nell'ambito di leadership e sviluppo dell'équipe. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere le necessità dei colleghi attuando strategie di supporto
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- Leadership clinica, feedback, change management e sviluppo del gruppo di lavoro
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

LEAD5 — Riconoscere l'identità professionale come risorsa per la professione infermieristica

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Leadership e sviluppo dell'équipe

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere l'identità professionale come risorsa per la professione infermieristica nell'ambito di leadership e sviluppo dell'équipe. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere l'identità professionale come risorsa per la professione infermieristica
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi
- Monitorare esiti di processo e correggere tempestivamente scostamenti o criticità

Conoscenze

- Leadership clinica, feedback, change management e sviluppo del gruppo di lavoro
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

LEAD6 — Fornire feedback costruttivi sull'operato dei colleghi

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Leadership e sviluppo dell'équipe

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di fornire feedback costruttivi sull'operato dei colleghi nell'ambito di leadership e sviluppo dell'équipe. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di fornire feedback costruttivi sull'operato dei colleghi
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- Leadership clinica, feedback, change management e sviluppo del gruppo di lavoro
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

Pianificazione e presa in carico

PLA1 — Delegare e attribuire attività garantendo sicurezza assistenziale

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Pianificazione e presa in carico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di delegare e attribuire attività garantendo sicurezza assistenziale nell'ambito di pianificazione e presa in carico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di delegare e attribuire attività garantendo sicurezza assistenziale
- Garantire sicurezza assistenziale
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Processo di assistenza infermieristica, modelli funzionali e outcome sensibili all'assistenza
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.

- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PLA2 — Pianificare e ridefinire le priorità in base all'evoluzione clinica

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Pianificazione e presa in carico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di pianificare e ridefinire le priorità in base all'evoluzione clinica nell'ambito di pianificazione e presa in carico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Capacità di decidere rapidamente senza perdere metodo e rivalutazione critica
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Allocare con giustizia clinica tempi e risorse in base a gravità e rischio evolutivo
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di pianificare e ridefinire le priorità in base all'evoluzione clinica
- Classificare, rivalutare e ridefinire la priorità sulla base dell'evoluzione clinica
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Discriminatori di triage, red flags, percorsi tempo-dipendenti e principi di rivalutazione
- Processo di assistenza infermieristica, modelli funzionali e outcome sensibili all'assistenza
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PLA3 — Promuovere momenti di confronto con l'équipe su casi assistenziali

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Pianificazione e presa in carico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di promuovere momenti di confronto con l'équipe su casi assistenziali nell'ambito di pianificazione e presa in carico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di promuovere momenti di confronto con l'équipe su casi assistenziali
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- Processo di assistenza infermieristica, modelli funzionali e outcome sensibili all'assistenza
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PLA4 — Pianificare l'assistenza considerando le risorse disponibili

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Pianificazione e presa in carico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di pianificare l'assistenza considerando le risorse disponibili nell'ambito di pianificazione e presa in carico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di pianificare l'assistenza considerando le risorse disponibili
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi
- Monitorare esiti di processo e correggere tempestivamente scostamenti o criticità

Conoscenze

- Processo di assistenza infermieristica, modelli funzionali e outcome sensibili all'assistenza
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.

- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PLA5 — Coordinare il percorso di transitional care garantendo continuità assistenziale

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Pianificazione e presa in carico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di coordinare il percorso di transitional care garantendo continuità assistenziale nell'ambito di pianificazione e presa in carico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali. Il valore della competenza emerge nei momenti di transizione, quando il rischio di perdita di informazioni e di disallineamento terapeutico aumenta.

Attitudini

- Attenzione agli snodi di passaggio in cui si concentrano errori, omissioni e frammentazioni
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Garantire che il trasferimento tra setting non interrompa sicurezza, comprensione e continuità del piano di cura
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di coordinare il percorso di transitional care garantendo continuità assistenziale
- Garantire continuità assistenziale
- Mappare criticità di dimissione, bisogni clinico-sociali e referenti territoriali da attivare
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce

Conoscenze

- Farmaci ad alto rischio in dimissione, continuità dei follow-up, criteri di rischio di rientro ospedaliero
- Processo di assistenza infermieristica, modelli funzionali e outcome sensibili all'assistenza
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PLA6 — Individuare esiti sensibili all'assistenza pianificando rivalutazioni e monitorandone il raggiungimento

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Pianificazione e presa in carico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di individuare esiti sensibili all'assistenza pianificando rivalutazioni e monitorandone il raggiungimento nell'ambito di pianificazione e presa in carico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di individuare esiti sensibili all'assistenza pianificando rivalutazioni e monitorandone il raggiungimento
- Pianificare rivalutazioni e monitorandone il raggiungimento
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Processo di assistenza infermieristica, modelli funzionali e outcome sensibili all'assistenza
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PLA7 — Adattare l'assistenza infermieristica alle esigenze dell'assistito

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Pianificazione e presa in carico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di adattare l'assistenza infermieristica alle esigenze dell'assistito nell'ambito di pianificazione e presa in carico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di adattare l'assistenza infermieristica alle esigenze dell'assistito
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi
- Monitorare esiti di processo e correggere tempestivamente scostamenti o criticità

Conoscenze

- Processo di assistenza infermieristica, modelli funzionali e outcome sensibili all'assistenza
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.

- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PLA8 — Supportare l'assistito nell'adattamento alla malattia suggerendo strategie di coping

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Pianificazione e presa in carico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di supportare l'assistito nell'adattamento alla malattia suggerendo strategie di coping nell'ambito di pianificazione e presa in carico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Finezza nel cogliere segnali di paura, evitamento o sopraffazione emotiva
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Ridurre il carico di sofferenza emotiva che può interferire con collaborazione e recupero
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di supportare l'assistito nell'adattamento alla malattia suggerendo strategie di coping
- Utilizzare tecniche di supporto, rassicurazione realistica e orientamento al percorso
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Ansia perioperatoria, fattori che aumentano stress e strategie non farmacologiche di contenimento
- Processo di assistenza infermieristica, modelli funzionali e outcome sensibili all'assistenza
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PLA9 — Analizzare lo stato di salute dell'assistito utilizzando modelli funzionali

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Pianificazione e presa in carico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di analizzare lo stato di salute dell'assistito utilizzando modelli funzionali nell'ambito di pianificazione e presa in carico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di analizzare lo stato di salute dell'assistito utilizzando modelli funzionali
- Utilizzare modelli funzionali
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Processo di assistenza infermieristica, modelli funzionali e outcome sensibili all'assistenza
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.

- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PLA10 — Analizzare lo stato di salute dei caregiver utilizzando modelli funzionali

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Pianificazione e presa in carico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di analizzare lo stato di salute dei caregiver utilizzando modelli funzionali nell'ambito di pianificazione e presa in carico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Orientamento a valorizzare risorse, priorità e tempi di apprendimento della persona
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Favorire autonomia sostenibile e ridurre dipendenza evitabile dal sistema sanitario
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di analizzare lo stato di salute dei caregiver utilizzando modelli funzionali
- Utilizzare modelli funzionali
- Strutturare messaggi prioritari, rinforzi educativi e verifica del ritorno informativo
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce

Conoscenze

- Health literacy, teach-back, aderenza terapeutica e strategie di rinforzo dell'autogestione
- Processo di assistenza infermieristica, modelli funzionali e outcome sensibili all'assistenza
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nella personalizzazione dei messaggi, nella verifica della comprensione e nel sostegno all'autonomia; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PLA11 — Richiedere consulenze specialistiche quando necessario

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Pianificazione e presa in carico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di richiedere consulenze specialistiche quando necessario nell'ambito di pianificazione e presa in carico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di richiedere consulenze specialistiche quando necessario
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi
- Monitorare esiti di processo e correggere tempestivamente scostamenti o criticità

Conoscenze

- Processo di assistenza infermieristica, modelli funzionali e outcome sensibili all'assistenza
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.

- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PLA12 — Utilizzare strumenti di valutazione condividendo i risultati con l'équipe

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Pianificazione e presa in carico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di utilizzare strumenti di valutazione condividendo i risultati con l'équipe nell'ambito di pianificazione e presa in carico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di utilizzare strumenti di valutazione condividendo i risultati con l'équipe
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- Processo di assistenza infermieristica, modelli funzionali e outcome sensibili all'assistenza
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.

- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PLA13 — Redigere documentazione assistenziale puntuale e accurata

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Pianificazione e presa in carico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di redigere documentazione assistenziale puntuale e accurata nell'ambito di pianificazione e presa in carico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di redigere documentazione assistenziale puntuale e accurata
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi
- Monitorare esiti di processo e correggere tempestivamente scostamenti o criticità

Conoscenze

- Processo di assistenza infermieristica, modelli funzionali e outcome sensibili all'assistenza
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.

- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

Sicurezza e gestione del rischio

SIC1 — Adottare comportamenti professionali prudenti e appropriati

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Sicurezza e gestione del rischio

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di adottare comportamenti professionali prudenti e appropriati nell'ambito di sicurezza e gestione del rischio. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di adottare comportamenti professionali prudenti e appropriati
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi
- Monitorare esiti di processo e correggere tempestivamente scostamenti o criticità

Conoscenze

- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.

- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

SIC2 — Riconoscere precocemente situazioni critiche attivando i sistemi di emergenza intraospedaliera e fornendo supporto vitale di base

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Sicurezza e gestione del rischio

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere precocemente situazioni critiche attivando i sistemi di emergenza intraospedaliera e fornendo supporto vitale di base nell'ambito di sicurezza e gestione del rischio. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere precocemente situazioni critiche attivando i sistemi di emergenza intraospedaliera e fornendo supporto vitale di base
- Attivare i sistemi di emergenza intraospedaliera e fornendo supporto vitale di base
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.

- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

SIC3 — Garantire il corretto funzionamento delle attrezzature applicando protocolli di sicurezza

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Sicurezza e gestione del rischio

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di garantire il corretto funzionamento delle attrezzature applicando protocolli di sicurezza nell'ambito di sicurezza e gestione del rischio. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di garantire il corretto funzionamento delle attrezzature applicando protocolli di sicurezza
- Applicare protocolli di sicurezza
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.

- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

SIC4 — Utilizzare le tecnologie informatiche come strumenti di lavoro

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Sicurezza e gestione del rischio

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di utilizzare le tecnologie informatiche come strumenti di lavoro nell'ambito di sicurezza e gestione del rischio. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di utilizzare le tecnologie informatiche come strumenti di lavoro
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi
- Monitorare esiti di processo e correggere tempestivamente scostamenti o criticità

Conoscenze

- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.

- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

Sviluppo professionale e benessere

SV11 — Attivarsi per il mantenimento e miglioramento delle competenze professionali

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Sviluppo professionale e benessere

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di attivarsi per il mantenimento e miglioramento delle competenze professionali nell'ambito di sviluppo professionale e benessere. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di attivarsi per il mantenimento e miglioramento delle competenze professionali
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi
- Monitorare esiti di processo e correggere tempestivamente scostamenti o criticità

Conoscenze

- Sviluppo continuo professionale, burnout, coping e qualità percepita dei servizi
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

SVI2 — Identificare i determinanti della qualità percepita adottando comportamenti congruenti

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Sviluppo professionale e benessere

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di identificare i determinanti della qualità percepita adottando comportamenti congruenti nell'ambito di sviluppo professionale e benessere. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di identificare i determinanti della qualità percepita adottando comportamenti congruenti
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi
- Monitorare esiti di processo e correggere tempestivamente scostamenti o criticità

Conoscenze

- Sviluppo continuo professionale, burnout, coping e qualità percepita dei servizi
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

SVI3 — Condividere competenze con l'équipe favorendo miglioramento continuo

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Sviluppo professionale e benessere

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di condividere competenze con l'équipe favorendo miglioramento continuo nell'ambito di sviluppo professionale e benessere. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di condividere competenze con l'équipe favorendo miglioramento continuo
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- Sviluppo continuo professionale, burnout, coping e qualità percepita dei servizi
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

SVI4 — Adottare strategie per gestire situazioni stressanti e l'emozione professionale

Area/Pannello: Trasversali / Dimensione: Sviluppo professionale e benessere

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di adottare strategie per gestire situazioni stressanti e l'emozione professionale nell'ambito di sviluppo professionale e benessere. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di trasversali.

Attitudini

- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo
- Attenzione alla continuità delle informazioni e alla chiarezza dei ruoli

Motivazioni

- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale
- Promuovere coerenza tra bisogni della persona, risorse disponibili e decisioni del team

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di adottare strategie per gestire situazioni stressanti e l'emozione professionale
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi
- Monitorare esiti di processo e correggere tempestivamente scostamenti o criticità

Conoscenze

- Sviluppo continuo professionale, burnout, coping e qualità percepita dei servizi
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.

- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

Competenze di Area del Territorio e della Prevenzione

Transitional care e continuità assistenziale

TRC1 — Garantire la continuità assistenziale ospedale-territorio coordinando il piano di cura multiprofessionale con MMG, PLS e servizi socio-assistenziali

Area/Pannello: Territorio e Prevenzione / Dimensione: Transitional care e continuità assistenziale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di garantire la continuità assistenziale ospedale-territorio coordinando il piano di cura multiprofessionale con MMG, PLS e servizi socio-assistenziali nell'ambito di transitional care e continuità assistenziale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di territorio e Prevenzione. Il valore della competenza emerge nei momenti di transizione, quando il rischio di perdita di informazioni e di disallineamento terapeutico aumenta.

Attitudini

- Attenzione agli snodi di passaggio in cui si concentrano errori, omissioni e frammentazioni
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Garantire che il trasferimento tra setting non interrompa sicurezza, comprensione e continuità del piano di cura
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di garantire la continuità assistenziale ospedale-territorio coordinando il piano di cura multiprofessionale con MMG, PLS e servizi socio-assistenziali
- Coordinare il piano di cura multiprofessionale con MMG, PLS e servizi socio-assistenziali
- Mappare criticità di dimissione, bisogni clinico-sociali e referenti territoriali da attivare
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce

Conoscenze

- Farmaci ad alto rischio in dimissione, continuità dei follow-up, criteri di rischio di rientro ospedaliero

- Transitional care, riconciliazione terapeutica, rischio di riospedalizzazione e handover intersetting
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

TRC2 — Eseguire stratificazione del rischio di riospedalizzazione e pianificare follow-up proattivi integrando bisogni clinici e sociali

Area/Pannello: Territorio e Prevenzione / Dimensione: Transitional care e continuità assistenziale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di eseguire stratificazione del rischio di riospedalizzazione e pianificare follow-up proattivi integrando bisogni clinici e sociali nell'ambito di transitional care e continuità assistenziale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di territorio e Prevenzione. Il valore della competenza emerge nei momenti di transizione, quando il rischio di perdita di informazioni e di disallineamento terapeutico aumenta.

Attitudini

- Attenzione agli snodi di passaggio in cui si concentrano errori, omissioni e frammentazioni
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Garantire che il trasferimento tra setting non interrompa sicurezza, comprensione e continuità del piano di cura
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di eseguire stratificazione del rischio di riospedalizzazione e pianificare follow-up proattivi integrando bisogni clinici e sociali
- Integrare bisogni clinici e sociali
- Mappare criticità di dimissione, bisogni clinico-sociali e referenti territoriali da attivare
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce

Conoscenze

- Farmaci ad alto rischio in dimissione, continuità dei follow-up, criteri di rischio di rientro ospedaliero
- Transitional care, riconciliazione terapeutica, rischio di riospedalizzazione e handover intersetting
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

TRC3 — Condurre riconciliazione terapeutica alla dimissione identificando discrepanze farmacologiche e attivando azioni correttive con i professionisti coinvolti

Area/Pannello: Territorio e Prevenzione / Dimensione: Transitional care e continuità assistenziale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di condurre riconciliazione terapeutica alla dimissione identificando discrepanze farmacologiche e attivando azioni correttive con i professionisti coinvolti nell'ambito di transitional care e continuità assistenziale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di territorio e Prevenzione. Il valore della competenza emerge nei momenti di transizione, quando il rischio di perdita di informazioni e di disallineamento terapeutico aumenta.

Attitudini

- Attenzione agli snodi di passaggio in cui si concentrano errori, omissioni e frammentazioni
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Garantire che il trasferimento tra setting non interrompa sicurezza, comprensione e continuità del piano di cura
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di condurre riconciliazione terapeutica alla dimissione identificando discrepanze farmacologiche e attivando azioni correttive con i professionisti coinvolti
- Identificare discrepanze farmacologiche
- Attivare azioni correttive con i professionisti coinvolti
- Mappare criticità di dimissione, bisogni clinico-sociali e referenti territoriali da attivare

Conoscenze

- Farmaci ad alto rischio in dimissione, continuità dei follow-up, criteri di rischio di rientro ospedaliero
- Transitional care, riconciliazione terapeutica, rischio di riospedalizzazione e handover intersetting
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nella corretta gestione del trattamento, nella prevenzione del rischio e nel monitoraggio della risposta; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

TRC4 — Progettare e valutare percorsi di transitional care definendo indicatori di esito e di processo e implementando azioni di miglioramento continuo

Area/Pannello: Territorio e Prevenzione / Dimensione: Transitional care e continuità assistenziale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di progettare e valutare percorsi di transitional care definendo indicatori di esito e di processo e implementando azioni di miglioramento continuo nell'ambito di transitional care e continuità assistenziale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di territorio e Prevenzione. Il valore della competenza emerge nei momenti di transizione, quando il rischio di perdita di informazioni e di disallineamento terapeutico aumenta.

Attitudini

- Attenzione agli snodi di passaggio in cui si concentrano errori, omissioni e frammentazioni
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Garantire che il trasferimento tra setting non interrompa sicurezza, comprensione e continuità del piano di cura
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di progettare e valutare percorsi di transitional care definendo indicatori di esito e di processo e implementando azioni di miglioramento continuo
- Definire indicatori di esito e di processo
- Implementare azioni di miglioramento continuo
- Mappare criticità di dimissione, bisogni clinico-sociali e referenti territoriali da attivare

Conoscenze

- Farmaci ad alto rischio in dimissione, continuità dei follow-up, criteri di rischio di rientro ospedaliero
- Transitional care, riconciliazione terapeutica, rischio di riospedalizzazione e handover intersetting
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

Prevenzione e tutela della salute

PRV1 — Gestire programmi di prevenzione e intercettare precocemente situazioni di vulnerabilità e trascuratezza attivando interventi di tutela

Area/Pannello: Territorio e Prevenzione / Dimensione: Prevenzione e tutela della salute

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire programmi di prevenzione e intercettare precocemente situazioni di vulnerabilità e trascuratezza attivando interventi di tutela nell'ambito di prevenzione e tutela della salute. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di territorio e Prevenzione.

Attitudini

- Sguardo allargato ai determinanti sociali e ambientali della salute
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Intercettare precocemente fragilità che tendono a restare invisibili ai servizi
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire programmi di prevenzione e intercettare precocemente situazioni di vulnerabilità e trascuratezza attivando interventi di tutela
- Attivare interventi di tutela
- Leggere dati di popolazione e segnali di vulnerabilità per orientare interventi mirati
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce

Conoscenze

- Epidemiologia di comunità, indicatori di vulnerabilità, reti territoriali e meccanismi di tutela
- Determinanti sociali di salute, epidemiologia di comunità e mappatura di rischio/risorse
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PRV2 — Analizzare bisogni di salute della comunità utilizzando dati epidemiologici e determinanti sociali per orientare interventi di prevenzione mirati

Area/Pannello: Territorio e Prevenzione / Dimensione: Prevenzione e tutela della salute

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di analizzare bisogni di salute della comunità utilizzando dati epidemiologici e determinanti sociali per orientare interventi di prevenzione mirati nell'ambito di prevenzione e tutela della salute. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di territorio e Prevenzione.

Attitudini

- Sguardo allargato ai determinanti sociali e ambientali della salute
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Intercettare precocemente fragilità che tendono a restare invisibili ai servizi
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di analizzare bisogni di salute della comunità utilizzando dati epidemiologici e determinanti sociali per orientare interventi di prevenzione mirati
- Utilizzare dati epidemiologici e determinanti sociali per orientare interventi di prevenzione mirati
- Leggere dati di popolazione e segnali di vulnerabilità per orientare interventi mirati
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce

Conoscenze

- Epidemiologia di comunità, indicatori di vulnerabilità, reti territoriali e meccanismi di tutela
- Determinanti sociali di salute, epidemiologia di comunità e mappatura di rischio/risorse
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nell'uso rigoroso delle evidenze, dei protocolli e della documentazione; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PRV3 — Monitorare stabilità clinica e aderenza terapeutica con valutazioni strutturate identificando precocemente alterazioni e attivando interventi integrati di rete

Area/Pannello: Territorio e Prevenzione / Dimensione: Prevenzione e tutela della salute

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare stabilità clinica e aderenza terapeutica con valutazioni strutturate identificando precocemente alterazioni e attivando interventi integrati di rete nell'ambito di prevenzione e tutela della salute. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di territorio e Prevenzione.

Attitudini

- Orientamento a valorizzare risorse, priorità e tempi di apprendimento della persona
- Orientamento alle potenzialità della persona e del contesto di vita
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative

Motivazioni

- Favorire autonomia sostenibile e ridurre dipendenza evitabile dal sistema sanitario
- Spostare il focus dal solo contenimento del sintomo alla partecipazione e alla cittadinanza possibile
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare stabilità clinica e aderenza terapeutica con valutazioni strutturate identificando precocemente alterazioni e attivando interventi integrati di rete
- Identificare precocemente alterazioni
- Attivare interventi integrati di rete
- Strutturare messaggi prioritari, rinforzi educativi e verifica del ritorno informativo

Conoscenze

- Health literacy, teach-back, aderenza terapeutica e strategie di rinforzo dell'autogestione
- Recovery, riabilitazione psicosociale, gruppi terapeutici, rete formale/informale e prevenzione ricadute
- Determinanti sociali di salute, epidemiologia di comunità e mappatura di rischio/risorse
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PRV4 — Valutare contesto comunitario e ambientale mappando fattori di rischio risorse e barriere di accesso per facilitare presa in carico e prevenzione

Area/Pannello: Territorio e Prevenzione / Dimensione: Prevenzione e tutela della salute

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare contesto comunitario e ambientale mappando fattori di rischio risorse e barriere di accesso per facilitare presa in carico e prevenzione nell'ambito di prevenzione e tutela della salute. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di territorio e Prevenzione.

Attitudini

- Sguardo allargato ai determinanti sociali e ambientali della salute
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Intercettare precocemente fragilità che tendono a restare invisibili ai servizi
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare contesto comunitario e ambientale mappando fattori di rischio risorse e barriere di accesso per facilitare presa in carico e prevenzione
- Leggere dati di popolazione e segnali di vulnerabilità per orientare interventi mirati
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Epidemiologia di comunità, indicatori di vulnerabilità, reti territoriali e meccanismi di tutela
- Determinanti sociali di salute, epidemiologia di comunità e mappatura di rischio/risorse
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

Teleassistenza e sistemi informativi

TEL1 — Implementare percorsi di teleassistenza e telemonitoraggio definendo criteri di eleggibilità protocolli operativi e requisiti di sicurezza dei dati

Area/Pannello: Territorio e Prevenzione / Dimensione: Teleassistenza e sistemi informativi

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di implementare percorsi di teleassistenza e telemonitoraggio definendo criteri di eleggibilità protocolli operativi e requisiti di sicurezza dei dati nell'ambito di teleassistenza e sistemi informativi. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni poco fondate, perdita di qualità dei dati e ridotta trasferibilità delle evidenze. La sua corretta espressione produce aggiornamento della pratica, innovazione controllata e miglioramento guidato da dati e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di territorio e Prevenzione.

Attitudini

- Affidabilità nella lettura dei dati a distanza e nella gestione delle soglie di allarme
- Rigore documentale e rispetto stretto del protocollo di studio
- Curiosità scientifica e disponibilità a mettere in discussione routine consolidate

Motivazioni

- Usare il digitale per aumentare accessibilità, continuità e tempestività e non per moltiplicare passaggi inutili
- Garantire integrità dei dati e sicurezza del partecipante lungo tutto il trial
- Migliorare la pratica assistenziale attraverso decisioni informate da prove affidabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di implementare percorsi di teleassistenza e telemonitoraggio definendo criteri di eleggibilità protocolli operativi e requisiti di sicurezza dei dati
- Definire criteri di eleggibilità protocolli operativi e requisiti di sicurezza dei dati
- Gestire alert, trend, contatti programmati e documentazione interoperabile
- Applicare criteri di eleggibilità, visit schedule, raccolta dati e reporting delle deviazioni/eventi

Conoscenze

- Criteri di eleggibilità, data governance, allarmi clinici e limiti del monitoraggio remoto
- ICH-GCP, informed consent in ricerca, AE/SAE reporting, CRF e accountability del farmaco di studio
- Criteri di eleggibilità ai percorsi di telemedicina, alerting, interoperabilità e protezione dei dati
- Principi di metodologia della ricerca, gerarchia delle evidenze e critical appraisal
- Indicatori clinici, esiti sensibili all'assistenza e principi base di audit

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Usa strumenti, procedure o fonti secondo istruzioni definite nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; necessita di supervisione per valutare qualità metodologica, coerenza documentale o implicazioni dei dati.
- **Principiante avanzato:** Ricerca e utilizza fonti/protocolli con discreta autonomia nei casi più frequenti; riconosce criticità comuni ma richiede confronto per analisi e decisioni più complesse.
- **Competente:** Gestisce in autonomia attività ordinarie di ricerca/EBP/documentazione, garantisce accuratezza dei dati e trasferisce risultati rilevanti alla pratica clinica.
- **Abile:** Interpreta criticamente dati ed evidenze, individua limiti/applicabilità e orienta miglioramenti clinico-organizzativi fondati su prove e indicatori.
- **Esperto:** Agisce come riferimento metodologico locale: sostiene colleghi, anticipa criticità di qualità del dato/protocollo e contribuisce allo sviluppo di pratiche innovative e rigorose.

TEL2 — Interpretare trend e alert dei dati di telemonitoraggio integrandoli con valutazione clinica e attivando escalation assistenziale secondo protocolli

Area/Pannello: Territorio e Prevenzione / Dimensione: Teleassistenza e sistemi informativi

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di interpretare trend e alert dei dati di telemonitoraggio integrandoli con valutazione clinica e attivando escalation assistenziale secondo protocolli nell'ambito di teleassistenza e sistemi informativi. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni poco fondate, perdita di qualità dei dati e ridotta trasferibilità delle evidenze. La sua corretta espressione produce aggiornamento della pratica, innovazione controllata e miglioramento guidato da dati e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di territorio e Prevenzione.

Attitudini

- Affidabilità nella lettura dei dati a distanza e nella gestione delle soglie di allarme
- Curiosità scientifica e disponibilità a mettere in discussione routine consolidate
- Rigore nel trattamento dei dati, nella verifica delle fonti e nella documentazione

Motivazioni

- Usare il digitale per aumentare accessibilità, continuità e tempestività e non per moltiplicare passaggi inutili
- Migliorare la pratica assistenziale attraverso decisioni informate da prove affidabili
- Sostenere innovazione e qualità senza separare ricerca e assistenza

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di interpretare trend e alert dei dati di telemonitoraggio integrandoli con valutazione clinica e attivando escalation assistenziale secondo protocolli
- Attivare escalation assistenziale secondo protocolli
- Gestire alert, trend, contatti programmati e documentazione interoperabile
- Ricercare, selezionare e utilizzare fonti affidabili in modo sistematico

Conoscenze

- Criteri di eleggibilità, data governance, allarmi clinici e limiti del monitoraggio remoto
- Criteri di eleggibilità ai percorsi di telemedicina, alerting, interoperabilità e protezione dei dati
- Principi di metodologia della ricerca, gerarchia delle evidenze e critical appraisal
- Indicatori clinici, esiti sensibili all'assistenza e principi base di audit
- Norme etiche, privacy e requisiti documentali della ricerca clinica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Usa strumenti, procedure o fonti secondo istruzioni definite nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; necessita di supervisione per valutare qualità metodologica, coerenza documentale o implicazioni dei dati.

- **Principiante avanzato:** Ricerca e utilizza fonti/protocolli con discreta autonomia nei casi più frequenti; riconosce criticità comuni ma richiede confronto per analisi e decisioni più complesse.
- **Competente:** Gestisce in autonomia attività ordinarie di ricerca/EBP/documentazione, garantisce accuratezza dei dati e trasferisce risultati rilevanti alla pratica clinica.
- **Abile:** Interpreta criticamente dati ed evidenze, individua limiti/applicabilità e orienta miglioramenti clinico-organizzativi fondati su prove e indicatori.
- **Esperto:** Agisce come riferimento metodologico locale: sostiene colleghi, anticipa criticità di qualità del dato/protocollo e contribuisce allo sviluppo di pratiche innovative e rigorose.

TEL3 — Valutare efficacia appropriatezza e costo-efficacia degli interventi di telemedicina attraverso audit clinici e indicatori di outcome

Area/Pannello: Territorio e Prevenzione / Dimensione: Teleassistenza e sistemi informativi

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare efficacia appropriatezza e costo-efficacia degli interventi di telemedicina attraverso audit clinici e indicatori di outcome nell'ambito di teleassistenza e sistemi informativi. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni poco fondate, perdita di qualità dei dati e ridotta trasferibilità delle evidenze. La sua corretta espressione produce aggiornamento della pratica, innovazione controllata e miglioramento guidato da dati e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di territorio e Prevenzione.

Attitudini

- Affidabilità nella lettura dei dati a distanza e nella gestione delle soglie di allarme
- Curiosità scientifica e disponibilità a mettere in discussione routine consolidate
- Rigore nel trattamento dei dati, nella verifica delle fonti e nella documentazione

Motivazioni

- Usare il digitale per aumentare accessibilità, continuità e tempestività e non per moltiplicare passaggi inutili
- Migliorare la pratica assistenziale attraverso decisioni informate da prove affidabili
- Sostenere innovazione e qualità senza separare ricerca e assistenza

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare efficacia appropriatezza e costo-efficacia degli interventi di telemedicina attraverso audit clinici e indicatori di outcome
- Gestire alert, trend, contatti programmati e documentazione interoperabile
- Ricercare, selezionare e utilizzare fonti affidabili in modo sistematico
- Applicare protocolli e procedure di raccolta dati con accuratezza e tracciabilità

Conoscenze

- Criteri di eleggibilità, data governance, allarmi clinici e limiti del monitoraggio remoto
- Criteri di eleggibilità ai percorsi di telemedicina, alerting, interoperabilità e protezione dei dati
- Principi di metodologia della ricerca, gerarchia delle evidenze e critical appraisal
- Indicatori clinici, esiti sensibili all'assistenza e principi base di audit
- Norme etiche, privacy e requisiti documentali della ricerca clinica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Usa strumenti, procedure o fonti secondo istruzioni definite nel collegare evidenze, dati e decisioni assistenziali; necessita di supervisione per valutare qualità metodologica, coerenza documentale o implicazioni dei dati.
- **Principiante avanzato:** Ricerca e utilizza fonti/protocolli con discreta autonomia nei casi più frequenti; riconosce criticità comuni ma richiede confronto per analisi e decisioni più complesse.
- **Competente:** Gestisce in autonomia attività ordinarie di ricerca/EBP/documentazione, garantisce accuratezza dei dati e trasferisce risultati rilevanti alla pratica clinica.
- **Abile:** Interpreta criticamente dati ed evidenze, individua limiti/applicabilità e orienta miglioramenti clinico-organizzativi fondati su prove e indicatori.
- **Esperto:** Agisce come riferimento metodologico locale: sostiene colleghi, anticipa criticità di qualità del dato/protocollo e contribuisce allo sviluppo di pratiche innovative e rigorose.

TEL4 — Governare la documentazione digitale e l'interoperabilità informativa garantendo tracciabilità continuità dei dati e conformità normativa

Area/Pannello: Territorio e Prevenzione / Dimensione: Teleassistenza e sistemi informativi

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di governare la documentazione digitale e l'interoperabilità informativa garantendo tracciabilità continuità dei dati e conformità normativa nell'ambito di teleassistenza e sistemi informativi. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni poco fondate, perdita di qualità dei dati e ridotta trasferibilità delle evidenze. La sua corretta espressione produce aggiornamento della pratica, innovazione controllata e miglioramento guidato da dati e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di territorio e Prevenzione.

Attitudini

- Affidabilità nella lettura dei dati a distanza e nella gestione delle soglie di allarme
- Curiosità scientifica e disponibilità a mettere in discussione routine consolidate
- Rigore nel trattamento dei dati, nella verifica delle fonti e nella documentazione

Motivazioni

- Usare il digitale per aumentare accessibilità, continuità e tempestività e non per moltiplicare passaggi inutili
- Migliorare la pratica assistenziale attraverso decisioni informate da prove affidabili
- Sostenere innovazione e qualità senza separare ricerca e assistenza

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di governare la documentazione digitale e l'interoperabilità informativa garantendo tracciabilità continuità dei dati e conformità normativa
- Garantire tracciabilità continuità dei dati e conformità normativa
- Gestire alert, trend, contatti programmati e documentazione interoperabile
- Ricercare, selezionare e utilizzare fonti affidabili in modo sistematico

Conoscenze

- Criteri di eleggibilità, data governance, allarmi clinici e limiti del monitoraggio remoto
- Criteri di eleggibilità ai percorsi di telemedicina, alerting, interoperabilità e protezione dei dati
- Principi di metodologia della ricerca, gerarchia delle evidenze e critical appraisal
- Indicatori clinici, esiti sensibili all'assistenza e principi base di audit
- Norme etiche, privacy e requisiti documentali della ricerca clinica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Usa strumenti, procedure o fonti secondo istruzioni definite nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; necessita di supervisione per valutare qualità metodologica, coerenza documentale o implicazioni dei dati.

- **Principiante avanzato:** Ricerca e utilizza fonti/protocolli con discreta autonomia nei casi più frequenti; riconosce criticità comuni ma richiede confronto per analisi e decisioni più complesse.
- **Competente:** Gestisce in autonomia attività ordinarie di ricerca/EBP/documentazione, garantisce accuratezza dei dati e trasferisce risultati rilevanti alla pratica clinica.
- **Abile:** Interpreta criticamente dati ed evidenze, individua limiti/applicabilità e orienta miglioramenti clinico-organizzativi fondati su prove e indicatori.
- **Esperto:** Agisce come riferimento metodologico locale: sostiene colleghi, anticipa criticità di qualità del dato/protocollo e contribuisce allo sviluppo di pratiche innovative e rigorose.

Competenze di Area Chirurgica

Gestione perioperatoria avanzata

PER1 — Gestire in modo proattivo e integrato il percorso perioperatorio coordinando il team multidisciplinare e garantendo standard elevati di qualità assistenziale

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Gestione perioperatoria avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire in modo proattivo e integrato il percorso perioperatorio coordinando il team multidisciplinare e garantendo standard elevati di qualità assistenziale nell'ambito di gestione perioperatoria avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Visione longitudinale del percorso chirurgico e dei momenti a maggior rischio

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Rendere il percorso operatorio prevedibile, sicuro e leggibile per assistito e caregiver
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire in modo proattivo e integrato il percorso perioperatorio coordinando il team multidisciplinare e garantendo standard elevati di qualità assistenziale
- Coordinare il team multidisciplinare
- Garantire standard elevati di qualità assistenziale
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- Fasi del percorso chirurgico, ERAS, preparazione preoperatoria e complicanze postoperatorie frequenti
- Percorsi ERAS, stratificazione del rischio perioperatorio, preparazione chirurgica e recovery

- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PER2 — Eseguire valutazione preoperatoria avanzata integrando stratificazione del rischio comorbidità riconciliazione farmacologica e preparazione chirurgica secondo protocolli

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Gestione perioperatoria avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di eseguire valutazione preoperatoria avanzata integrando stratificazione del rischio comorbidità riconciliazione farmacologica e preparazione chirurgica secondo protocolli nell'ambito di gestione perioperatoria avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. La competenza connette preparazione, procedura e recupero, evitando che il percorso chirurgico sia frammentato in atti isolati.

Attitudini

- Visione longitudinale del percorso chirurgico e dei momenti a maggior rischio
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Rendere il percorso operatorio prevedibile, sicuro e leggibile per assistito e caregiver
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di eseguire valutazione preoperatoria avanzata integrando stratificazione del rischio comorbidità riconciliazione farmacologica e preparazione chirurgica secondo protocolli
- Integrare stratificazione del rischio comorbidità riconciliazione farmacologica e preparazione chirurgica secondo protocolli
- Integrare preparazione, monitoraggio, informazione e recovery in un piano coerente
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce

Conoscenze

- Fasi del percorso chirurgico, ERAS, preparazione preoperatoria e complicanze postoperatorie frequenti
- Percorsi ERAS, stratificazione del rischio perioperatorio, preparazione chirurgica e recovery
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nella corretta gestione del trattamento, nella prevenzione del rischio e nel monitoraggio della risposta; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PER3 — Gestire l'ansia preoperatoria dell'assistito e del caregiver applicando interventi strutturati di supporto psicologico

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Gestione perioperatoria avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire l'ansia preoperatoria dell'assistito e del caregiver applicando interventi strutturati di supporto psicologico nell'ambito di gestione perioperatoria avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. La competenza connette preparazione, procedura e recupero, evitando che il percorso chirurgico sia frammentato in atti isolati.

Attitudini

- Orientamento a valorizzare risorse, priorità e tempi di apprendimento della persona
- Visione longitudinale del percorso chirurgico e dei momenti a maggior rischio
- Finezza nel cogliere segnali di paura, evitamento o sopraffazione emotiva

Motivazioni

- Favorire autonomia sostenibile e ridurre dipendenza evitabile dal sistema sanitario
- Rendere il percorso operatorio prevedibile, sicuro e leggibile per assistito e caregiver
- Ridurre il carico di sofferenza emotiva che può interferire con collaborazione e recupero

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire l'ansia preoperatoria dell'assistito e del caregiver applicando interventi strutturati di supporto psicologico
- Applicare interventi strutturati di supporto psicologico
- Strutturare messaggi prioritari, rinforzi educativi e verifica del ritorno informativo
- Integrare preparazione, monitoraggio, informazione e recovery in un piano coerente

Conoscenze

- Health literacy, teach-back, aderenza terapeutica e strategie di rinforzo dell'autogestione
- Fasi del percorso chirurgico, ERAS, preparazione preoperatoria e complicanze postoperatorie frequenti
- Ansia perioperatoria, fattori che aumentano stress e strategie non farmacologiche di contenimento
- Percorsi ERAS, stratificazione del rischio perioperatorio, preparazione chirurgica e recovery
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nella personalizzazione dei messaggi, nella verifica della comprensione e nel sostegno all'autonomia; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PER4 — Definire e monitorare indicazioni dietetiche personalizzate pre e postoperatorie in relazione alla procedura e alla tecnica anestesiológica

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Gestione perioperatoria avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di definire e monitorare indicazioni dietetiche personalizzate pre e postoperatorie in relazione alla procedura e alla tecnica anestesiológica nell'ambito di gestione perioperatoria avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. La competenza connette preparazione, procedura e recupero, evitando che il percorso chirurgico sia frammentato in atti isolati.

Attitudini

- Sensibilità ai bisogni emotivi e informativi espressi o impliciti
- Capacità di mantenere coerenza tra contenuto, tono e postura professionale
- Visione longitudinale del percorso chirurgico e dei momenti a maggior rischio

Motivazioni

- Rendere comprensibile il percorso di cura e favorire scelte realmente consapevoli
- Rendere il percorso operatorio prevedibile, sicuro e leggibile per assistito e caregiver
- Preservare stato nutrizionale, crescita o recupero evitando complicanze da intake inadeguato

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di definire e monitorare indicazioni dietetiche personalizzate pre e postoperatorie in relazione alla procedura e alla tecnica anestesiológica
- Verificare comprensione, dubbi, consenso e necessità di rinforzo informativo
- Integrare preparazione, monitoraggio, informazione e recovery in un piano coerente
- Valutare tolleranza, introiti, pattern alimentare e necessità di adattamento del supporto nutrizionale

Conoscenze

- Principi di comunicazione efficace, decisione condivisa, consenso e adattamento del linguaggio
- Fasi del percorso chirurgico, ERAS, preparazione preoperatoria e complicanze postoperatorie frequenti
- Fabbisogni nutrizionali, controindicazioni, sicurezza dell'alimentazione enterale e segnali di intolleranza
- Percorsi ERAS, stratificazione del rischio perioperatorio, preparazione chirurgica e recovery
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PER5 — Gestire l'assistenza in chirurgia pediatrica adattando valutazione clinica comunicazione e gestione del dolore alle specificità evolutive

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Gestione perioperatoria avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire l'assistenza in chirurgia pediatrica adattando valutazione clinica comunicazione e gestione del dolore alle specificità evolutive nell'ambito di gestione perioperatoria avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. Il controllo del dolore incide direttamente su mobilitazione, partecipazione alle cure, stabilità fisiologica e qualità dell'esperienza assistenziale.

Attitudini

- Sensibilità ai bisogni emotivi e informativi espressi o impliciti
- Capacità di mantenere coerenza tra contenuto, tono e postura professionale
- Sensibilità a un dolore non sempre esplicitato ma clinicamente rilevante

Motivazioni

- Rendere comprensibile il percorso di cura e favorire scelte realmente consapevoli
- Trattare il dolore come esito clinico da monitorare e non come effetto collaterale inevitabile
- Prevenire errori di dosaggio e adattare la terapia alla vulnerabilità età-correlata

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire l'assistenza in chirurgia pediatrica adattando valutazione clinica comunicazione e gestione del dolore alle specificità evolutive
- Adattare valutazione clinica comunicazione e gestione del dolore alle specificità evolutive
- Verificare comprensione, dubbi, consenso e necessità di rinforzo informativo
- Utilizzare scale di valutazione del dolore, monitorare risposta analgesica e riconoscere effetti collaterali

Conoscenze

- Principi di comunicazione efficace, decisione condivisa, consenso e adattamento del linguaggio
- Fisiopatologia del dolore acuto, PCA, analgesia epidurale/peridurale e monitoraggio correlato
- Farmacocinetica pediatrica, formule di dosaggio, fluidi di mantenimento e fattori di rischio di errore
- Percorsi ERAS, stratificazione del rischio perioperatorio, preparazione chirurgica e recovery
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PER6 — Supportare pazienti fragili nel percorso postoperatorio integrando valutazione multidimensionale e interventi di coping mirati

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Gestione perioperatoria avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di supportare pazienti fragili nel percorso postoperatorio integrando valutazione multidimensionale e interventi di coping mirati nell'ambito di gestione perioperatoria avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. La competenza connette preparazione, procedura e recupero, evitando che il percorso chirurgico sia frammentato in atti isolati.

Attitudini

- Visione longitudinale del percorso chirurgico e dei momenti a maggior rischio
- Finezza nel cogliere segnali di paura, evitamento o sopraffazione emotiva
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative

Motivazioni

- Rendere il percorso operatorio prevedibile, sicuro e leggibile per assistito e caregiver
- Ridurre il carico di sofferenza emotiva che può interferire con collaborazione e recupero
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di supportare pazienti fragili nel percorso postoperatorio integrando valutazione multidimensionale e interventi di coping mirati
- Integrare valutazione multidimensionale e interventi di coping mirati
- Integrare preparazione, monitoraggio, informazione e recovery in un piano coerente
- Utilizzare tecniche di supporto, rassicurazione realistica e orientamento al percorso

Conoscenze

- Fasi del percorso chirurgico, ERAS, preparazione preoperatoria e complicanze postoperatorie frequenti
- Ansia perioperatoria, fattori che aumentano stress e strategie non farmacologiche di contenimento
- Percorsi ERAS, stratificazione del rischio perioperatorio, preparazione chirurgica e recovery
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

PER7 — Educare assistito e caregiver alla gestione avanzata del postoperatorio e al riconoscimento precoce di complicanze tardive

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Gestione perioperatoria avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di educare assistito e caregiver alla gestione avanzata del postoperatorio e al riconoscimento precoce di complicanze tardive nell'ambito di gestione perioperatoria avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. La competenza connette preparazione, procedura e recupero, evitando che il percorso chirurgico sia frammentato in atti isolati.

Attitudini

- Orientamento a valorizzare risorse, priorità e tempi di apprendimento della persona
- Visione longitudinale del percorso chirurgico e dei momenti a maggior rischio
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative

Motivazioni

- Favorire autonomia sostenibile e ridurre dipendenza evitabile dal sistema sanitario
- Rendere il percorso operatorio prevedibile, sicuro e leggibile per assistito e caregiver
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di educare assistito e caregiver alla gestione avanzata del postoperatorio e al riconoscimento precoce di complicanze tardive
- Strutturare messaggi prioritari, rinforzi educativi e verifica del ritorno informativo
- Integrare preparazione, monitoraggio, informazione e recovery in un piano coerente
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce

Conoscenze

- Health literacy, teach-back, aderenza terapeutica e strategie di rinforzo dell'autogestione
- Fasi del percorso chirurgico, ERAS, preparazione preoperatoria e complicanze postoperatorie frequenti
- Percorsi ERAS, stratificazione del rischio perioperatorio, preparazione chirurgica e recovery
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nella personalizzazione dei messaggi, nella verifica della comprensione e nel sostegno all'autonomia; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

Monitoraggio clinico e gestione delle complicanze

COM1 — Gestire il dolore postoperatorio attraverso valutazione multidimensionale monitoraggio degli esiti e modulazione terapeutica

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Monitoraggio clinico e gestione delle complicanze

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire il dolore postoperatorio attraverso valutazione multidimensionale monitoraggio degli esiti e modulazione terapeutica nell'ambito di monitoraggio clinico e gestione delle complicanze. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. La competenza connette preparazione, procedura e recupero, evitando che il percorso chirurgico sia frammentato in atti isolati.

Attitudini

- Visione longitudinale del percorso chirurgico e dei momenti a maggior rischio
- Sensibilità a un dolore non sempre esplicitato ma clinicamente rilevante
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi

Motivazioni

- Rendere il percorso operatorio prevedibile, sicuro e leggibile per assistito e caregiver
- Trattare il dolore come esito clinico da monitorare e non come effetto collaterale inevitabile
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire il dolore postoperatorio attraverso valutazione multidimensionale monitoraggio degli esiti e modulazione terapeutica
- Integrare preparazione, monitoraggio, informazione e recovery in un piano coerente
- Utilizzare scale di valutazione del dolore, monitorare risposta analgesica e riconoscere effetti collaterali
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto

Conoscenze

- Fasi del percorso chirurgico, ERAS, preparazione preoperatoria e complicanze postoperatorie frequenti
- Fisiopatologia del dolore acuto, PCA, analgesia epidurale/peridurale e monitoraggio correlato
- Fisiopatologia del postoperatorio, scale di dolore/PONV e criteri di deterioramento clinico
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

COM2 — Monitorare e gestire il decorso postoperatorio riconoscendo precocemente segni di deterioramento clinico e attivando interventi tempestivi

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Monitoraggio clinico e gestione delle complicanze

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare e gestire il decorso postoperatorio riconoscendo precocemente segni di deterioramento clinico e attivando interventi tempestivi nell'ambito di monitoraggio clinico e gestione delle complicanze. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. La competenza connette preparazione, procedura e recupero, evitando che il percorso chirurgico sia frammentato in atti isolati.

Attitudini

- Visione longitudinale del percorso chirurgico e dei momenti a maggior rischio
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Rendere il percorso operatorio prevedibile, sicuro e leggibile per assistito e caregiver
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare e gestire il decorso postoperatorio riconoscendo precocemente segni di deterioramento clinico e attivando interventi tempestivi
- Attivare interventi tempestivi
- Integrare preparazione, monitoraggio, informazione e recovery in un piano coerente
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto

Conoscenze

- Fasi del percorso chirurgico, ERAS, preparazione preoperatoria e complicanze postoperatorie frequenti
- Fisiopatologia del postoperatorio, scale di dolore/PONV e criteri di deterioramento clinico
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

COM3 — Monitorare e supportare il recupero postanestesiologico gestendo nausea vomito parametri clinici e terapia infusionale

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Monitoraggio clinico e gestione delle complicanze

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare e supportare il recupero postanestesiologico gestendo nausea vomito parametri clinici e terapia infusionale nell'ambito di monitoraggio clinico e gestione delle complicanze. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica.

Attitudini

- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend
- Freddezza operativa nelle situazioni a rapida evoluzione

Motivazioni

- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita
- Ricercare una lettura sempre più fine del quadro clinico per sostenere decisioni assistenziali tempestive

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare e supportare il recupero postanestesiologico gestendo nausea vomito parametri clinici e terapia infusionale
- Gestire nausea vomito parametri clinici e terapia infusionale
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione

Conoscenze

- Fisiopatologia del postoperatorio, scale di dolore/PONV e criteri di deterioramento clinico
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.

- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

COM4 — Gestire complicanze correlate a intervento anestesia e dispositivi analgesici avanzati quali PCA e catetere peridurale

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Monitoraggio clinico e gestione delle complicanze

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire complicanze correlate a intervento anestesia e dispositivi analgesici avanzati quali PCA e catetere peridurale nell'ambito di monitoraggio clinico e gestione delle complicanze. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. Il controllo del dolore incide direttamente su mobilitazione, partecipazione alle cure, stabilità fisiologica e qualità dell'esperienza assistenziale.

Attitudini

- Sensibilità a un dolore non sempre esplicitato ma clinicamente rilevante
- Cura del patrimonio venoso come bene clinico da preservare nel tempo
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi

Motivazioni

- Trattare il dolore come esito clinico da monitorare e non come effetto collaterale inevitabile
- Scegliere il device meno invasivo ma adeguato per ridurre fallimenti e consumo venoso evitabile
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire complicanze correlate a intervento anestesia e dispositivi analgesici avanzati quali PCA e catetere peridurale
- Utilizzare scale di valutazione del dolore, monitorare risposta analgesica e riconoscere effetti collaterali
- Riconoscere pattern di tossicità acuta/tardiva e attivare escalation secondo grading e severità
- Proteggere l'assistito durante posizionamento, sedazione e fase intra-procedurale con monitoraggio attivo

Conoscenze

- Fisiopatologia del dolore acuto, PCA, analgesia epidurale/peridurale e monitoraggio correlato
- CTCAE o sistemi analoghi di grading, late effects, triage tossicità e criteri di invio specialistico
- Stewardship venosa, scelta del device, ecoguida, Seldinger, conferma punta e complicanze meccaniche/infettive
- Rischi da posizionamento, monitoraggio in sedazione, prevenzione lesioni e gestione eventi critici di sala
- Fisiopatologia del postoperatorio, scale di dolore/PONV e criteri di deterioramento clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

Gestione avanzata di ferite e dispositivi

FER1 — Gestire e trattare ferite chirurgiche semplici e complesse applicando medicazioni avanzate basate su evidenze

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Gestione avanzata di ferite e dispositivi

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire e trattare ferite chirurgiche semplici e complesse applicando medicazioni avanzate basate su evidenze nell'ambito di gestione avanzata di ferite e dispositivi. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. La competenza connette preparazione, procedura e recupero, evitando che il percorso chirurgico sia frammentato in atti isolati.

Attitudini

- Atteggiamento critico verso routine non supportate da evidenze
- Visione longitudinale del percorso chirurgico e dei momenti a maggior rischio
- Precisione osservativa nei segni locali che anticipano complicanze dei tessuti o dei dispositivi

Motivazioni

- Trasformare l'aggiornamento professionale in miglioramento concreto della pratica
- Rendere il percorso operatorio prevedibile, sicuro e leggibile per assistito e caregiver
- Mantenere integrità tissutale, comfort e autonomia riducendo complicanze locali e ricoveri evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire e trattare ferite chirurgiche semplici e complesse applicando medicazioni avanzate basate su evidenze
- Applicare medicazioni avanzate basate su evidenze
- Valutare affidabilità delle fonti e trasferibilità delle evidenze al contesto locale
- Integrare preparazione, monitoraggio, informazione e recovery in un piano coerente

Conoscenze

- Quesiti clinico-assistenziali, PICO, criteri di qualità metodologica e applicabilità dei risultati
- Fasi del percorso chirurgico, ERAS, preparazione preoperatoria e complicanze postoperatorie frequenti
- Guarigione tissutale, criteri di scelta delle medicazioni, gestione drenaggi/stomie/tracheostomia e prevenzione complicanze
- Principi di wound bed preparation, drenaggi, stomie e gestione della tracheostomia

- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.
- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

FER2 — Monitorare e gestire drenaggi chirurgici interpretando caratteristiche del drenato e identificando precocemente anomalie

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Gestione avanzata di ferite e dispositivi

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare e gestire drenaggi chirurgici interpretando caratteristiche del drenato e identificando precocemente anomalie nell'ambito di gestione avanzata di ferite e dispositivi. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. La competenza connette preparazione, procedura e recupero, evitando che il percorso chirurgico sia frammentato in atti isolati.

Attitudini

- Visione longitudinale del percorso chirurgico e dei momenti a maggior rischio
- Precisione osservativa nei segni locali che anticipano complicanze dei tessuti o dei dispositivi
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici

Motivazioni

- Rendere il percorso operatorio prevedibile, sicuro e leggibile per assistito e caregiver
- Mantenere integrità tissutale, comfort e autonomia riducendo complicanze locali e ricoveri evitabili
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare e gestire drenaggi chirurgici interpretando caratteristiche del drenato e identificando precocemente anomalie
- Interpretare caratteristiche del drenato
- Identificare precocemente anomalie
- Integrare preparazione, monitoraggio, informazione e recovery in un piano coerente

Conoscenze

- Fasi del percorso chirurgico, ERAS, preparazione preoperatoria e complicanze postoperatorie frequenti
- Guarigione tissutale, criteri di scelta delle medicazioni, gestione drenaggi/stomie/tracheostomia e prevenzione complicanze
- Principi di wound bed preparation, drenaggi, stomie e gestione della tracheostomia
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.
- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

FER3 — Gestire ed educare alla cura di stomie gastriche enteriche e urinarie promuovendo autonomia e qualità di vita

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Gestione avanzata di ferite e dispositivi

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire ed educare alla cura di stomie gastriche enteriche e urinarie promuovendo autonomia e qualità di vita nell'ambito di gestione avanzata di ferite e dispositivi. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica.

Attitudini

- Orientamento a valorizzare risorse, priorità e tempi di apprendimento della persona
- Precisione osservativa nei segni locali che anticipano complicanze dei tessuti o dei dispositivi
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici

Motivazioni

- Favorire autonomia sostenibile e ridurre dipendenza evitabile dal sistema sanitario
- Mantenere integrità tissutale, comfort e autonomia riducendo complicanze locali e ricoveri evitabili
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire ed educare alla cura di stomie gastriche enteriche e urinarie promuovendo autonomia e qualità di vita
- Strutturare messaggi prioritari, rinforzi educativi e verifica del ritorno informativo
- Valutare caratteristiche della lesione o del dispositivo e scegliere interventi coerenti con l'obiettivo assistenziale
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza

Conoscenze

- Health literacy, teach-back, aderenza terapeutica e strategie di rinforzo dell'autogestione
- Guarigione tissutale, criteri di scelta delle medicazioni, gestione drenaggi/stomie/tracheostomia e prevenzione complicanze
- Principi di wound bed preparation, drenaggi, stomie e gestione della tracheostomia
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella personalizzazione dei messaggi, nella verifica della comprensione e nel sostegno all'autonomia; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.
- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

FER4 — Gestire in sicurezza la cannula tracheostomica garantendo pervietà vie aeree prevenzione complicanze e corretta gestione delle secrezioni

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Gestione avanzata di ferite e dispositivi

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire in sicurezza la cannula tracheostomica garantendo pervietà vie aeree prevenzione complicanze e corretta gestione delle secrezioni nell'ambito di gestione avanzata di ferite e dispositivi. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica.

Attitudini

- Precisione osservativa nei segni locali che anticipano complicanze dei tessuti o dei dispositivi
- Attenzione simultanea a comfort, meccanica ventilatoria e sicurezza del supporto respiratorio
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici

Motivazioni

- Mantenere integrità tissutale, comfort e autonomia riducendo complicanze locali e ricoveri evitabili
- Prevenire ipossia, ventilazione inadeguata e complicanze correlate al supporto respiratorio
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire in sicurezza la cannula tracheostomica garantendo pervietà vie aeree prevenzione complicanze e corretta gestione delle secrezioni
- Garantire pervietà vie aeree prevenzione complicanze e corretta gestione delle secrezioni
- Valutare caratteristiche della lesione o del dispositivo e scegliere interventi coerenti con l'obiettivo assistenziale
- Impostare o assistere i settaggi respiratori, verificare interfacce/circuiti e monitorare tolleranza/efficacia

Conoscenze

- Guarigione tissutale, criteri di scelta delle medicazioni, gestione drenaggi/stomie/tracheostomia e prevenzione complicanze
- Fisiologia respiratoria, FiO₂, PEEP, curve ventilatorie, criteri di fallimento NIV e sicurezza vie aeree
- Principi di wound bed preparation, drenaggi, stomie e gestione della tracheostomia
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.
- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

Prevenzione e sicurezza chirurgica

CHR1 — Prevenire complicanze settiche del sito chirurgico e dei dispositivi invasivi applicando bundle e protocolli di controllo del rischio infettivo

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Prevenzione e sicurezza chirurgica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di prevenire complicanze settiche del sito chirurgico e dei dispositivi invasivi applicando bundle e protocolli di controllo del rischio infettivo nell'ambito di prevenzione e sicurezza chirurgica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare danni evitabili, deviazioni dagli standard e mancata intercettazione dei fattori di rischio. La sua corretta espressione produce qualità assistenziale, prevenzione del danno e affidabilità organizzativa e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. La competenza connette preparazione, procedura e recupero, evitando che il percorso chirurgico sia frammentato in atti isolati.

Attitudini

- Visione longitudinale del percorso chirurgico e dei momenti a maggior rischio
- Disciplina nell'applicazione di bundle e misure di prevenzione anche quando il rischio sembra basso
- Prudenza professionale e sensibilità verso i segnali di rischio

Motivazioni

- Rendere il percorso operatorio prevedibile, sicuro e leggibile per assistito e caregiver
- Evitare eventi infettivi che aumentano esiti avversi, tempi di degenza e sofferenza evitabile
- Proteggere la persona assistita da danni evitabili e dall'esposizione a rischi non necessari

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di prevenire complicanze settiche del sito chirurgico e dei dispositivi invasivi applicando bundle e protocolli di controllo del rischio infettivo
- Applicare bundle e protocolli di controllo del rischio infettivo
- Integrare preparazione, monitoraggio, informazione e recovery in un piano coerente
- Controllare punti critici di asepsi, profilassi, gestione dispositivi e sorveglianza dei segni di infezione

Conoscenze

- Fasi del percorso chirurgico, ERAS, preparazione preoperatoria e complicanze postoperatorie frequenti
- SSI, misure di asepsi/antisepsi, bundle prevenzione infezioni e sorveglianza delle complicanze sistemiche
- Bundle SSI, mobilitazione precoce, profilassi e prevenzione delle complicanze da immobilità
- Principi di risk management, prevenzione del danno e sicurezza delle cure
- Bundle, check-list, procedure e indicatori di processo/esito rilevanti per l'area

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica standard, check-list e procedure di sicurezza nei casi previsti nel prevenire deviazioni dagli standard e danni evitabili; individua soprattutto i rischi più evidenti e necessita di supervisione nel problem solving.
- **Principiante avanzato:** Riconosce scostamenti ricorrenti dagli standard e attiva le contromisure più note; richiede supporto per analizzare cause multiple o eventi meno tipici.
- **Competente:** Presidia in autonomia i punti critici dei casi ordinari, applica misure preventive, documenta eventi/near miss e interviene tempestivamente sulle deviazioni più frequenti.
- **Abile:** Anticipa condizioni favorevoli all'errore, integra fattori clinici, tecnici e umani e rinforza attivamente il comportamento sicuro dell'équipe nei contesti complessi.
- **Esperto:** È riferimento per la cultura della sicurezza: legge i rischi in modo sistemico, promuove apprendimento dagli eventi e contribuisce a bundle, audit e miglioramento continuo.

CHR2 — Attuare strategie evidence based di prevenzione delle infezioni del sito chirurgico e delle complicanze sistemiche

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Prevenzione e sicurezza chirurgica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di attuare strategie evidence based di prevenzione delle infezioni del sito chirurgico e delle complicanze sistemiche nell'ambito di prevenzione e sicurezza chirurgica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare danni evitabili, deviazioni dagli standard e mancata intercettazione dei fattori di rischio. La sua corretta espressione produce qualità assistenziale, prevenzione del danno e affidabilità organizzativa e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica. La competenza connette preparazione, procedura e recupero, evitando che il percorso chirurgico sia frammentato in atti isolati.

Attitudini

- Visione longitudinale del percorso chirurgico e dei momenti a maggior rischio
- Disciplina nell'applicazione di bundle e misure di prevenzione anche quando il rischio sembra basso
- Prudenza professionale e sensibilità verso i segnali di rischio

Motivazioni

- Rendere il percorso operatorio prevedibile, sicuro e leggibile per assistito e caregiver
- Evitare eventi infettivi che aumentano esiti avversi, tempi di degenza e sofferenza evitabile
- Proteggere la persona assistita da danni evitabili e dall'esposizione a rischi non necessari

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di attuare strategie evidence based di prevenzione delle infezioni del sito chirurgico e delle complicanze sistemiche
- Integrare preparazione, monitoraggio, informazione e recovery in un piano coerente
- Controllare punti critici di asepsi, profilassi, gestione dispositivi e sorveglianza dei segni di infezione
- Applicare protocolli di prevenzione e verificare i punti critici del processo

Conoscenze

- Fasi del percorso chirurgico, ERAS, preparazione preoperatoria e complicanze postoperatorie frequenti
- SSI, misure di asepsi/antisepsi, bundle prevenzione infezioni e sorveglianza delle complicanze sistemiche
- Bundle SSI, mobilitazione precoce, profilassi e prevenzione delle complicanze da immobilità
- Principi di risk management, prevenzione del danno e sicurezza delle cure
- Bundle, check-list, procedure e indicatori di processo/esito rilevanti per l'area

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica standard, check-list e procedure di sicurezza nei casi previsti nel prevenire deviazioni dagli standard e danni evitabili; individua soprattutto i rischi più evidenti e necessita di supervisione nel problem solving.

- **Principiante avanzato:** Riconosce scostamenti ricorrenti dagli standard e attiva le contromisure più note; richiede supporto per analizzare cause multiple o eventi meno tipici.
- **Competente:** Presidia in autonomia i punti critici dei casi ordinari, applica misure preventive, documenta eventi/near miss e interviene tempestivamente sulle deviazioni più frequenti.
- **Abile:** Anticipa condizioni favorevoli all'errore, integra fattori clinici, tecnici e umani e rinforza attivamente il comportamento sicuro dell'équipe nei contesti complessi.
- **Esperto:** È riferimento per la cultura della sicurezza: legge i rischi in modo sistemico, promuove apprendimento dagli eventi e contribuisce a bundle, audit e miglioramento continuo.

CHR3 — Valutare e promuovere mobilitazione precoce per prevenire complicanze tromboemboliche respiratorie e da immobilità

Area/Pannello: Area Chirurgica / Dimensione: Prevenzione e sicurezza chirurgica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare e promuovere mobilitazione precoce per prevenire complicanze tromboemboliche respiratorie e da immobilità nell'ambito di prevenzione e sicurezza chirurgica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare danni evitabili, deviazioni dagli standard e mancata intercettazione dei fattori di rischio. La sua corretta espressione produce qualità assistenziale, prevenzione del danno e affidabilità organizzativa e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Chirurgica.

Attitudini

- Orientamento alla prevenzione attiva delle complicanze da allettamento
- Prudenza professionale e sensibilità verso i segnali di rischio
- Aderenza rigorosa a standard, check-list, bundle e procedure condivise

Motivazioni

- Favorire recupero funzionale precoce e ridurre esiti evitabili da immobilità
- Proteggere la persona assistita da danni evitabili e dall'esposizione a rischi non necessari
- Contribuire a una cultura della sicurezza affidabile, trasparente e non difensiva

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare e promuovere mobilitazione precoce per prevenire complicanze tromboemboliche respiratorie e da immobilità
- Valutare fattori di rischio, timing e tolleranza alla mobilitazione precoce
- Applicare protocolli di prevenzione e verificare i punti critici del processo
- Identificare precocemente deviazioni dagli standard e attivare contromisure appropriate

Conoscenze

- Fisiopatologia tromboembolica, complicanze respiratorie da immobilità e criteri di mobilitazione sicura
- Bundle SSI, mobilitazione precoce, profilassi e prevenzione delle complicanze da immobilità
- Principi di risk management, prevenzione del danno e sicurezza delle cure
- Bundle, check-list, procedure e indicatori di processo/esito rilevanti per l'area
- Fattori umani, cause frequenti di errore e strategie di mitigazione del rischio

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica standard, check-list e procedure di sicurezza nei casi previsti nel prevenire deviazioni dagli standard e danni evitabili; individua soprattutto i rischi più evidenti e necessita di supervisione nel problem solving.

- **Principiante avanzato:** Riconosce scostamenti ricorrenti dagli standard e attiva le contromisure più note; richiede supporto per analizzare cause multiple o eventi meno tipici.
- **Competente:** Presidia in autonomia i punti critici dei casi ordinari, applica misure preventive, documenta eventi/near miss e interviene tempestivamente sulle deviazioni più frequenti.
- **Abile:** Anticipa condizioni favorevoli all'errore, integra fattori clinici, tecnici e umani e rinforza attivamente il comportamento sicuro dell'équipe nei contesti complessi.
- **Esperto:** È riferimento per la cultura della sicurezza: legge i rischi in modo sistemico, promuove apprendimento dagli eventi e contribuisce a bundle, audit e miglioramento continuo.

Competenze di Area Onco-Ematologica

Terapie oncologiche sistemiche e sicurezza farmacologica

CHM1 — Preparare e somministrare terapie oncologiche sistemiche complesse garantendo appropriatezza clinica e sicurezza ambientale

Area/Pannello: Area Onco-Ematologica / Dimensione: Terapie oncologiche sistemiche e sicurezza farmacologica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di preparare e somministrare terapie oncologiche sistemiche complesse garantendo appropriatezza clinica e sicurezza ambientale nell'ambito di terapie oncologiche sistemiche e sicurezza farmacologica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Onco-Ematologica.

Attitudini

- Accuratezza elevata nella gestione di processi ad alto rischio clinico e farmacologico
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Proteggere la persona assistita da tossicità evitabili senza interrompere l'efficacia del percorso oncologico
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di preparare e somministrare terapie oncologiche sistemiche complesse garantendo appropriatezza clinica e sicurezza ambientale
- Garantire appropriatezza clinica e sicurezza ambientale
- Verificare schema terapeutico, parametri di eleggibilità, protezioni, preparazione e somministrazione sicura
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza

Conoscenze

- Principi di oncologia medica infermieristica, sicurezza dei farmaci ad alto rischio e monitoraggio strutturato delle tossicità
- Vescicanti/irritanti, BSA o criteri prescrittivi, DPI, closed system e gestione dell'extravasazione
- Farmaci antineoplastici, gestione del rischio da esposizione, extravasazione, tossicità e farmacovigilanza

- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella corretta gestione del trattamento, nella prevenzione del rischio e nel monitoraggio della risposta; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.
- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

CHM2 — Gestire farmaci antitumorali e terapie innovative applicando protocolli di sicurezza e tracciabilità

Area/Pannello: Area Onco-Ematologica / Dimensione: Terapie oncologiche sistemiche e sicurezza farmacologica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire farmaci antitumorali e terapie innovative applicando protocolli di sicurezza e tracciabilità nell'ambito di terapie oncologiche sistemiche e sicurezza farmacologica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Onco-Ematologica.

Attitudini

- Accuratezza elevata nella gestione di processi ad alto rischio clinico e farmacologico
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Proteggere la persona assistita da tossicità evitabili senza interrompere l'efficacia del percorso oncologico
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire farmaci antitumorali e terapie innovative applicando protocolli di sicurezza e tracciabilità
- Applicare protocolli di sicurezza e tracciabilità
- Verificare schema terapeutico, parametri di eleggibilità, protezioni, preparazione e somministrazione sicura
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza

Conoscenze

- Principi di oncologia medica infermieristica, sicurezza dei farmaci ad alto rischio e monitoraggio strutturato delle tossicità
- Vescicanti/irritanti, BSA o criteri prescrittivi, DPI, closed system e gestione dell'extravasazione
- Farmaci antineoplastici, gestione del rischio da esposizione, extravasazione, tossicità e farmacovigilanza
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella corretta gestione del trattamento, nella prevenzione del rischio e nel monitoraggio della risposta; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

CHM3 — Educare assistito e caregiver alla gestione domiciliare sicura delle terapie orali e infusionali ad alto rischio

Area/Pannello: Area Onco-Ematologica / Dimensione: Terapie oncologiche sistemiche e sicurezza farmacologica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di educare assistito e caregiver alla gestione domiciliare sicura delle terapie orali e infusionali ad alto rischio nell'ambito di terapie oncologiche sistemiche e sicurezza farmacologica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Onco-Ematologica.

Attitudini

- Orientamento a valorizzare risorse, priorità e tempi di apprendimento della persona
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Favorire autonomia sostenibile e ridurre dipendenza evitabile dal sistema sanitario
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di educare assistito e caregiver alla gestione domiciliare sicura delle terapie orali e infusionali ad alto rischio
- Strutturare messaggi prioritari, rinforzi educativi e verifica del ritorno informativo
- Verificare schema terapeutico, parametri di eleggibilità, protezioni, preparazione e somministrazione sicura
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza

Conoscenze

- Health literacy, teach-back, aderenza terapeutica e strategie di rinforzo dell'autogestione
- Vescicanti/irritanti, BSA o criteri prescrittivi, DPI, closed system e gestione dell'extravasazione
- Farmaci antineoplastici, gestione del rischio da esposizione, extravasazione, tossicità e farmacovigilanza
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella personalizzazione dei messaggi, nella verifica della comprensione e nel sostegno all'autonomia; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

CHM4 — Anticipare e gestire tossicità acute e tardive dei trattamenti oncologici utilizzando strumenti di grading e monitoraggio strutturato

Area/Pannello: Area Onco-Ematologica / Dimensione: Terapie oncologiche sistemiche e sicurezza farmacologica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di anticipare e gestire tossicità acute e tardive dei trattamenti oncologici utilizzando strumenti di grading e monitoraggio strutturato nell'ambito di terapie oncologiche sistemiche e sicurezza farmacologica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Onco-Ematologica.

Attitudini

- Accuratezza elevata nella gestione di processi ad alto rischio clinico e farmacologico
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Proteggere la persona assistita da tossicità evitabili senza interrompere l'efficacia del percorso oncologico
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di anticipare e gestire tossicità acute e tardive dei trattamenti oncologici utilizzando strumenti di grading e monitoraggio strutturato
- Utilizzare strumenti di grading e monitoraggio strutturato
- Riconoscere pattern di tossicità acuta/tardiva e attivare escalation secondo grading e severità
- Monitorare risposta clinica, effetti indesiderati, aderenza e condizioni di sicurezza dei trattamenti

Conoscenze

- Principi di oncologia medica infermieristica, sicurezza dei farmaci ad alto rischio e monitoraggio strutturato delle tossicità
- CTCAE o sistemi analoghi di grading, late effects, triage tossicità e criteri di invio specialistico
- Antipsicotici, stabilizzatori, benzodiazepine, sindromi da sospensione, CIWA/COWS se applicabili, interazioni e tossicità
- Farmaci antineoplastici, gestione del rischio da esposizione, extravasazione, tossicità e farmacovigilanza
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.
- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

CHM5 — Identificare precocemente complicanze oncologiche tempo-dipendenti attivando percorsi di intervento specialistico

Area/Pannello: Area Onco-Ematologica / Dimensione: Terapie oncologiche sistemiche e sicurezza farmacologica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di identificare precocemente complicanze oncologiche tempo-dipendenti attivando percorsi di intervento specialistico nell'ambito di terapie oncologiche sistemiche e sicurezza farmacologica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Onco-Ematologica.

Attitudini

- Accuratezza elevata nella gestione di processi ad alto rischio clinico e farmacologico
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Proteggere la persona assistita da tossicità evitabili senza interrompere l'efficacia del percorso oncologico
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di identificare precocemente complicanze oncologiche tempo-dipendenti attivando percorsi di intervento specialistico
- Attivare percorsi di intervento specialistico
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza
- Monitorare efficacia clinica e comparsa di eventi avversi o tossicità

Conoscenze

- Principi di oncologia medica infermieristica, sicurezza dei farmaci ad alto rischio e monitoraggio strutturato delle tossicità
- Farmaci antineoplastici, gestione del rischio da esposizione, extravasazione, tossicità e farmacovigilanza
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

CHM6 — Integrare farmacovigilanza e segnalazione eventi avversi nei percorsi di cura oncologici

Area/Pannello: Area Onco-Ematologica / Dimensione: Terapie oncologiche sistemiche e sicurezza farmacologica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di integrare farmacovigilanza e segnalazione eventi avversi nei percorsi di cura oncologici nell'ambito di terapie oncologiche sistemiche e sicurezza farmacologica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Onco-Ematologica.

Attitudini

- Accuratezza elevata nella gestione di processi ad alto rischio clinico e farmacologico
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Proteggere la persona assistita da tossicità evitabili senza interrompere l'efficacia del percorso oncologico
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di integrare farmacovigilanza e segnalazione eventi avversi nei percorsi di cura oncologici
- Riconoscere pattern di tossicità acuta/tardiva e attivare escalation secondo grading e severità
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza
- Monitorare efficacia clinica e comparsa di eventi avversi o tossicità

Conoscenze

- Principi di oncologia medica infermieristica, sicurezza dei farmaci ad alto rischio e monitoraggio strutturato delle tossicità
- CTCAE o sistemi analoghi di grading, late effects, triage tossicità e criteri di invio specialistico
- Farmaci antineoplastici, gestione del rischio da esposizione, extravasazione, tossicità e farmacovigilanza
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella corretta gestione del trattamento, nella prevenzione del rischio e nel monitoraggio della risposta; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

Navigazione oncologica e survivorship avanzata

NAV1 — Structurare percorsi di navigazione oncologica garantendo continuità terapeutica e accesso appropriato ai servizi

Area/Pannello: Area Onco-Ematologica / Dimensione: Navigazione oncologica e survivorship avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di strutturare percorsi di navigazione oncologica garantendo continuità terapeutica e accesso appropriato ai servizi nell'ambito di navigazione oncologica e survivorship avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Onco-Ematologica.

Attitudini

- Accuratezza elevata nella gestione di processi ad alto rischio clinico e farmacologico
- Attenzione ai bisogni che emergono oltre la fase strettamente terapeutica
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative

Motivazioni

- Proteggere la persona assistita da tossicità evitabili senza interrompere l'efficacia del percorso oncologico
- Accompagnare la persona anche dopo la fase acuta, riducendo frammentazione e abbandono del follow-up
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di strutturare percorsi di navigazione oncologica garantendo continuità terapeutica e accesso appropriato ai servizi
- Garantire continuità terapeutica e accesso appropriato ai servizi
- Coordinare appuntamenti, follow-up, bisogni multidimensionali e prevenzione secondaria
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce

Conoscenze

- Principi di oncologia medica infermieristica, sicurezza dei farmaci ad alto rischio e monitoraggio strutturato delle tossicità
- Survivorship care plan, late effects, bisogni psicosociali e continuità oncologica
- Percorsi oncologici, late effects, survivorship care plan e bisogni multidimensionali
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

NAV2 — Monitorare effetti tardivi e sequele a lungo termine pianificando follow-up personalizzati nei survivors

Area/Pannello: Area Onco-Ematologica / Dimensione: Navigazione oncologica e survivorship avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare effetti tardivi e sequele a lungo termine pianificando follow-up personalizzati nei survivors nell'ambito di navigazione oncologica e survivorship avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Onco-Ematologica. Il valore della competenza emerge nei momenti di transizione, quando il rischio di perdita di informazioni e di disallineamento terapeutico aumenta.

Attitudini

- Attenzione agli snodi di passaggio in cui si concentrano errori, omissioni e frammentazioni
- Accuratezza elevata nella gestione di processi ad alto rischio clinico e farmacologico
- Attenzione ai bisogni che emergono oltre la fase strettamente terapeutica

Motivazioni

- Garantire che il trasferimento tra setting non interrompa sicurezza, comprensione e continuità del piano di cura
- Proteggere la persona assistita da tossicità evitabili senza interrompere l'efficacia del percorso oncologico
- Accompagnare la persona anche dopo la fase acuta, riducendo frammentazione e abbandono del follow-up

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare effetti tardivi e sequele a lungo termine pianificando follow-up personalizzati nei survivors
- Pianificare follow-up personalizzati nei survivors
- Mappare criticità di dimissione, bisogni clinico-sociali e referenti territoriali da attivare
- Riconoscere pattern di tossicità acuta/tardiva e attivare escalation secondo grading e severità

Conoscenze

- Farmaci ad alto rischio in dimissione, continuità dei follow-up, criteri di rischio di rientro ospedaliero
- Principi di oncologia medica infermieristica, sicurezza dei farmaci ad alto rischio e monitoraggio strutturato delle tossicità
- CTCAE o sistemi analoghi di grading, late effects, triage tossicità e criteri di invio specialistico
- Survivorship care plan, late effects, bisogni psicosociali e continuità oncologica
- Percorsi oncologici, late effects, survivorship care plan e bisogni multidimensionali

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

NAV3 — Valutare bisogni multidimensionali dei survivors integrando supporto clinico e prevenzione secondaria

Area/Pannello: Area Onco-Ematologica / Dimensione: Navigazione oncologica e survivorship avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare bisogni multidimensionali dei survivors integrando supporto clinico e prevenzione secondaria nell'ambito di navigazione oncologica e survivorship avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Onco-Ematologica.

Attitudini

- Accuratezza elevata nella gestione di processi ad alto rischio clinico e farmacologico
- Attenzione ai bisogni che emergono oltre la fase strettamente terapeutica
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative

Motivazioni

- Proteggere la persona assistita da tossicità evitabili senza interrompere l'efficacia del percorso oncologico
- Accompagnare la persona anche dopo la fase acuta, riducendo frammentazione e abbandono del follow-up
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare bisogni multidimensionali dei survivors integrando supporto clinico e prevenzione secondaria
- Integrare supporto clinico e prevenzione secondaria
- Coordinare appuntamenti, follow-up, bisogni multidimensionali e prevenzione secondaria
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce

Conoscenze

- Principi di oncologia medica infermieristica, sicurezza dei farmaci ad alto rischio e monitoraggio strutturato delle tossicità
- Survivorship care plan, late effects, bisogni psicosociali e continuità oncologica
- Percorsi oncologici, late effects, survivorship care plan e bisogni multidimensionali
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

Ricerca clinica e innovazione terapeutica

GCP1 — Valutare eleggibilità a studi clinici collaborando alla selezione e arruolamento secondo criteri protocollari

Area/Pannello: Area Onco-Ematologica / Dimensione: Ricerca clinica e innovazione terapeutica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare eleggibilità a studi clinici collaborando alla selezione e arruolamento secondo criteri protocollari nell'ambito di ricerca clinica e innovazione terapeutica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni poco fondate, perdita di qualità dei dati e ridotta trasferibilità delle evidenze. La sua corretta espressione produce aggiornamento della pratica, innovazione controllata e miglioramento guidato da dati e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Onco-Ematologica.

Attitudini

- Atteggiamento critico verso routine non supportate da evidenze
- Rigore documentale e rispetto stretto del protocollo di studio
- Curiosità scientifica e disponibilità a mettere in discussione routine consolidate

Motivazioni

- Trasformare l'aggiornamento professionale in miglioramento concreto della pratica
- Garantire integrità dei dati e sicurezza del partecipante lungo tutto il trial
- Migliorare la pratica assistenziale attraverso decisioni informate da prove affidabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare eleggibilità a studi clinici collaborando alla selezione e arruolamento secondo criteri protocollari
- Valutare affidabilità delle fonti e trasferibilità delle evidenze al contesto locale
- Applicare criteri di eleggibilità, visit schedule, raccolta dati e reporting delle deviazioni/eventi
- Ricercare, selezionare e utilizzare fonti affidabili in modo sistematico

Conoscenze

- Quesiti clinico-assistenziali, PICO, criteri di qualità metodologica e applicabilità dei risultati
- ICH-GCP, informed consent in ricerca, AE/SAE reporting, CRF e accountability del farmaco di studio
- Banche dati bibliografiche, strategie di ricerca e criteri di selezione degli studi
- Principi di implementazione delle evidenze in protocolli e procedure
- Principi di metodologia della ricerca, gerarchia delle evidenze e critical appraisal

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Usa strumenti, procedure o fonti secondo istruzioni definite nel collegare evidenze, dati e decisioni assistenziali; necessita di supervisione per valutare qualità metodologica, coerenza documentale o implicazioni dei dati.
- **Principiante avanzato:** Ricerca e utilizza fonti/protocolli con discreta autonomia nei casi più frequenti; riconosce criticità comuni ma richiede confronto per analisi e decisioni più complesse.
- **Competente:** Gestisce in autonomia attività ordinarie di ricerca/EBP/documentazione, garantisce accuratezza dei dati e trasferisce risultati rilevanti alla pratica clinica.
- **Abile:** Interpreta criticamente dati ed evidenze, individua limiti/applicabilità e orienta miglioramenti clinico-organizzativi fondati su prove e indicatori.
- **Esperto:** Agisce come riferimento metodologico locale: sostiene colleghi, anticipa criticità di qualità del dato/protocollo e contribuisce allo sviluppo di pratiche innovative e rigorose.

GCP2 — Garantire gestione protocollare del paziente in trial clinici monitorando sicurezza e aderenza al protocollo

Area/Pannello: Area Onco-Ematologica / Dimensione: Ricerca clinica e innovazione terapeutica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di garantire gestione protocollare del paziente in trial clinici monitorando sicurezza e aderenza al protocollo nell'ambito di ricerca clinica e innovazione terapeutica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni poco fondate, perdita di qualità dei dati e ridotta trasferibilità delle evidenze. La sua corretta espressione produce aggiornamento della pratica, innovazione controllata e miglioramento guidato da dati e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Onco-Ematologica.

Attitudini

- Atteggiamento critico verso routine non supportate da evidenze
- Orientamento a valorizzare risorse, priorità e tempi di apprendimento della persona
- Accuratezza elevata nella gestione di processi ad alto rischio clinico e farmacologico

Motivazioni

- Trasformare l'aggiornamento professionale in miglioramento concreto della pratica
- Favorire autonomia sostenibile e ridurre dipendenza evitabile dal sistema sanitario
- Proteggere la persona assistita da tossicità evitabili senza interrompere l'efficacia del percorso oncologico

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di garantire gestione protocollare del paziente in trial clinici monitorando sicurezza e aderenza al protocollo
- Monitorare sicurezza e aderenza al protocollo
- Valutare affidabilità delle fonti e trasferibilità delle evidenze al contesto locale
- Strutturare messaggi prioritari, rinforzi educativi e verifica del ritorno informativo

Conoscenze

- Quesiti clinico-assistenziali, PICO, criteri di qualità metodologica e applicabilità dei risultati
- Health literacy, teach-back, aderenza terapeutica e strategie di rinforzo dell'autogestione
- Principi di oncologia medica infermieristica, sicurezza dei farmaci ad alto rischio e monitoraggio strutturato delle tossicità
- ICH-GCP, informed consent in ricerca, AE/SAE reporting, CRF e accountability del farmaco di studio
- Banche dati bibliografiche, strategie di ricerca e criteri di selezione degli studi

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Usa strumenti, procedure o fonti secondo istruzioni definite nell'uso rigoroso delle evidenze, dei protocolli e della documentazione; necessita di supervisione per valutare qualità metodologica, coerenza documentale o implicazioni dei dati.
- **Principiante avanzato:** Ricerca e utilizza fonti/protocolli con discreta autonomia nei casi più frequenti; riconosce criticità comuni ma richiede confronto per analisi e decisioni più complesse.
- **Competente:** Gestisce in autonomia attività ordinarie di ricerca/EBP/documentazione, garantisce accuratezza dei dati e trasferisce risultati rilevanti alla pratica clinica.
- **Abile:** Interpreta criticamente dati ed evidenze, individua limiti/applicabilità e orienta miglioramenti clinico-organizzativi fondati su prove e indicatori.
- **Esperto:** Agisce come riferimento metodologico locale: sostiene colleghi, anticipa criticità di qualità del dato/protocollo e contribuisce allo sviluppo di pratiche innovative e rigorose.

GCP3 — Contribuire alla raccolta e gestione dei dati clinici nel rispetto delle normative di buona pratica clinica

Area/Pannello: Area Onco-Ematologica / Dimensione: Ricerca clinica e innovazione terapeutica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di contribuire alla raccolta e gestione dei dati clinici nel rispetto delle normative di buona pratica clinica nell'ambito di ricerca clinica e innovazione terapeutica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni poco fondate, perdita di qualità dei dati e ridotta trasferibilità delle evidenze. La sua corretta espressione produce aggiornamento della pratica, innovazione controllata e miglioramento guidato da dati e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Onco-Ematologica.

Attitudini

- Atteggiamento critico verso routine non supportate da evidenze
- Rigore documentale e rispetto stretto del protocollo di studio
- Curiosità scientifica e disponibilità a mettere in discussione routine consolidate

Motivazioni

- Trasformare l'aggiornamento professionale in miglioramento concreto della pratica
- Garantire integrità dei dati e sicurezza del partecipante lungo tutto il trial
- Migliorare la pratica assistenziale attraverso decisioni informate da prove affidabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di contribuire alla raccolta e gestione dei dati clinici nel rispetto delle normative di buona pratica clinica
- Valutare affidabilità delle fonti e trasferibilità delle evidenze al contesto locale
- Applicare criteri di eleggibilità, visit schedule, raccolta dati e reporting delle deviazioni/eventi
- Ricercare, selezionare e utilizzare fonti affidabili in modo sistematico

Conoscenze

- Quesiti clinico-assistenziali, PICO, criteri di qualità metodologica e applicabilità dei risultati
- ICH-GCP, informed consent in ricerca, AE/SAE reporting, CRF e accountability del farmaco di studio
- Banche dati bibliografiche, strategie di ricerca e criteri di selezione degli studi
- Principi di implementazione delle evidenze in protocolli e procedure
- Principi di metodologia della ricerca, gerarchia delle evidenze e critical appraisal

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Usa strumenti, procedure o fonti secondo istruzioni definite nell'uso rigoroso delle evidenze, dei protocolli e della documentazione; necessita di supervisione per valutare qualità metodologica, coerenza documentale o implicazioni dei dati.

- **Principiante avanzato:** Ricerca e utilizza fonti/protocolli con discreta autonomia nei casi più frequenti; riconosce criticità comuni ma richiede confronto per analisi e decisioni più complesse.
- **Competente:** Gestisce in autonomia attività ordinarie di ricerca/EBP/documentazione, garantisce accuratezza dei dati e trasferisce risultati rilevanti alla pratica clinica.
- **Abile:** Interpreta criticamente dati ed evidenze, individua limiti/applicabilità e orienta miglioramenti clinico-organizzativi fondati su prove e indicatori.
- **Esperto:** Agisce come riferimento metodologico locale: sostiene colleghi, anticipa criticità di qualità del dato/protocollo e contribuisce allo sviluppo di pratiche innovative e rigorose.

Gestione clinica avanzata della malattia renale

REN1 — Riconoscere e gestire sintomi e complicanze della malattia renale cronica attivando interventi tempestivi basati su valutazione clinica avanzata

Area/Pannello: Area Nefrologica-Dialisi / Dimensione: Gestione clinica avanzata della malattia renale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere e gestire sintomi e complicanze della malattia renale cronica attivando interventi tempestivi basati su valutazione clinica avanzata nell'ambito di gestione clinica avanzata della malattia renale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Nefrologica-Dialisi.

Attitudini

- Costanza nel correlare sintomi, laboratorio, bilancio e trattamento sostitutivo
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Stabilizzare il paziente nefrologico riducendo squilibri, sintomi e accessi evitabili
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere e gestire sintomi e complicanze della malattia renale cronica attivando interventi tempestivi basati su valutazione clinica avanzata
- Attivare interventi tempestivi basati su valutazione clinica avanzata
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione

Conoscenze

- Funzione renale, uremia, bilancio idrico, elettroliti e principi delle terapie sostitutive
- Fisiopatologia della CKD, equilibrio idro-elettrolitico, nutrizione nefrologica e terapia conservativa
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri

- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

REN2 — Gestire l'equilibrio idrico ed elettrolitico prevenendo squilibri e modulando il trattamento sostitutivo

Area/Pannello: Area Nefrologica-Dialisi / Dimensione: Gestione clinica avanzata della malattia renale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire l'equilibrio idrico ed elettrolitico prevenendo squilibri e modulando il trattamento sostitutivo nell'ambito di gestione clinica avanzata della malattia renale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Nefrologica-Dialisi.

Attitudini

- Costanza nel correlare sintomi, laboratorio, bilancio e trattamento sostitutivo
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Stabilizzare il paziente nefrologico riducendo squilibri, sintomi e accessi evitabili
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire l'equilibrio idrico ed elettrolitico prevenendo squilibri e modulando il trattamento sostitutivo
- Modulare il trattamento sostitutivo
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione

Conoscenze

- Funzione renale, uremia, bilancio idrico, elettroliti e principi delle terapie sostitutive
- Fisiopatologia della CKD, equilibrio idro-elettrolitico, nutrizione nefrologica e terapia conservativa
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.

- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

REN3 — Valutare e ottimizzare lo stato nutrizionale del paziente nefropatico integrando parametri biochimici e indicazioni dietetiche personalizzate

Area/Pannello: Area Nefrologica-Dialisi / Dimensione: Gestione clinica avanzata della malattia renale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare e ottimizzare lo stato nutrizionale del paziente nefropatico integrando parametri biochimici e indicazioni dietetiche personalizzate nell'ambito di gestione clinica avanzata della malattia renale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Nefrologica-Dialisi.

Attitudini

- Attenzione alla relazione tra nutrizione, tolleranza clinica e recupero funzionale
- Costanza nel correlare sintomi, laboratorio, bilancio e trattamento sostitutivo
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi

Motivazioni

- Preservare stato nutrizionale, crescita o recupero evitando complicanze da intake inadeguato
- Stabilizzare il paziente nefrologico riducendo squilibri, sintomi e accessi evitabili
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare e ottimizzare lo stato nutrizionale del paziente nefropatico integrando parametri biochimici e indicazioni dietetiche personalizzate
- Integrare parametri biochimici e indicazioni dietetiche personalizzate
- Valutare tolleranza, introiti, pattern alimentare e necessità di adattamento del supporto nutrizionale
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto

Conoscenze

- Fabbisogni nutrizionali, controindicazioni, sicurezza dell'alimentazione enterale e segnali di intolleranza
- Funzione renale, uremia, bilancio idrico, elettroliti e principi delle terapie sostitutive
- Fisiopatologia della CKD, equilibrio idro-elettrolitico, nutrizione nefrologica e terapia conservativa
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

REN4 — Gestire la conservative therapy personalizzando il piano assistenziale secondo stadio di malattia e obiettivi di cura

Area/Pannello: Area Nefrologica-Dialisi / Dimensione: Gestione clinica avanzata della malattia renale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire la conservative therapy personalizzando il piano assistenziale secondo stadio di malattia e obiettivi di cura nell'ambito di gestione clinica avanzata della malattia renale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Nefrologica-Dialisi.

Attitudini

- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend
- Freddezza operativa nelle situazioni a rapida evoluzione

Motivazioni

- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita
- Ricercare una lettura sempre più fine del quadro clinico per sostenere decisioni assistenziali tempestive

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire la conservative therapy personalizzando il piano assistenziale secondo stadio di malattia e obiettivi di cura
- Personalizzare il piano assistenziale secondo stadio di malattia e obiettivi di cura
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione

Conoscenze

- Fisiopatologia della CKD, equilibrio idro-elettrolitico, nutrizione nefrologica e terapia conservativa
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.

- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

Emodialisi e tecnologie extracorporee

EM01 — Condurre trattamenti di emodialisi garantendo adeguatezza dialitica e sicurezza clinica

Area/Pannello: Area Nefrologica-Dialisi / Dimensione: Emodialisi e tecnologie extracorporee

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di condurre trattamenti di emodialisi garantendo adeguatezza dialitica e sicurezza clinica nell'ambito di emodialisi e tecnologie extracorporee. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Nefrologica-Dialisi.

Attitudini

- Costanza nel correlare sintomi, laboratorio, bilancio e trattamento sostitutivo
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Stabilizzare il paziente nefrologico riducendo squilibri, sintomi e accessi evitabili
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di condurre trattamenti di emodialisi garantendo adeguatezza dialitica e sicurezza clinica
- Garantire adeguatezza dialitica e sicurezza clinica
- Predisporre circuito, settaggi e monitoraggio del trattamento con attenzione all'adeguatezza dialitica
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza

Conoscenze

- Funzione renale, uremia, bilancio idrico, elettroliti e principi delle terapie sostitutive
- Convezione/diffusione, Kt/V o concetti di adeguatezza, UF, anticoagulazione e complicanze intradialitiche
- Principi di diffusione/ultrafiltrazione, adeguatezza dialitica, settaggi e complicanze intradialitiche
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.
- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

EMO2 — Gestire il rene artificiale impostando e monitorando parametri dialitici secondo prescrizione e condizioni cliniche

Area/Pannello: Area Nefrologica-Dialisi / Dimensione: Emodialisi e tecnologie extracorporee

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire il rene artificiale impostando e monitorando parametri dialitici secondo prescrizione e condizioni cliniche nell'ambito di emodialisi e tecnologie extracorporee. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Nefrologica-Dialisi.

Attitudini

- Costanza nel correlare sintomi, laboratorio, bilancio e trattamento sostitutivo
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Stabilizzare il paziente nefrologico riducendo squilibri, sintomi e accessi evitabili
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire il rene artificiale impostando e monitorando parametri dialitici secondo prescrizione e condizioni cliniche
- Monitorare parametri dialitici secondo prescrizione e condizioni cliniche
- Predisporre circuito, settaggi e monitoraggio del trattamento con attenzione all'adeguatezza dialitica
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza

Conoscenze

- Funzione renale, uremia, bilancio idrico, elettroliti e principi delle terapie sostitutive
- Convezione/diffusione, Kt/V o concetti di adeguatezza, UF, anticoagulazione e complicanze intradialitiche
- Principi di diffusione/ultrafiltrazione, adeguatezza dialitica, settaggi e complicanze intradialitiche
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

EMO3 — Monitorare il trattamento emodialitico identificando e gestendo complicanze intra-dialitiche

Area/Pannello: Area Nefrologica-Dialisi / Dimensione: Emodialisi e tecnologie extracorporee

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare il trattamento emodialitico identificando e gestendo complicanze intra-dialitiche nell'ambito di emodialisi e tecnologie extracorporee. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Nefrologica-Dialisi.

Attitudini

- Costanza nel correlare sintomi, laboratorio, bilancio e trattamento sostitutivo
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Stabilizzare il paziente nefrologico riducendo squilibri, sintomi e accessi evitabili
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare il trattamento emodialitico identificando e gestendo complicanze intra-dialitiche
- Gestire complicanze intra-dialitiche
- Predisporre circuito, settaggi e monitoraggio del trattamento con attenzione all'adeguatezza dialitica
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza

Conoscenze

- Funzione renale, uremia, bilancio idrico, elettroliti e principi delle terapie sostitutive
- Convezione/diffusione, Kt/V o concetti di adeguatezza, UF, anticoagulazione e complicanze intradialitiche
- Principi di diffusione/ultrafiltrazione, adeguatezza dialitica, settaggi e complicanze intradialitiche
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

EMO4 — Gestire emergenze durante il trattamento dialitico applicando protocolli di sicurezza e stabilizzazione

Area/Pannello: Area Nefrologica-Dialisi / Dimensione: Emodialisi e tecnologie extracorporee

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire emergenze durante il trattamento dialitico applicando protocolli di sicurezza e stabilizzazione nell'ambito di emodialisi e tecnologie extracorporee. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Nefrologica-Dialisi.

Attitudini

- Costanza nel correlare sintomi, laboratorio, bilancio e trattamento sostitutivo
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Stabilizzare il paziente nefrologico riducendo squilibri, sintomi e accessi evitabili
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire emergenze durante il trattamento dialitico applicando protocolli di sicurezza e stabilizzazione
- Applicare protocolli di sicurezza e stabilizzazione
- Predisporre circuito, settaggi e monitoraggio del trattamento con attenzione all'adeguatezza dialitica
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza

Conoscenze

- Funzione renale, uremia, bilancio idrico, elettroliti e principi delle terapie sostitutive
- Convezione/diffusione, Kt/V o concetti di adeguatezza, UF, anticoagulazione e complicanze intradialitiche
- Principi di diffusione/ultrafiltrazione, adeguatezza dialitica, settaggi e complicanze intradialitiche
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

EM05 — Gestire il sistema di osmosi inversa garantendo qualità dell'acqua e conformità ai parametri normativi

Area/Pannello: Area Nefrologica-Dialisi / Dimensione: Emodialisi e tecnologie extracorporee

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire il sistema di osmosi inversa garantendo qualità dell'acqua e conformità ai parametri normativi nell'ambito di emodialisi e tecnologie extracorporee. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Nefrologica-Dialisi.

Attitudini

- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione
- Attenzione continua alla sterilità, alla sicurezza e ai dettagli esecutivi

Motivazioni

- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione
- Consolidare padronanza tecnica come forma di tutela clinica e professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire il sistema di osmosi inversa garantendo qualità dell'acqua e conformità ai parametri normativi
- Garantire qualità dell'acqua e conformità ai parametri normativi
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza
- Eseguire i passaggi tecnici con sequenza corretta e controllo degli esiti immediati

Conoscenze

- Principi di diffusione/ultrafiltrazione, adeguatezza dialitica, settaggi e complicanze intradialitiche
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità
- Complicanze immediate e tardive, con relative strategie di prevenzione e gestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.
- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.

- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

EM06 — Monitorare i sistemi tecnologici dialitici assicurando tracciabilità manutenzione e sicurezza operativa

Area/Pannello: Area Nefrologica-Dialisi / Dimensione: Emodialisi e tecnologie extracorporee

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare i sistemi tecnologici dialitici assicurando tracciabilità manutenzione e sicurezza operativa nell'ambito di emodialisi e tecnologie extracorporee. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Nefrologica-Dialisi.

Attitudini

- Costanza nel correlare sintomi, laboratorio, bilancio e trattamento sostitutivo
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Stabilizzare il paziente nefrologico riducendo squilibri, sintomi e accessi evitabili
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare i sistemi tecnologici dialitici assicurando tracciabilità manutenzione e sicurezza operativa
- Predisporre circuito, settaggi e monitoraggio del trattamento con attenzione all'adeguatezza dialitica
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza
- Eseguire i passaggi tecnici con sequenza corretta e controllo degli esiti immediati

Conoscenze

- Funzione renale, uremia, bilancio idrico, elettroliti e principi delle terapie sostitutive
- Convezione/diffusione, Kt/V o concetti di adeguatezza, UF, anticoagulazione e complicanze intradialitiche
- Principi di diffusione/ultrafiltrazione, adeguatezza dialitica, settaggi e complicanze intradialitiche
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

Accessi dialitici e terapie peritoneali

DIA1 — Gestire e monitorare accessi vascolari e peritoneali prevenendo infezioni e disfunzioni

Area/Pannello: Area Nefrologica-Dialisi / Dimensione: Accessi dialitici e terapie peritoneali

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire e monitorare accessi vascolari e peritoneali prevenendo infezioni e disfunzioni nell'ambito di accessi dialitici e terapie peritoneali. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Nefrologica-Dialisi.

Attitudini

- Disciplina nell'applicazione di bundle e misure di prevenzione anche quando il rischio sembra basso
- Costanza nel correlare sintomi, laboratorio, bilancio e trattamento sostitutivo
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali

Motivazioni

- Evitare eventi infettivi che aumentano esiti avversi, tempi di degenza e sofferenza evitabile
- Stabilizzare il paziente nefrologico riducendo squilibri, sintomi e accessi evitabili
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire e monitorare accessi vascolari e peritoneali prevenendo infezioni e disfunzioni
- Prevenire infezioni e disfunzioni
- Controllare punti critici di asepsi, profilassi, gestione dispositivi e sorveglianza dei segni di infezione
- Valutare e gestire accesso dialitico identificando segni precoci di disfunzione o infezione

Conoscenze

- SSI, misure di asepsi/antisepsi, bundle prevenzione infezioni e sorveglianza delle complicanze sistemiche
- Funzione renale, uremia, bilancio idrico, elettroliti e principi delle terapie sostitutive
- Cure di fistole/CVC dialitici/cateteri peritoneali, peritonite e malfunzionamento accessi
- Fistole, CVC dialitici, cateteri peritoneali, prevenzione infezioni e tecniche di cura/accesso
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.
- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

DIA2 — Condurre trattamenti di dialisi peritoneale automatizzata e continua personalizzando schema terapeutico e monitoraggio domiciliare

Area/Pannello: Area Nefrologica-Dialisi / Dimensione: Accessi dialitici e terapie peritoneali

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di condurre trattamenti di dialisi peritoneale automatizzata e continua personalizzando schema terapeutico e monitoraggio domiciliare nell'ambito di accessi dialitici e terapie peritoneali. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Nefrologica-Dialisi.

Attitudini

- Costanza nel correlare sintomi, laboratorio, bilancio e trattamento sostitutivo
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Stabilizzare il paziente nefrologico riducendo squilibri, sintomi e accessi evitabili
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di condurre trattamenti di dialisi peritoneale automatizzata e continua personalizzando schema terapeutico e monitoraggio domiciliare
- Personalizzare schema terapeutico e monitoraggio domiciliare
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza
- Eseguire i passaggi tecnici con sequenza corretta e controllo degli esiti immediati

Conoscenze

- Funzione renale, uremia, bilancio idrico, elettroliti e principi delle terapie sostitutive
- Fistole, CVC dialitici, cateteri peritoneali, prevenzione infezioni e tecniche di cura/accesso
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità
- Complicanze immediate e tardive, con relative strategie di prevenzione e gestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

DIA3 — Valutare idoneità e performance dell'accesso dialitico intervenendo precocemente in caso di segni di malfunzionamento

Area/Pannello: Area Nefrologica-Dialisi / Dimensione: Accessi dialitici e terapie peritoneali

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare idoneità e performance dell'accesso dialitico intervenendo precocemente in caso di segni di malfunzionamento nell'ambito di accessi dialitici e terapie peritoneali. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Nefrologica-Dialisi.

Attitudini

- Costanza nel correlare sintomi, laboratorio, bilancio e trattamento sostitutivo
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Stabilizzare il paziente nefrologico riducendo squilibri, sintomi e accessi evitabili
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare idoneità e performance dell'accesso dialitico intervenendo precocemente in caso di segni di malfunzionamento
- Predisporre circuito, settaggi e monitoraggio del trattamento con attenzione all'adeguatezza dialitica
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza
- Eseguire i passaggi tecnici con sequenza corretta e controllo degli esiti immediati

Conoscenze

- Funzione renale, uremia, bilancio idrico, elettroliti e principi delle terapie sostitutive
- Convezione/diffusione, Kt/V o concetti di adeguatezza, UF, anticoagulazione e complicanze intradialitiche
- Fistole, CVC dialitici, cateteri peritoneali, prevenzione infezioni e tecniche di cura/accesso
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

Competenze di Area dell'Emergenza-Urgenza

Monitoraggio avanzato e interpretazione fisiopatologica

MON1 — Gestire il monitoraggio invasivo delle pressioni centrali arteriose e intracraniche interpretando i dati in relazione al quadro clinico

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Monitoraggio avanzato e interpretazione fisiopatologica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire il monitoraggio invasivo delle pressioni centrali arteriose e intracraniche interpretando i dati in relazione al quadro clinico nell'ambito di monitoraggio avanzato e interpretazione fisiopatologica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Sensibilità ai bisogni emotivi e informativi espressi o impliciti
- Capacità di mantenere coerenza tra contenuto, tono e postura professionale
- Lettura integrata dei dati monitorati e delle loro implicazioni fisiopatologiche

Motivazioni

- Rendere comprensibile il percorso di cura e favorire scelte realmente consapevoli
- Identificare precocemente deterioramenti tempo-dipendenti e sostenere decisioni ad alta urgenza
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire il monitoraggio invasivo delle pressioni centrali arteriose e intracraniche interpretando i dati in relazione al quadro clinico
- Interpretare i dati in relazione al quadro clinico
- Verificare comprensione, dubbi, consenso e necessità di rinforzo informativo
- Correlare parametri invasivi/non invasivi con quadro clinico, trend e risposta ai trattamenti

Conoscenze

- Principi di comunicazione efficace, decisione condivisa, consenso e adattamento del linguaggio
- Monitoraggio emodinamico/neurologico/ECG, lettura dei trend e criteri di allerta in area critica
- Emodinamica, monitoraggio neurologico e respiratorio, lettura integrata dei parametri e dei trend

- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

MON2 — Monitorare la funzione respiratoria integrando meccanica ventilatoria e parametri di scambio gassoso nella valutazione clinica

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Monitoraggio avanzato e interpretazione fisiopatologica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare la funzione respiratoria integrando meccanica ventilatoria e parametri di scambio gassoso nella valutazione clinica nell'ambito di monitoraggio avanzato e interpretazione fisiopatologica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Attenzione simultanea a comfort, meccanica ventilatoria e sicurezza del supporto respiratorio
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Prevenire ipossia, ventilazione inadeguata e complicanze correlate al supporto respiratorio
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare la funzione respiratoria integrando meccanica ventilatoria e parametri di scambio gassoso nella valutazione clinica
- Integrare meccanica ventilatoria e parametri di scambio gassoso nella valutazione clinica
- Impostare o assistere i settaggi respiratori, verificare interfacce/circuiti e monitorare tolleranza/efficacia
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto

Conoscenze

- Fisiologia respiratoria, FiO₂, PEEP, curve ventilatorie, criteri di fallimento NIV e sicurezza vie aeree
- Emodinamica, monitoraggio neurologico e respiratorio, lettura integrata dei parametri e dei trend
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

MON3 — Identificare alterazioni elettrocardiografiche applicando algoritmi di advanced life support

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Monitoraggio avanzato e interpretazione fisiopatologica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di identificare alterazioni elettrocardiografiche applicando algoritmi di advanced life support nell'ambito di monitoraggio avanzato e interpretazione fisiopatologica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Lettura integrata dei dati monitorati e delle loro implicazioni fisiopatologiche
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Identificare precocemente deterioramenti tempo-dipendenti e sostenere decisioni ad alta urgenza
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di identificare alterazioni elettrocardiografiche applicando algoritmi di advanced life support
- Applicare algoritmi di advanced life support
- Correlare parametri invasivi/non invasivi con quadro clinico, trend e risposta ai trattamenti
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto

Conoscenze

- Monitoraggio emodinamico/neurologico/ECG, lettura dei trend e criteri di allerta in area critica
- Emodinamica, monitoraggio neurologico e respiratorio, lettura integrata dei parametri e dei trend
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.

- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

MON4 — Eseguire valutazione neurologica avanzata interpretando AVPU GCS e risposta pupillare in ottica evolutiva

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Monitoraggio avanzato e interpretazione fisiopatologica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di eseguire valutazione neurologica avanzata interpretando AVPU GCS e risposta pupillare in ottica evolutiva nell'ambito di monitoraggio avanzato e interpretazione fisiopatologica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Lettura integrata dei dati monitorati e delle loro implicazioni fisiopatologiche
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Identificare precocemente deterioramenti tempo-dipendenti e sostenere decisioni ad alta urgenza
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di eseguire valutazione neurologica avanzata interpretando AVPU GCS e risposta pupillare in ottica evolutiva
- Interpretare aVPU GCS e risposta pupillare in ottica evolutiva
- Correlare parametri invasivi/non invasivi con quadro clinico, trend e risposta ai trattamenti
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto

Conoscenze

- Monitoraggio emodinamico/neurologico/ECG, lettura dei trend e criteri di allerta in area critica
- Emodinamica, monitoraggio neurologico e respiratorio, lettura integrata dei parametri e dei trend
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.

- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

MON5 — Predisporre e gestire monitoraggio emodinamico avanzato interpretando parametri derivati e trend clinici

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Monitoraggio avanzato e interpretazione fisiopatologica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di predisporre e gestire monitoraggio emodinamico avanzato interpretando parametri derivati e trend clinici nell'ambito di monitoraggio avanzato e interpretazione fisiopatologica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Lettura integrata dei dati monitorati e delle loro implicazioni fisiopatologiche
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Identificare precocemente deterioramenti tempo-dipendenti e sostenere decisioni ad alta urgenza
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di predisporre e gestire monitoraggio emodinamico avanzato interpretando parametri derivati e trend clinici
- Interpretare parametri derivati e trend clinici
- Correlare parametri invasivi/non invasivi con quadro clinico, trend e risposta ai trattamenti
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto

Conoscenze

- Monitoraggio emodinamico/neurologico/ECG, lettura dei trend e criteri di allerta in area critica
- Emodinamica, monitoraggio neurologico e respiratorio, lettura integrata dei parametri e dei trend
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.

- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

Ventilazione e gestione avanzata delle vie aeree

VEN1 — Gestire ossigenoterapia e ventilazione non invasiva modulando settaggi in base a fisiopatologia e risposta clinica

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Ventilazione e gestione avanzata delle vie aeree

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire ossigenoterapia e ventilazione non invasiva modulando settaggi in base a fisiopatologia e risposta clinica nell'ambito di ventilazione e gestione avanzata delle vie aeree. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Attenzione simultanea a comfort, meccanica ventilatoria e sicurezza del supporto respiratorio
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Prevenire ipossia, ventilazione inadeguata e complicanze correlate al supporto respiratorio
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire ossigenoterapia e ventilazione non invasiva modulando settaggi in base a fisiopatologia e risposta clinica
- Modulare settaggi in base a fisiopatologia e risposta clinica
- Impostare o assistere i settaggi respiratori, verificare interfacce/circuiti e monitorare tolleranza/efficacia
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza

Conoscenze

- Fisiologia respiratoria, FiO₂, PEEP, curve ventilatorie, criteri di fallimento NIV e sicurezza vie aeree
- Fisiologia respiratoria, NIV/IMV, presidi per vie aeree, curve ventilatorie e sicurezza dell'intubazione
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità
- Complicanze immediate e tardive, con relative strategie di prevenzione e gestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.
- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

VEN2 — Gestire ventilazione meccanica invasiva interpretando curve ventilatorie e parametri avanzati

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Ventilazione e gestione avanzata delle vie aeree

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire ventilazione meccanica invasiva interpretando curve ventilatorie e parametri avanzati nell'ambito di ventilazione e gestione avanzata delle vie aeree. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Attenzione simultanea a comfort, meccanica ventilatoria e sicurezza del supporto respiratorio
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Prevenire ipossia, ventilazione inadeguata e complicanze correlate al supporto respiratorio
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire ventilazione meccanica invasiva interpretando curve ventilatorie e parametri avanzati
- Interpretare curve ventilatorie e parametri avanzati
- Impostare o assistere i settaggi respiratori, verificare interfacce/circuiti e monitorare tolleranza/efficacia
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza

Conoscenze

- Fisiologia respiratoria, FiO₂, PEEP, curve ventilatorie, criteri di fallimento NIV e sicurezza vie aeree
- Fisiologia respiratoria, NIV/IMV, presidi per vie aeree, curve ventilatorie e sicurezza dell'intubazione
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità
- Complicanze immediate e tardive, con relative strategie di prevenzione e gestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

VEN3 — Riconoscere compromissione delle vie aeree attuando manovre di apertura e utilizzo appropriato di presidi sovraglottici

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Ventilazione e gestione avanzata delle vie aeree

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere compromissione delle vie aeree attuando manovre di apertura e utilizzo appropriato di presidi sovraglottici nell'ambito di ventilazione e gestione avanzata delle vie aeree. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Attenzione simultanea a comfort, meccanica ventilatoria e sicurezza del supporto respiratorio
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Prevenire ipossia, ventilazione inadeguata e complicanze correlate al supporto respiratorio
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere compromissione delle vie aeree attuando manovre di apertura e utilizzo appropriato di presidi sovraglottici
- Impostare o assistere i settaggi respiratori, verificare interfacce/circuiti e monitorare tolleranza/efficacia
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza
- Eseguire i passaggi tecnici con sequenza corretta e controllo degli esiti immediati

Conoscenze

- Fisiologia respiratoria, FiO₂, PEEP, curve ventilatorie, criteri di fallimento NIV e sicurezza vie aeree
- Fisiologia respiratoria, NIV/IMV, presidi per vie aeree, curve ventilatorie e sicurezza dell'intubazione
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità
- Complicanze immediate e tardive, con relative strategie di prevenzione e gestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

VEN4 — Assistere nella gestione avanzata delle vie aeree durante intubazione rapida in sequenza garantendo sicurezza procedurale

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Ventilazione e gestione avanzata delle vie aeree

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di assistere nella gestione avanzata delle vie aeree durante intubazione rapida in sequenza garantendo sicurezza procedurale nell'ambito di ventilazione e gestione avanzata delle vie aeree. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Attenzione simultanea a comfort, meccanica ventilatoria e sicurezza del supporto respiratorio
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Prevenire ipossia, ventilazione inadeguata e complicanze correlate al supporto respiratorio
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di assistere nella gestione avanzata delle vie aeree durante intubazione rapida in sequenza garantendo sicurezza procedurale
- Garantire sicurezza procedurale
- Impostare o assistere i settaggi respiratori, verificare interfacce/circuiti e monitorare tolleranza/efficacia
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza

Conoscenze

- Fisiologia respiratoria, FiO₂, PEEP, curve ventilatorie, criteri di fallimento NIV e sicurezza vie aeree
- Fisiologia respiratoria, NIV/IMV, presidi per vie aeree, curve ventilatorie e sicurezza dell'intubazione
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità
- Complicanze immediate e tardive, con relative strategie di prevenzione e gestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.
- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

VEN5 — Predisporre ventilatore meccanico selezionando e collegando correttamente circuiti filtri e sistemi di umidificazione

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Ventilazione e gestione avanzata delle vie aeree

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di predisporre ventilatore meccanico selezionando e collegando correttamente circuiti filtri e sistemi di umidificazione nell'ambito di ventilazione e gestione avanzata delle vie aeree. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Attenzione simultanea a comfort, meccanica ventilatoria e sicurezza del supporto respiratorio
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Prevenire ipossia, ventilazione inadeguata e complicanze correlate al supporto respiratorio
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di predisporre ventilatore meccanico selezionando e collegando correttamente circuiti filtri e sistemi di umidificazione
- Selezionare e collegando correttamente circuiti filtri e sistemi di umidificazione
- Impostare o assistere i settaggi respiratori, verificare interfacce/circuiti e monitorare tolleranza/efficacia
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza

Conoscenze

- Fisiologia respiratoria, FiO₂, PEEP, curve ventilatorie, criteri di fallimento NIV e sicurezza vie aeree
- Fisiologia respiratoria, NIV/IMV, presidi per vie aeree, curve ventilatorie e sicurezza dell'intubazione
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità
- Complicanze immediate e tardive, con relative strategie di prevenzione e gestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

Triage avanzato e prioritarizzazione clinica

TRI1 — Eseguire triage avanzato applicando sistemi di classificazione e stratificazione del rischio basati su parametri clinici e segni di instabilità

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Triage avanzato e prioritarizzazione clinica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di eseguire triage avanzato applicando sistemi di classificazione e stratificazione del rischio basati su parametri clinici e segni di instabilità nell'ambito di triage avanzato e prioritarizzazione clinica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Capacità di decidere rapidamente senza perdere metodo e rivalutazione critica
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Allocare con giustizia clinica tempi e risorse in base a gravità e rischio evolutivo
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di eseguire triage avanzato applicando sistemi di classificazione e stratificazione del rischio basati su parametri clinici e segni di instabilità
- Applicare sistemi di classificazione e stratificazione del rischio basati su parametri clinici e segni di instabilità
- Classificare, rivalutare e ridefinire la priorità sulla base dell'evoluzione clinica
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce

Conoscenze

- Discriminatori di triage, red flags, percorsi tempo-dipendenti e principi di rivalutazione
- Sistemi di triage, criteri tempo-dipendenti, discriminatori clinici e rivalutazione dinamica
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

TRI2 — Prioritizzare interventi assistenziali in base a gravità tempo-dipendenza e probabilità di deterioramento clinico

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Triage avanzato e prioritarizzazione clinica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di prioritizzare interventi assistenziali in base a gravità tempo-dipendenza e probabilità di deterioramento clinico nell'ambito di triage avanzato e prioritarizzazione clinica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Capacità di decidere rapidamente senza perdere metodo e rivalutazione critica
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Allocare con giustizia clinica tempi e risorse in base a gravità e rischio evolutivo
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di prioritizzare interventi assistenziali in base a gravità tempo-dipendenza e probabilità di deterioramento clinico
- Classificare, rivalutare e ridefinire la priorità sulla base dell'evoluzione clinica
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Discriminatori di triage, red flags, percorsi tempo-dipendenti e principi di rivalutazione
- Sistemi di triage, criteri tempo-dipendenti, discriminatori clinici e rivalutazione dinamica
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

TRI3 — Rivalutare dinamicamente il livello di priorità integrando evoluzione clinica e risposta ai trattamenti

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Triage avanzato e prioritarizzazione clinica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di rivalutare dinamicamente il livello di priorità integrando evoluzione clinica e risposta ai trattamenti nell'ambito di triage avanzato e prioritarizzazione clinica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Capacità di decidere rapidamente senza perdere metodo e rivalutazione critica
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Allocare con giustizia clinica tempi e risorse in base a gravità e rischio evolutivo
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di rivalutare dinamicamente il livello di priorità integrando evoluzione clinica e risposta ai trattamenti
- Integrare evoluzione clinica e risposta ai trattamenti
- Classificare, rivalutare e ridefinire la priorità sulla base dell'evoluzione clinica
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce

Conoscenze

- Discriminatori di triage, red flags, percorsi tempo-dipendenti e principi di rivalutazione
- Sistemi di triage, criteri tempo-dipendenti, discriminatori clinici e rivalutazione dinamica
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel tenere insieme bisogni, tempi, professionisti e continuità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

Procurement d'organo

ORG1 — Identificare e valutare il potenziale donatore applicando criteri clinici e attivando tempestivamente il percorso di donazione

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Procurement d'organo

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di identificare e valutare il potenziale donatore applicando criteri clinici e attivando tempestivamente il percorso di donazione nell'ambito di procurement d'organo. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Rispetto del percorso di donazione come processo clinico e valoriale ad alta sensibilità
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative
- Affidabilità nel coordinare attori, tempi e passaggi critici del processo

Motivazioni

- Preservare qualità del procurement e dignità del percorso del donatore e della famiglia
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico
- Garantire che ogni snodo del percorso sia governato con responsabilità professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di identificare e valutare il potenziale donatore applicando criteri clinici e attivando tempestivamente il percorso di donazione
- Applicare criteri clinici
- Attivare tempestivamente il percorso di donazione
- Attivare percorso donazione, coordinare tempi, assistenza e requisiti di tracciabilità

Conoscenze

- Criteri di donazione, mantenimento del potenziale donatore, tempi di ischemia e logistica del procurement
- Criteri di donazione, gestione del potenziale donatore, tempi di ischemia e tracciabilità del percorso
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse
- Strumenti di comunicazione strutturata, documentazione e handover clinico

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

ORG2 — Gestire l'assistenza procedurale in camera operatoria durante il prelievo d'organo garantendo gestione sterile tracciabilità confezionamento e catena di custodia secondo standard

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Procurement d'organo

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire l'assistenza procedurale in camera operatoria durante il prelievo d'organo garantendo gestione sterile tracciabilità confezionamento e catena di custodia secondo standard nell'ambito di procurement d'organo. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Rispetto del percorso di donazione come processo clinico e valoriale ad alta sensibilità
- Anticipazione del fabbisogno tecnico e attenzione alla sequenza del workflow
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative

Motivazioni

- Preservare qualità del procurement e dignità del percorso del donatore e della famiglia
- Evitare interruzioni, contaminazioni e ritardi che compromettono sicurezza ed efficienza procedurale
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire l'assistenza procedurale in camera operatoria durante il prelievo d'organo garantendo gestione sterile tracciabilità confezionamento e catena di custodia secondo standard
- Garantire gestione sterile tracciabilità confezionamento e catena di custodia secondo standard
- Attivare percorso donazione, coordinare tempi, assistenza e requisiti di tracciabilità
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce

Conoscenze

- Criteri di donazione, mantenimento del potenziale donatore, tempi di ischemia e logistica del procurement
- Flussi di sala, set-up, materiali sterili, reprocessing, controlli funzionali e tracciabilità dei dispositivi
- Criteri di donazione, gestione del potenziale donatore, tempi di ischemia e tracciabilità del percorso
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.
- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

ORG3 — Coordinare il percorso del donatore per garantire continuità di monitoraggio e rispetto dei tempi di ischemia

Area/Pannello: Area dell'Emergenza Urgenza / Dimensione: Procurement d'organo

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di coordinare il percorso del donatore per garantire continuità di monitoraggio e rispetto dei tempi di ischemia nell'ambito di procurement d'organo. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare frammentazione del percorso, omissioni informative e disallineamento tra professionisti/setting. La sua corretta espressione produce continuità assistenziale, chiarezza dei ruoli e fluidità del percorso di cura e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area dell'Emergenza Urgenza.

Attitudini

- Accuratezza elevata nella gestione di processi ad alto rischio clinico e farmacologico
- Rispetto del percorso di donazione come processo clinico e valoriale ad alta sensibilità
- Visione d'insieme del percorso assistenziale e delle interdipendenze organizzative

Motivazioni

- Proteggere la persona assistita da tossicità evitabili senza interrompere l'efficacia del percorso oncologico
- Preservare qualità del procurement e dignità del percorso del donatore e della famiglia
- Ridurre frammentazioni, omissioni e ritardi che compromettono la continuità della presa in carico

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di coordinare il percorso del donatore per garantire continuità di monitoraggio e rispetto dei tempi di ischemia
- Attivare percorso donazione, coordinare tempi, assistenza e requisiti di tracciabilità
- Organizzare il percorso assistenziale definendo priorità, tempi, responsabilità e interfacce
- Favorire passaggi informativi affidabili tra professionisti, setting e servizi

Conoscenze

- Principi di oncologia medica infermieristica, sicurezza dei farmaci ad alto rischio e monitoraggio strutturato delle tossicità
- Criteri di donazione, mantenimento del potenziale donatore, tempi di ischemia e logistica del procurement
- Criteri di donazione, gestione del potenziale donatore, tempi di ischemia e tracciabilità del percorso
- Modelli di presa in carico, continuità assistenziale e case management infermieristico
- Criteri di prioritarizzazione, pianificazione e utilizzo appropriato delle risorse

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa al percorso assistenziale seguendo indicazioni e priorità definite da altri nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; necessita di guida per tenere insieme tempi, attori e passaggi informativi.

- **Principiante avanzato:** Gestisce segmenti del percorso nei casi più lineari e riconosce criticità organizzative frequenti; richiede confronto quando aumentano variabili, interfacce o conflitti di priorità.
- **Competente:** Coordina in autonomia i casi ordinari, pianifica attività, passaggi informativi e rivalutazioni, e corregge tempestivamente gli scostamenti più prevedibili.
- **Abile:** Integra quadro clinico, risorse, tempi e attori in modo flessibile; anticipa punti di rottura del percorso e riorganizza il piano assistenziale mantenendo continuità e chiarezza dei ruoli.
- **Esperto:** Governa percorsi complessi con visione sistemica, sostiene il team nei nodi decisionali e contribuisce a definire modelli organizzativi, indicatori e miglioramenti di processo.

Adattamento neonatale e valutazione clinica

NEON1 — Valutare adattamento cardio-respiratorio del neonato nelle prime ore di vita monitorando frequenza respiratoria colorito e perfusione

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Adattamento neonatale e valutazione clinica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare adattamento cardio-respiratorio del neonato nelle prime ore di vita monitorando frequenza respiratoria colorito e perfusione nell'ambito di adattamento neonatale e valutazione clinica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare adattamento cardio-respiratorio del neonato nelle prime ore di vita monitorando frequenza respiratoria colorito e perfusione
- Monitorare frequenza respiratoria colorito e perfusione
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione

Conoscenze

- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della cure neonatale
- Fisiologia della transizione neonatale, termoregolazione, respirazione, perfusione e parametri neonatali
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri

- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

NEON2 — Eseguire valutazione sistematica del neonato identificando segni precoci di distress respiratorio o instabilità termica

Area/Pannello: Area Materno-Infantile | Dimensione: Adattamento neonatale e valutazione clinica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di eseguire valutazione sistematica del neonato identificando segni precoci di distress respiratorio o instabilità termica nell'ambito di adattamento neonatale e valutazione clinica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di eseguire valutazione sistematica del neonato identificando segni precoci di distress respiratorio o instabilità termica
- Identificare segni precoci di distress respiratorio o instabilità termica
- Riconoscere precocemente deviazioni dell'adattamento neonatale e attivare rivalutazione/escalation
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto

Conoscenze

- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della care neonatale
- Soglie cliniche per ipoglicemia/ittero/instabilità, distress respiratorio e monitoraggio del late preterm
- Fisiologia della transizione neonatale, termoregolazione, respirazione, perfusione e parametri neonatali
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

NEON3 — Interpretare parametri antropometrici neonatali in relazione a età gestazionale e curve di crescita

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Adattamento neonatale e valutazione clinica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di interpretare parametri antropometrici neonatali in relazione a età gestazionale e curve di crescita nell'ambito di adattamento neonatale e valutazione clinica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Sensibilità ai bisogni emotivi e informativi espressi o impliciti
- Capacità di mantenere coerenza tra contenuto, tono e postura professionale
- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità

Motivazioni

- Rendere comprensibile il percorso di cura e favorire scelte realmente consapevoli
- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di interpretare parametri antropometrici neonatali in relazione a età gestazionale e curve di crescita
- Verificare comprensione, dubbi, consenso e necessità di rinforzo informativo
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione

Conoscenze

- Principi di comunicazione efficace, decisione condivisa, consenso e adattamento del linguaggio
- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della cure neonatale
- Fisiologia della transizione neonatale, termoregolazione, respirazione, perfusione e parametri neonatali
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.

- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

NEON4 — Gestire la pratica dello skin to skin, del roaming in e della Kangaroo therapy

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Adattamento neonatale e valutazione clinica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire la pratica dello skin to skin, del roaming in e della Kangaroo therapy nell'ambito di adattamento neonatale e valutazione clinica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire la pratica dello skin to skin, del roaming in e della Kangaroo therapy
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione
- Documentare tempestivamente anomalie, trend e interventi attuati

Conoscenze

- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della care neonatale
- Fisiologia della transizione neonatale, termoregolazione, respirazione, perfusione e parametri neonatali
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.

- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

Nutrizione e supporto all'allattamento

ALL1 — Valutare efficacia della suzione e coordinazione suzione-deglutizione-respirazione

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Nutrizione e supporto all'allattamento

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare efficacia della suzione e coordinazione suzione-deglutizione-respirazione nell'ambito di nutrizione e supporto all'allattamento. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare scarsa comprensione, bassa aderenza e difficoltà nell'autogestione. La sua corretta espressione produce maggiore autonomia, aderenza e partecipazione informata alle cure e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Attenzione alla relazione tra nutrizione, tolleranza clinica e recupero funzionale
- Ascolto attivo e rispetto del livello di comprensione della persona e della famiglia
- Flessibilità comunicativa nel modulare linguaggio, tempi e strumenti educativi

Motivazioni

- Preservare stato nutrizionale, crescita o recupero evitando complicanze da intake inadeguato
- Favorire consapevolezza e partecipazione attiva della persona al percorso di cura
- Ridurre errori, riacutizzazioni e dipendenza evitabile attraverso un apprendimento efficace

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare efficacia della suzione e coordinazione suzione-deglutizione-respirazione
- Valutare tolleranza, introiti, pattern alimentare e necessità di adattamento del supporto nutrizionale
- Osservare attacco, trasferimento di latte, coordinazione suzione-deglutizione-respirazione e segni di efficacia della poppata
- Accertare bisogni educativi, barriere e risorse di apprendimento

Conoscenze

- Fabbisogni nutrizionali, controindicazioni, sicurezza dell'alimentazione enterale e segnali di intolleranza
- Fisiologia della lattazione, segnali di poppata efficace, difficoltà di attacco e sostegno alla diade
- Lattazione, valutazione della poppata, alimentazione alternativa e tolleranza nutrizionale neonatale
- Principi di educazione terapeutica, health literacy e apprendimento degli adulti
- Strumenti di teaching, teach-back e rinforzo dell'aderenza/autogestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Fornisce informazioni essenziali seguendo indicazioni e materiali disponibili nella costruzione di comprensione, aderenza e partecipazione attiva; verifica in modo ancora limitato comprensione e trasferibilità dei contenuti.
- **Principiante avanzato:** Adatta parzialmente linguaggio e tempi ai bisogni più evidenti; riconosce barriere frequenti ma necessita di supporto per pianificare interventi educativi più complessi.
- **Competente:** Accerta bisogni educativi, pianifica interventi graduati, utilizza verifiche di comprensione e rivaluta gli esiti nei casi ordinari con buona autonomia.
- **Abile:** Personalizza in profondità l'educazione in base a literacy, motivazione, fragilità, credenze e contesto familiare; trasforma il colloquio educativo in leva di aderenza e autonomia.
- **Esperto:** Costruisce veri percorsi educativi complessi, supporta colleghi nel gestire situazioni difficili e contribuisce a materiali, strumenti e modelli educativi del servizio.

ALL2 — Supportare avvio e mantenimento dell'allattamento materno monitorando attacco produzione e trasferimento di latte

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Nutrizione e supporto all'allattamento

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di supportare avvio e mantenimento dell'allattamento materno monitorando attacco produzione e trasferimento di latte nell'ambito di nutrizione e supporto all'allattamento. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare scarsa comprensione, bassa aderenza e difficoltà nell'autogestione. La sua corretta espressione produce maggiore autonomia, aderenza e partecipazione informata alle cure e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Attenzione alla relazione tra nutrizione, tolleranza clinica e recupero funzionale
- Attenzione alle dimensioni cliniche, relazionali e culturali che attraversano il percorso della donna
- Ascolto attivo e rispetto del livello di comprensione della persona e della famiglia

Motivazioni

- Preservare stato nutrizionale, crescita o recupero evitando complicanze da intake inadeguato
- Sostenere sicurezza, autonomia informata e continuità lungo gravidanza, parto e puerperio
- Favorire consapevolezza e partecipazione attiva della persona al percorso di cura

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di supportare avvio e mantenimento dell'allattamento materno monitorando attacco produzione e trasferimento di latte
- Monitorare attacco produzione e trasferimento di latte
- Valutare tolleranza, introiti, pattern alimentare e necessità di adattamento del supporto nutrizionale
- Osservare attacco, trasferimento di latte, coordinazione suzione-deglutizione-respirazione e segni di efficacia della poppata

Conoscenze

- Fabbisogni nutrizionali, controindicazioni, sicurezza dell'alimentazione enterale e segnali di intolleranza
- Fisiologia della lattazione, segnali di poppata efficace, difficoltà di attacco e sostegno alla diade
- Fisiologia e rischio ostetrico-ginecologico, educazione alla donna/coppia e continuità del percorso nascita
- Lattazione, valutazione della poppata, alimentazione alternativa e tolleranza nutrizionale neonatale
- Principi di educazione terapeutica, health literacy e apprendimento degli adulti

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Fornisce informazioni essenziali seguendo indicazioni e materiali disponibili nella personalizzazione dei messaggi, nella verifica della comprensione e nel sostegno all'autonomia; verifica in modo ancora limitato comprensione e trasferibilità dei contenuti.
- **Principiante avanzato:** Adatta parzialmente linguaggio e tempi ai bisogni più evidenti; riconosce barriere frequenti ma necessita di supporto per pianificare interventi educativi più complessi.
- **Competente:** Accerta bisogni educativi, pianifica interventi graduati, utilizza verifiche di comprensione e rivaluta gli esiti nei casi ordinari con buona autonomia.
- **Abile:** Personalizza in profondità l'educazione in base a literacy, motivazione, fragilità, credenze e contesto familiare; trasforma il colloquio educativo in leva di aderenza e autonomia.
- **Esperto:** Costruisce veri percorsi educativi complessi, supporta colleghi nel gestire situazioni difficili e contribuisce a materiali, strumenti e modelli educativi del servizio.

ALL3 — Gestire alimentazione alternativa in caso di difficoltà neonatali garantendo sicurezza e adeguato apporto nutrizionale

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Nutrizione e supporto all'allattamento

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire alimentazione alternativa in caso di difficoltà neonatali garantendo sicurezza e adeguato apporto nutrizionale nell'ambito di nutrizione e supporto all'allattamento. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare scarsa comprensione, bassa aderenza e difficoltà nell'autogestione. La sua corretta espressione produce maggiore autonomia, aderenza e partecipazione informata alle cure e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Attenzione alla relazione tra nutrizione, tolleranza clinica e recupero funzionale
- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Ascolto attivo e rispetto del livello di comprensione della persona e della famiglia

Motivazioni

- Preservare stato nutrizionale, crescita o recupero evitando complicanze da intake inadeguato
- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Favorire consapevolezza e partecipazione attiva della persona al percorso di cura

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire alimentazione alternativa in caso di difficoltà neonatali garantendo sicurezza e adeguato apporto nutrizionale
- Garantire sicurezza e adeguato apporto nutrizionale
- Valutare tolleranza, introiti, pattern alimentare e necessità di adattamento del supporto nutrizionale
- Accertare bisogni educativi, barriere e risorse di apprendimento

Conoscenze

- Fabbisogni nutrizionali, controindicazioni, sicurezza dell'alimentazione enterale e segnali di intolleranza
- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della cure neonatale
- Lattazione, valutazione della poppata, alimentazione alternativa e tolleranza nutrizionale neonatale
- Principi di educazione terapeutica, health literacy e apprendimento degli adulti
- Strumenti di teaching, teach-back e rinforzo dell'aderenza/autogestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Fornisce informazioni essenziali seguendo indicazioni e materiali disponibili nella costruzione di comprensione, aderenza e partecipazione attiva; verifica in modo ancora limitato comprensione e trasferibilità dei contenuti.
- **Principiante avanzato:** Adatta parzialmente linguaggio e tempi ai bisogni più evidenti; riconosce barriere frequenti ma necessita di supporto per pianificare interventi educativi più complessi.
- **Competente:** Accerta bisogni educativi, pianifica interventi graduati, utilizza verifiche di comprensione e rivaluta gli esiti nei casi ordinari con buona autonomia.
- **Abile:** Personalizza in profondità l'educazione in base a literacy, motivazione, fragilità, credenze e contesto familiare; trasforma il colloquio educativo in leva di aderenza e autonomia.
- **Esperto:** Costruisce veri percorsi educativi complessi, supporta colleghi nel gestire situazioni difficili e contribuisce a materiali, strumenti e modelli educativi del servizio.

ALL4 — Gestire nutrizione enterale mediante sondino valutando tolleranza e residui gastrici

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Nutrizione e supporto all'allattamento

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire nutrizione enterale mediante sondino valutando tolleranza e residui gastrici nell'ambito di nutrizione e supporto all'allattamento. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare scarsa comprensione, bassa aderenza e difficoltà nell'autogestione. La sua corretta espressione produce maggiore autonomia, aderenza e partecipazione informata alle cure e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Attenzione alla relazione tra nutrizione, tolleranza clinica e recupero funzionale
- Ascolto attivo e rispetto del livello di comprensione della persona e della famiglia
- Flessibilità comunicativa nel modulare linguaggio, tempi e strumenti educativi

Motivazioni

- Preservare stato nutrizionale, crescita o recupero evitando complicanze da intake inadeguato
- Favorire consapevolezza e partecipazione attiva della persona al percorso di cura
- Ridurre errori, riacutizzazioni e dipendenza evitabile attraverso un apprendimento efficace

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire nutrizione enterale mediante sondino valutando tolleranza e residui gastrici
- Valutare tolleranza e residui gastrici
- Valutare tolleranza, introiti, pattern alimentare e necessità di adattamento del supporto nutrizionale
- Accertare bisogni educativi, barriere e risorse di apprendimento

Conoscenze

- Fabbisogni nutrizionali, controindicazioni, sicurezza dell'alimentazione enterale e segnali di intolleranza
- Lattazione, valutazione della poppata, alimentazione alternativa e tolleranza nutrizionale neonatale
- Principi di educazione terapeutica, health literacy e apprendimento degli adulti
- Strumenti di teaching, teach-back e rinforzo dell'aderenza/autogestione
- Fattori culturali, cognitivi ed emotivi che influenzano la comprensione e l'autocura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Fornisce informazioni essenziali seguendo indicazioni e materiali disponibili nella costruzione di comprensione, aderenza e partecipazione attiva; verifica in modo ancora limitato comprensione e trasferibilità dei contenuti.

- **Principiante avanzato:** Adatta parzialmente linguaggio e tempi ai bisogni più evidenti; riconosce barriere frequenti ma necessita di supporto per pianificare interventi educativi più complessi.
- **Competente:** Accerta bisogni educativi, pianifica interventi graduati, utilizza verifiche di comprensione e rivaluta gli esiti nei casi ordinari con buona autonomia.
- **Abile:** Personalizza in profondità l'educazione in base a literacy, motivazione, fragilità, credenze e contesto familiare; trasforma il colloquio educativo in leva di aderenza e autonomia.
- **Esperto:** Costruisce veri percorsi educativi complessi, supporta colleghi nel gestire situazioni difficili e contribuisce a materiali, strumenti e modelli educativi del servizio.

Monitoraggio clinico e prevenzione complicanze

MNEO1 — Monitorare glicemia neonatale identificando precocemente ipoglicemia

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Monitoraggio clinico e prevenzione complicanze

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare glicemia neonatale identificando precocemente ipoglicemia nell'ambito di monitoraggio clinico e prevenzione complicanze. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare glicemia neonatale identificando precocemente ipoglicemia
- Identificare precocemente ipoglicemia
- Riconoscere precocemente deviazioni dell'adattamento neonatale e attivare rivalutazione/escalation
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto

Conoscenze

- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della care neonatale
- Soglie cliniche per ipoglicemia/ittero/instabilità, distress respiratorio e monitoraggio del late preterm
- Fisiopatologia del postoperatorio, scale di dolore/PONV e criteri di deterioramento clinico
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.

- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

MNEO2 — Valutare e gestire rischio di ittero neonatale interpretando valori di bilirubina secondo età post-natale

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Monitoraggio clinico e prevenzione complicanze

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare e gestire rischio di ittero neonatale interpretando valori di bilirubina secondo età post-natale nell'ambito di monitoraggio clinico e prevenzione complicanze. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare e gestire rischio di ittero neonatale interpretando valori di bilirubina secondo età post-natale
- Interpretare valori di bilirubina secondo età post-natale
- Riconoscere precocemente deviazioni dell'adattamento neonatale e attivare rivalutazione/escalation
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto

Conoscenze

- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della cure neonatale
- Soglie cliniche per ipoglicemia/ittero/instabilità, distress respiratorio e monitoraggio del late preterm
- Fisiopatologia del postoperatorio, scale di dolore/PONV e criteri di deterioramento clinico
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.

- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

MNEO3 — Riconoscere e gestire episodi di instabilità metabolica o termica

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Monitoraggio clinico e prevenzione complicanze

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere e gestire episodi di instabilità metabolica o termica nell'ambito di monitoraggio clinico e prevenzione complicanze. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend
- Freddezza operativa nelle situazioni a rapida evoluzione

Motivazioni

- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita
- Ricercare una lettura sempre più fine del quadro clinico per sostenere decisioni assistenziali tempestive

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere e gestire episodi di instabilità metabolica o termica
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione
- Documentare tempestivamente anomalie, trend e interventi attuati

Conoscenze

- Fisiopatologia del postoperatorio, scale di dolore/PONV e criteri di deterioramento clinico
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.

- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

MNEO4 — Riconoscere segni di infezione neonatale attivando tempestivamente valutazione medica

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Monitoraggio clinico e prevenzione complicanze

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere segni di infezione neonatale attivando tempestivamente valutazione medica nell'ambito di monitoraggio clinico e prevenzione complicanze. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Disciplina nell'applicazione di bundle e misure di prevenzione anche quando il rischio sembra basso
- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi

Motivazioni

- Evitare eventi infettivi che aumentano esiti avversi, tempi di degenza e sofferenza evitabile
- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere segni di infezione neonatale attivando tempestivamente valutazione medica
- Attivare tempestivamente valutazione medica
- Controllare punti critici di asepsi, profilassi, gestione dispositivi e sorveglianza dei segni di infezione
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto

Conoscenze

- SSI, misure di asepsi/antisepsi, bundle prevenzione infezioni e sorveglianza delle complicanze sistemiche
- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della cure neonatale
- Fisiopatologia del postoperatorio, scale di dolore/PONV e criteri di deterioramento clinico
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.

- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

MNE05 — Monitorare parametri cardio-respiratori in neonato late preterm o patologico stabile utilizzando monitor multiparametrici

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Monitoraggio clinico e prevenzione complicanze

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare parametri cardio-respiratori in neonato late preterm o patologico stabile utilizzando monitor multiparametrici nell'ambito di monitoraggio clinico e prevenzione complicanze. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Orientamento alle potenzialità della persona e del contesto di vita
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi

Motivazioni

- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Spostare il focus dal solo contenimento del sintomo alla partecipazione e alla cittadinanza possibile
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare parametri cardio-respiratori in neonato late preterm o patologico stabile utilizzando monitor multiparametrici
- Utilizzare monitor multiparametrici
- Riconoscere pattern di tossicità acuta/tardiva e attivare escalation secondo grading e severità
- Costruire obiettivi riabilitativi, lavorare con rete e attivare risorse comunitarie

Conoscenze

- CTCAE o sistemi analoghi di grading, late effects, triage tossicità e criteri di invio specialistico
- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della care neonatale
- Recovery, riabilitazione psicosociale, gruppi terapeutici, rete formale/informale e prevenzione ricadute
- Fisiopatologia del postoperatorio, scale di dolore/PONV e criteri di deterioramento clinico
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

MNE06 — Interpretare segni precoci di distress respiratorio apnea e instabilità emodinamica

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Monitoraggio clinico e prevenzione complicanze

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di interpretare segni precoci di distress respiratorio apnea e instabilità emodinamica nell'ambito di monitoraggio clinico e prevenzione complicanze. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend
- Freddezza operativa nelle situazioni a rapida evoluzione

Motivazioni

- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita
- Ricercare una lettura sempre più fine del quadro clinico per sostenere decisioni assistenziali tempestive

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di interpretare segni precoci di distress respiratorio apnea e instabilità emodinamica
- Riconoscere precocemente deviazioni dell'adattamento neonatale e attivare rivalutazione/escalation
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione

Conoscenze

- Soglie cliniche per ipoglicemia/ittero/instabilità, distress respiratorio e monitoraggio del late preterm
- Fisiopatologia del postoperatorio, scale di dolore/PONV e criteri di deterioramento clinico
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.

- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

Screening e procedure neonatali

SCR1 — Eseguire e garantire corretta tracciabilità degli screening neonatali metabolici uditivi e cardiologici

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Screening e procedure neonatali

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di eseguire e garantire corretta tracciabilità degli screening neonatali metabolici uditivi e cardiologici nell'ambito di screening e procedure neonatali. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di eseguire e garantire corretta tracciabilità degli screening neonatali metabolici uditivi e cardiologici
- Eseguire screening/profilassi secondo tempi, tecniche e standard di tracciabilità
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza
- Eseguire i passaggi tecnici con sequenza corretta e controllo degli esiti immediati

Conoscenze

- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della cure neonatale
- Finestre temporali, requisiti tecnici e sistemi di sicurezza identificativa madre-neonato
- Screening metabolico/uditivo/cardiologico, profilassi neonatali e sistemi identificativi madre-neonato
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.
- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

SCR2 — Preparare e assistere a procedure neonatali quali profilassi vitamina K e profilassi oculare secondo protocolli

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Screening e procedure neonatali

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di preparare e assistere a procedure neonatali quali profilassi vitamina K e profilassi oculare secondo protocolli nell'ambito di screening e procedure neonatali. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di preparare e assistere a procedure neonatali quali profilassi vitamina K e profilassi oculare secondo protocolli
- Eseguire screening/profilassi secondo tempi, tecniche e standard di tracciabilità
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza
- Eseguire i passaggi tecnici con sequenza corretta e controllo degli esiti immediati

Conoscenze

- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della cure neonatale
- Finestre temporali, requisiti tecnici e sistemi di sicurezza identificativa madre-neonato
- Screening metabolico/uditivo/cardiologico, profilassi neonatali e sistemi identificativi madre-neonato
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

SCR3 — Gestire correttamente identificazione anagrafica e sistemi di sicurezza madre-neonato

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Screening e procedure neonatali

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire correttamente identificazione anagrafica e sistemi di sicurezza madre-neonato nell'ambito di screening e procedure neonatali. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire correttamente identificazione anagrafica e sistemi di sicurezza madre-neonato
- Eseguire screening/profilassi secondo tempi, tecniche e standard di tracciabilità
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza
- Eseguire i passaggi tecnici con sequenza corretta e controllo degli esiti immediati

Conoscenze

- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della cura neonatale
- Finestre temporali, requisiti tecnici e sistemi di sicurezza identificativa madre-neonato
- Screening metabolico/uditivo/cardiologico, profilassi neonatali e sistemi identificativi madre-neonato
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

Valutazione clinica pediatrica avanzata

VALP1 — Valutare parametri vitali e segni clinici in relazione alle specificità fisiologiche delle diverse fasce di età

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Valutazione clinica pediatrica avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare parametri vitali e segni clinici in relazione alle specificità fisiologiche delle diverse fasce di età nell'ambito di valutazione clinica pediatrica avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Sensibilità ai bisogni emotivi e informativi espressi o impliciti
- Capacità di mantenere coerenza tra contenuto, tono e postura professionale
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi

Motivazioni

- Rendere comprensibile il percorso di cura e favorire scelte realmente consapevoli
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare parametri vitali e segni clinici in relazione alle specificità fisiologiche delle diverse fasce di età
- Verificare comprensione, dubbi, consenso e necessità di rinforzo informativo
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione

Conoscenze

- Principi di comunicazione efficace, decisione condivisa, consenso e adattamento del linguaggio
- Parametri età-specifici, scale pediatriche e riconoscimento del deterioramento nei bambini
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

VALP2 — Utilizzare scale validate per età per valutazione di dolore coscienza e stato clinico

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Valutazione clinica pediatrica avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di utilizzare scale validate per età per valutazione di dolore coscienza e stato clinico nell'ambito di valutazione clinica pediatrica avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile. Il controllo del dolore incide direttamente su mobilitazione, partecipazione alle cure, stabilità fisiologica e qualità dell'esperienza assistenziale.

Attitudini

- Sensibilità a un dolore non sempre esplicitato ma clinicamente rilevante
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Trattare il dolore come esito clinico da monitorare e non come effetto collaterale inevitabile
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di utilizzare scale validate per età per valutazione di dolore coscienza e stato clinico
- Utilizzare scale di valutazione del dolore, monitorare risposta analgesica e riconoscere effetti collaterali
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione

Conoscenze

- Fisiopatologia del dolore acuto, PCA, analgesia epidurale/peridurale e monitoraggio correlato
- Parametri età-specifici, scale pediatriche e riconoscimento del deterioramento nei bambini
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

Gestione terapeutica pediatrica

GESTP1 — Calcolare e somministrare terapie farmacologiche pediatriche in base a peso e superficie corporea

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Gestione terapeutica pediatrica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di calcolare e somministrare terapie farmacologiche pediatriche in base a peso e superficie corporea nell'ambito di gestione terapeutica pediatrica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Accuratezza estrema nel calcolo perché l'errore anche minimo ha impatto clinico rilevante
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Prevenire errori di dosaggio e adattare la terapia alla vulnerabilità età-correlata
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di calcolare e somministrare terapie farmacologiche pediatriche in base a peso e superficie corporea
- Verificare schema terapeutico, parametri di eleggibilità, protezioni, preparazione e somministrazione sicura
- Calcolare dosi/volumi in base a peso, superficie corporea e condizioni cliniche
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza

Conoscenze

- Vescicanti/irritanti, BSA o criteri prescrittivi, DPI, closed system e gestione dell'extravasazione
- Farmacocinetica pediatrica, formule di dosaggio, fluidi di mantenimento e fattori di rischio di errore
- Calcolo dosaggi pediatrici, fluidoterapia, ossigenoterapia/CPAP, accessi e vulnerabilità età-correlata
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella corretta gestione del trattamento, nella prevenzione del rischio e nel monitoraggio della risposta; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.
- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

GESTP2 — Gestire fluidoterapia pediatrica modulando volumi e velocità in base al fabbisogno età-correlato

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Gestione terapeutica pediatrica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire fluidoterapia pediatrica modulando volumi e velocità in base al fabbisogno età-correlato nell'ambito di gestione terapeutica pediatrica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Accuratezza estrema nel calcolo perché l'errore anche minimo ha impatto clinico rilevante
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Prevenire errori di dosaggio e adattare la terapia alla vulnerabilità età-correlata
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire fluidoterapia pediatrica modulando volumi e velocità in base al fabbisogno età-correlato
- Modulare volumi e velocità in base al fabbisogno età-correlato
- Calcolare dosi/volumi in base a peso, superficie corporea e condizioni cliniche
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza

Conoscenze

- Farmacocinetica pediatrica, formule di dosaggio, fluidi di mantenimento e fattori di rischio di errore
- Calcolo dosaggi pediatrici, fluidoterapia, ossigenoterapia/CPAP, accessi e vulnerabilità età-correlata
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

GESTP3 — Adattare dispositivi e presidi alle caratteristiche anatomiche pediatriche

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Gestione terapeutica pediatrica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di adattare dispositivi e presidi alle caratteristiche anatomiche pediatriche nell'ambito di gestione terapeutica pediatrica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Accuratezza estrema nel calcolo perché l'errore anche minimo ha impatto clinico rilevante
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Prevenire errori di dosaggio e adattare la terapia alla vulnerabilità età-correlata
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di adattare dispositivi e presidi alle caratteristiche anatomiche pediatriche
- Calcolare dosi/volumi in base a peso, superficie corporea e condizioni cliniche
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza
- Monitorare efficacia clinica e comparsa di eventi avversi o tossicità

Conoscenze

- Farmacocinetica pediatrica, formule di dosaggio, fluidi di mantenimento e fattori di rischio di errore
- Calcolo dosaggi pediatrici, fluidoterapia, ossigenoterapia/CPAP, accessi e vulnerabilità età-correlata
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.
- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.

- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

GESTP4 — Preparare e assistere a procedure diagnostiche e terapeutiche pediatriche garantendo sicurezza

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Gestione terapeutica pediatrica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di preparare e assistere a procedure diagnostiche e terapeutiche pediatriche garantendo sicurezza nell'ambito di gestione terapeutica pediatrica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Accuratezza estrema nel calcolo perché l'errore anche minimo ha impatto clinico rilevante
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Prevenire errori di dosaggio e adattare la terapia alla vulnerabilità età-correlata
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di preparare e assistere a procedure diagnostiche e terapeutiche pediatriche garantendo sicurezza
- Calcolare dosi/volumi in base a peso, superficie corporea e condizioni cliniche
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza
- Monitorare efficacia clinica e comparsa di eventi avversi o tossicità

Conoscenze

- Farmacocinetica pediatrica, formule di dosaggio, fluidi di mantenimento e fattori di rischio di errore
- Calcolo dosaggi pediatrici, fluidoterapia, ossigenoterapia/CPAP, accessi e vulnerabilità età-correlata
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

GESTP5 — Prevenire errori di dosaggio farmacologico e eventi avversi correlati a vulnerabilità pediatrica

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Gestione terapeutica pediatrica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di prevenire errori di dosaggio farmacologico e eventi avversi correlati a vulnerabilità pediatrica nell'ambito di gestione terapeutica pediatrica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Sguardo allargato ai determinanti sociali e ambientali della salute
- Accuratezza estrema nel calcolo perché l'errore anche minimo ha impatto clinico rilevante
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici

Motivazioni

- Intercettare precocemente fragilità che tendono a restare invisibili ai servizi
- Prevenire errori di dosaggio e adattare la terapia alla vulnerabilità età-correlata
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di prevenire errori di dosaggio farmacologico e eventi avversi correlati a vulnerabilità pediatrica
- Leggere dati di popolazione e segnali di vulnerabilità per orientare interventi mirati
- Riconoscere pattern di tossicità acuta/tardiva e attivare escalation secondo grading e severità
- Calcolare dosi/volumi in base a peso, superficie corporea e condizioni cliniche

Conoscenze

- Epidemiologia di comunità, indicatori di vulnerabilità, reti territoriali e meccanismi di tutela
- CTCAE o sistemi analoghi di grading, late effects, triage tossicità e criteri di invio specialistico
- Farmacocinetica pediatrica, formule di dosaggio, fluidi di mantenimento e fattori di rischio di errore
- Calcolo dosaggi pediatrici, fluidoterapia, ossigenoterapia/CPAP, accessi e vulnerabilità età-correlata
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella corretta gestione del trattamento, nella prevenzione del rischio e nel monitoraggio della risposta; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

GESTP6 — Riconoscere precocemente segni di deterioramento clinico pediatrico attivando escalation appropriata

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Gestione terapeutica pediatrica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere precocemente segni di deterioramento clinico pediatrico attivando escalation appropriata nell'ambito di gestione terapeutica pediatrica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Accuratezza estrema nel calcolo perché l'errore anche minimo ha impatto clinico rilevante
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Prevenire errori di dosaggio e adattare la terapia alla vulnerabilità età-correlata
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere precocemente segni di deterioramento clinico pediatrico attivando escalation appropriata
- Attivare escalation appropriata
- Calcolare dosi/volumi in base a peso, superficie corporea e condizioni cliniche
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza

Conoscenze

- Farmacocinetica pediatrica, formule di dosaggio, fluidi di mantenimento e fattori di rischio di errore
- Calcolo dosaggi pediatrici, fluidoterapia, ossigenoterapia/CPAP, accessi e vulnerabilità età-correlata
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

GESTP7 — Gestire ossigenoterapia e CPAP neonatale modulando FiO2 e pressione secondo risposta clinica

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Gestione terapeutica pediatrica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire ossigenoterapia e CPAP neonatale modulando FiO2 e pressione secondo risposta clinica nell'ambito di gestione terapeutica pediatrica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Attenzione simultanea a comfort, meccanica ventilatoria e sicurezza del supporto respiratorio
- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici

Motivazioni

- Prevenire ipossia, ventilazione inadeguata e complicanze correlate al supporto respiratorio
- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire ossigenoterapia e CPAP neonatale modulando FiO2 e pressione secondo risposta clinica
- Modulare fiO2 e pressione secondo risposta clinica
- Impostare o assistere i settaggi respiratori, verificare interfacce/circuiti e monitorare tolleranza/efficacia
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza

Conoscenze

- Fisiologia respiratoria, FiO2, PEEP, curve ventilatorie, criteri di fallimento NIV e sicurezza vie aeree
- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della care neonatale
- Calcolo dosaggi pediatrici, fluidoterapia, ossigenoterapia/CPAP, accessi e vulnerabilità età-correlata
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

GESTP8 — Monitorare efficacia del supporto respiratorio prevenendo complicanze correlate

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Gestione terapeutica pediatrica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare efficacia del supporto respiratorio prevenendo complicanze correlate nell'ambito di gestione terapeutica pediatrica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati
- Disciplina nell'aderire a protocolli, doppie verifiche e tracciabilità

Motivazioni

- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili
- Contribuire alla continuità terapeutica attraverso una gestione affidabile della terapia

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare efficacia del supporto respiratorio prevenendo complicanze correlate
- Prevenire complicanze correlate
- Riconoscere pattern di tossicità acuta/tardiva e attivare escalation secondo grading e severità
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza

Conoscenze

- CTCAE o sistemi analoghi di grading, late effects, triage tossicità e criteri di invio specialistico
- Calcolo dosaggi pediatrici, fluidoterapia, ossigenoterapia/CPAP, accessi e vulnerabilità età-correlata
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

GESTP9 — Gestire nutrizione enterale mediante sondino valutando tolleranza e residui gastrici

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Gestione terapeutica pediatrica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire nutrizione enterale mediante sondino valutando tolleranza e residui gastrici nell'ambito di gestione terapeutica pediatrica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Attenzione alla relazione tra nutrizione, tolleranza clinica e recupero funzionale
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Preservare stato nutrizionale, crescita o recupero evitando complicanze da intake inadeguato
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire nutrizione enterale mediante sondino valutando tolleranza e residui gastrici
- Valutare tolleranza e residui gastrici
- Valutare tolleranza, introiti, pattern alimentare e necessità di adattamento del supporto nutrizionale
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza

Conoscenze

- Fabbisogni nutrizionali, controindicazioni, sicurezza dell'alimentazione enterale e segnali di intolleranza
- Calcolo dosaggi pediatrici, fluidoterapia, ossigenoterapia/CPAP, accessi e vulnerabilità età-correlata
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

GESTP10 — Monitorare crescita ponderale e bilancio idrico in neonato pretermine

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Gestione terapeutica pediatrica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare crescita ponderale e bilancio idrico in neonato pretermine nell'ambito di gestione terapeutica pediatrica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Orientamento alle potenzialità della persona e del contesto di vita
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici

Motivazioni

- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Spostare il focus dal solo contenimento del sintomo alla partecipazione e alla cittadinanza possibile
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare crescita ponderale e bilancio idrico in neonato pretermine
- Costruire obiettivi riabilitativi, lavorare con rete e attivare risorse comunitarie
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza
- Monitorare efficacia clinica e comparsa di eventi avversi o tossicità

Conoscenze

- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della cure neonatale
- Recovery, riabilitazione psicosociale, gruppi terapeutici, rete formale/informale e prevenzione ricadute
- Calcolo dosaggi pediatrici, fluidoterapia, ossigenoterapia/CPAP, accessi e vulnerabilità età-correlata
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

GESTP11 — Gestire accessi venosi periferici e centrali neonatali prevenendo complicanze infettive e meccaniche

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Gestione terapeutica pediatrica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire accessi venosi periferici e centrali neonatali prevenendo complicanze infettive e meccaniche nell'ambito di gestione terapeutica pediatrica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire accessi venosi periferici e centrali neonatali prevenendo complicanze infettive e meccaniche
- Prevenire complicanze infettive e meccaniche
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza
- Monitorare efficacia clinica e comparsa di eventi avversi o tossicità

Conoscenze

- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della cure neonatale
- Calcolo dosaggi pediatrici, fluidoterapia, ossigenoterapia/CPAP, accessi e vulnerabilità età-correlata
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

GESTP12 — Riconoscere e gestire episodi di instabilità metabolica o termica nel neonato ricoverato

Area/Pannello: Area Materno-Infantile / Dimensione: Gestione terapeutica pediatrica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere e gestire episodi di instabilità metabolica o termica nel neonato ricoverato nell'ambito di gestione terapeutica pediatrica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Materno-Infantile.

Attitudini

- Delicatezza osservativa nel cogliere segni clinici sottili in soggetti ad alta vulnerabilità
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Sostenere adattamento fisiologico, legame precoce e sicurezza del neonato e della famiglia
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere e gestire episodi di instabilità metabolica o termica nel neonato ricoverato
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza
- Monitorare efficacia clinica e comparsa di eventi avversi o tossicità
- Educare persona assistita e caregiver agli aspetti critici della terapia quando pertinente

Conoscenze

- Adattamento cardio-respiratorio neonatale, termoregolazione, bonding e organizzazione della cure neonatale
- Calcolo dosaggi pediatrici, fluidoterapia, ossigenoterapia/CPAP, accessi e vulnerabilità età-correlata
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

Valutazione e stewardship del patrimonio venoso

STW1 — Eseguire valutazione sistematica del patrimonio venoso mediante ispezione palpazione ed ecografia vascolare

Area/Pannello: Impianto di Accessi Vascolari / Dimensione: Valutazione e stewardship del patrimonio venoso

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di eseguire valutazione sistematica del patrimonio venoso mediante ispezione palpazione ed ecografia vascolare nell'ambito di valutazione e stewardship del patrimonio venoso. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari.

Attitudini

- Cura del patrimonio venoso come bene clinico da preservare nel tempo
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Scegliere il device meno invasivo ma adeguato per ridurre fallimenti e consumo venoso evitabile
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di eseguire valutazione sistematica del patrimonio venoso mediante ispezione palpazione ed ecografia vascolare
- Utilizzare l'ecografia e i riferimenti anatomici/tecnici per guidare impianto e verifica
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione

Conoscenze

- Stewardship venosa, scelta del device, ecoguida, Seldinger, conferma punta e complicanze meccaniche/infettive
- Anatomia ecografica, asse corto/lungo, needle visualization e prevenzione delle complicanze immediate
- Ecografia vascolare, algoritmi di scelta del device, stewardship venosa e rischio trombotico/infettivo

- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

STW2 — Applicare algoritmi decisionali per la scelta dell'accesso venoso più appropriato in relazione a terapia durata e caratteristiche cliniche

Area/Pannello: Impianto di Accessi Vascolari / Dimensione: Valutazione e stewardship del patrimonio venoso

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di applicare algoritmi decisionali per la scelta dell'accesso venoso più appropriato in relazione a terapia durata e caratteristiche cliniche nell'ambito di valutazione e stewardship del patrimonio venoso. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari.

Attitudini

- Sensibilità ai bisogni emotivi e informativi espressi o impliciti
- Capacità di mantenere coerenza tra contenuto, tono e postura professionale
- Cura del patrimonio venoso come bene clinico da preservare nel tempo

Motivazioni

- Rendere comprensibile il percorso di cura e favorire scelte realmente consapevoli
- Scegliere il device meno invasivo ma adeguato per ridurre fallimenti e consumo venoso evitabile
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di applicare algoritmi decisionali per la scelta dell'accesso venoso più appropriato in relazione a terapia durata e caratteristiche cliniche
- Verificare comprensione, dubbi, consenso e necessità di rinforzo informativo
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione

Conoscenze

- Principi di comunicazione efficace, decisione condivisa, consenso e adattamento del linguaggio
- Stewardship venosa, scelta del device, ecoguida, Seldinger, conferma punta e complicanze meccaniche/infettive
- Ecografia vascolare, algoritmi di scelta del device, stewardship venosa e rischio trombotico/infettivo
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nel modulare la relazione, contenere il rischio e scegliere il livello di intervento più adeguato; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

STW3 — Preservare il patrimonio venoso prevenendo inserimenti ripetuti e selezionando dispositivi a minor impatto vascolare

Area/Pannello: Impianto di Accessi Vascolari / Dimensione: Valutazione e stewardship del patrimonio venoso

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di preservare il patrimonio venoso prevenendo inserimenti ripetuti e selezionando dispositivi a minor impatto vascolare nell'ambito di valutazione e stewardship del patrimonio venoso. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari.

Attitudini

- Cura del patrimonio venoso come bene clinico da preservare nel tempo
- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend

Motivazioni

- Scegliere il device meno invasivo ma adeguato per ridurre fallimenti e consumo venoso evitabile
- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di preservare il patrimonio venoso prevenendo inserimenti ripetuti e selezionando dispositivi a minor impatto vascolare
- Prevenire inserimenti ripetuti
- Selezionare dispositivi a minor impatto vascolare
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto

Conoscenze

- Stewardship venosa, scelta del device, ecoguida, Seldinger, conferma punta e complicanze meccaniche/infettive
- Ecografia vascolare, algoritmi di scelta del device, stewardship venosa e rischio trombotico/infettivo
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'osservazione clinica, nell'interpretazione dei segnali e nell'escalation tempestiva; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.
- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

STW4 — Valutare indicazioni controindicazioni e rischio trombotico o infettivo prima dell'impianto

Area/Pannello: Impianto di Accessi Vascolari / Dimensione: Valutazione e stewardship del patrimonio venoso

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare indicazioni controindicazioni e rischio trombotico o infettivo prima dell'impianto nell'ambito di valutazione e stewardship del patrimonio venoso. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare ritardi nel riconoscimento del deterioramento, sottostima dei trend e attivazione tardiva dell'escalation. La sua corretta espressione produce valutazione tempestiva, stabilità clinica e decisioni assistenziali più precoci e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari.

Attitudini

- Vigilanza clinica costante e attenzione ai cambiamenti minimi
- Rigore nell'osservazione, nella misurazione e nel confronto con i trend
- Freddezza operativa nelle situazioni a rapida evoluzione

Motivazioni

- Prevenire il deterioramento evitabile attraverso un riconoscimento tempestivo dei segnali precoci
- Mantenere un elevato senso di responsabilità verso la stabilità clinica della persona assistita
- Ricercare una lettura sempre più fine del quadro clinico per sostenere decisioni assistenziali tempestive

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare indicazioni controindicazioni e rischio trombotico o infettivo prima dell'impianto
- Rilevare dati clinici in modo accurato e confrontarli con i valori attesi per il contesto
- Integrare parametri, osservazione diretta e risposta ai trattamenti nella rivalutazione
- Documentare tempestivamente anomalie, trend e interventi attuati

Conoscenze

- Ecografia vascolare, algoritmi di scelta del device, stewardship venosa e rischio trombotico/infettivo
- Principi di fisiopatologia rilevanti per interpretare segni, sintomi e parametri
- Scale, score e strumenti di monitoraggio pertinenti all'area clinica
- Criteri di escalation clinica e attivazione dei percorsi di sicurezza

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Rileva i dati richiesti e applica protocolli e check-list nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; riconosce soprattutto pattern tipici e necessita di supervisione nella lettura del significato complessivo.

- **Principiante avanzato:** Coglie alcune anomalie ricorrenti e collega segni/parametri ai problemi più frequenti; rivaluta con maggiore metodo ma richiede confronto nei quadri meno lineari.
- **Competente:** Pianifica il monitoraggio, interpreta trend e priorità assistenziali nei casi ordinari, attiva tempestivamente escalation e documenta in modo completo gli esiti.
- **Abile:** Legge il quadro in modo integrato, anticipa possibili evoluzioni e modula intensità del monitoraggio/intervento in base a rischio, risposta clinica e contesto.
- **Esperto:** Riconosce precocemente configurazioni atipiche, orienta il team nella lettura dei segnali critici e contribuisce a raffinare criteri operativi e standard dell'unità.

Tecniche di impianto accessi venosi periferici

IMP1 — Posizionare cateteri venosi periferici corti utilizzando tecnica asettica avanzata e corretta scelta di calibro e sede

Area/Pannello: Impianto di Accessi Vascolari / Dimensione: Tecniche di impianto accessi venosi periferici

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di posizionare cateteri venosi periferici corti utilizzando tecnica asettica avanzata e corretta scelta di calibro e sede nell'ambito di tecniche di impianto accessi venosi periferici. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari.

Attitudini

- Disciplina nell'applicazione di bundle e misure di prevenzione anche quando il rischio sembra basso
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Evitare eventi infettivi che aumentano esiti avversi, tempi di degenza e sofferenza evitabile
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di posizionare cateteri venosi periferici corti utilizzando tecnica asettica avanzata e corretta scelta di calibro e sede
- Utilizzare tecnica asettica avanzata e corretta scelta di calibro e sede
- Controllare punti critici di asepsi, profilassi, gestione dispositivi e sorveglianza dei segni di infezione
- Allestire campo sterile avanzato e mantenere asepsi lungo tutta la procedura

Conoscenze

- SSI, misure di asepsi/antisepsi, bundle prevenzione infezioni e sorveglianza delle complicanze sistemiche
- Barriere massimali, antisepsi cutanea, tempi di contatto e prevenzione CLABSI
- Tecnica asettica, scelta di calibro/sede, ecoguida periferica e prevenzione del dolore/trauma
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.
- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

IMP2 — Eseguire inserimento ecoguidato di accessi periferici difficili garantendo visualizzazione diretta del vaso

Area/Pannello: Impianto di Accessi Vascolari / Dimensione: Tecniche di impianto accessi venosi periferici

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di eseguire inserimento ecoguidato di accessi periferici difficili garantendo visualizzazione diretta del vaso nell'ambito di tecniche di impianto accessi venosi periferici. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari.

Attitudini

- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione
- Attenzione continua alla sterilità, alla sicurezza e ai dettagli esecutivi

Motivazioni

- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione
- Consolidare padronanza tecnica come forma di tutela clinica e professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di eseguire inserimento ecoguidato di accessi periferici difficili garantendo visualizzazione diretta del vaso
- Garantire visualizzazione diretta del vaso
- Utilizzare l'ecografia e i riferimenti anatomici/tecnicici per guidare impianto e verifica
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza

Conoscenze

- Anatomia ecografica, asse corto/lungo, needle visualization e prevenzione delle complicanze immediate
- Tecnica asettica, scelta di calibro/sede, ecoguida periferica e prevenzione del dolore/trauma
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità
- Complicanze immediate e tardive, con relative strategie di prevenzione e gestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

IMP3 — Applicare analgesia locale e tecniche atraumatiche per ridurre dolore e complicanze meccaniche

Area/Pannello: Impianto di Accessi Vascolari / Dimensione: Tecniche di impianto accessi venosi periferici

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di applicare analgesia locale e tecniche atraumatiche per ridurre dolore e complicanze meccaniche nell'ambito di tecniche di impianto accessi venosi periferici. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari. Il controllo del dolore incide direttamente su mobilitazione, partecipazione alle cure, stabilità fisiologica e qualità dell'esperienza assistenziale.

Attitudini

- Sensibilità a un dolore non sempre esplicitato ma clinicamente rilevante
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Trattare il dolore come esito clinico da monitorare e non come effetto collaterale inevitabile
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di applicare analgesia locale e tecniche atraumatiche per ridurre dolore e complicanze meccaniche
- Utilizzare scale di valutazione del dolore, monitorare risposta analgesica e riconoscere effetti collaterali
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza
- Eseguire i passaggi tecnici con sequenza corretta e controllo degli esiti immediati

Conoscenze

- Fisiopatologia del dolore acuto, PCA, analgesia epidurale/peridurale e monitoraggio correlato
- Tecnica asettica, scelta di calibro/sede, ecoguida periferica e prevenzione del dolore/trauma
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità
- Complicanze immediate e tardive, con relative strategie di prevenzione e gestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

Tecniche di impianto accessi venosi centrali ad inserzione periferica

IMP4 — Eseguire posizionamento ecoguidato di PICC garantendo identificazione anatomica e riduzione del rischio di complicanze immediate

Area/Pannello: Impianto di Accessi Vascolari | Dimensione: Tecniche di impianto accessi venosi centrali ad inserzione periferica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di eseguire posizionamento ecoguidato di PICC garantendo identificazione anatomica e riduzione del rischio di complicanze immediate nell'ambito di tecniche di impianto accessi venosi centrali ad inserzione periferica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari.

Attitudini

- Cura del patrimonio venoso come bene clinico da preservare nel tempo
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Scegliere il device meno invasivo ma adeguato per ridurre fallimenti e consumo venoso evitabile
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di eseguire posizionamento ecoguidato di PICC garantendo identificazione anatomica e riduzione del rischio di complicanze immediate
- Garantire identificazione anatomica e riduzione del rischio di complicanze immediate
- Utilizzare l'ecografia e i riferimenti anatomici/tecnici per guidare impianto e verifica
- Proteggere l'assistito durante posizionamento, sedazione e fase intra-procedurale con monitoraggio attivo

Conoscenze

- Stewardship venosa, scelta del device, ecoguida, Seldinger, conferma punta e complicanze meccaniche/infettive
- Anatomia ecografica, asse corto/lungo, needle visualization e prevenzione delle complicanze immediate
- Rischi da posizionamento, monitoraggio in sedazione, prevenzione lesioni e gestione eventi critici di sala
- Anatomia ecografica, tecnica di Seldinger, ECG intracavitario, malposizionamento e complicanze immediate
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.
- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

IMP5 — Applicare tecnica Seldinger modificata nel rispetto degli standard di sicurezza procedurale

Area/Pannello: Impianto di Accessi Vascolari / Dimensione: Tecniche di impianto accessi venosi centrali ad inserzione periferica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di applicare tecnica Seldinger modificata nel rispetto degli standard di sicurezza procedurale nell'ambito di tecniche di impianto accessi venosi centrali ad inserzione periferica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari.

Attitudini

- Cura del patrimonio venoso come bene clinico da preservare nel tempo
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Scegliere il device meno invasivo ma adeguato per ridurre fallimenti e consumo venoso evitabile
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di applicare tecnica Seldinger modificata nel rispetto degli standard di sicurezza procedurale
- Utilizzare l'ecografia e i riferimenti anatomici/tecnici per guidare impianto e verifica
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza
- Eseguire i passaggi tecnici con sequenza corretta e controllo degli esiti immediati

Conoscenze

- Stewardship venosa, scelta del device, ecoguida, Seldinger, conferma punta e complicanze meccaniche/infettive
- Anatomia ecografica, asse corto/lungo, needle visualization e prevenzione delle complicanze immediate
- Anatomia ecografica, tecnica di Seldinger, ECG intracavitario, malposizionamento e complicanze immediate
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.
- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

IMP6 — Gestire campi sterili avanzati e barriere massimali durante l'impianto

Area/Pannello: Impianto di Accessi Vascolari / Dimensione: Tecniche di impianto accessi venosi centrali ad inserzione periferica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire campi sterili avanzati e barriere massimali durante l'impianto nell'ambito di tecniche di impianto accessi venosi centrali ad inserzione periferica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari.

Attitudini

- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione
- Attenzione continua alla sterilità, alla sicurezza e ai dettagli esecutivi

Motivazioni

- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione
- Consolidare padronanza tecnica come forma di tutela clinica e professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire campi sterili avanzati e barriere massimali durante l'impianto
- Allestire campo sterile avanzato e mantenere asepsi lungo tutta la procedura
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza
- Eseguire i passaggi tecnici con sequenza corretta e controllo degli esiti immediati

Conoscenze

- Barriere massimali, antisepsi cutanea, tempi di contatto e prevenzione CLABSI
- Anatomia ecografica, tecnica di Seldinger, ECG intracavitario, malposizionamento e complicanze immediate
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità
- Complicanze immediate e tardive, con relative strategie di prevenzione e gestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

IMP7 — Prevenire complicanze meccaniche quali pneumotorace ematoma e malposizionamento

Area/Pannello: Impianto di Accessi Vascolari / Dimensione: Tecniche di impianto accessi venosi centrali ad inserzione periferica

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di prevenire complicanze meccaniche quali pneumotorace ematoma e malposizionamento nell'ambito di tecniche di impianto accessi venosi centrali ad inserzione periferica. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari.

Attitudini

- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione
- Attenzione continua alla sterilità, alla sicurezza e ai dettagli esecutivi

Motivazioni

- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione
- Consolidare padronanza tecnica come forma di tutela clinica e professionale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di prevenire complicanze meccaniche quali pneumotorace ematoma e malposizionamento
- Utilizzare l'ecografia e i riferimenti anatomici/tecnici per guidare impianto e verifica
- Proteggere l'assistito durante posizionamento, sedazione e fase intra-procedurale con monitoraggio attivo
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza

Conoscenze

- Anatomia ecografica, asse corto/lungo, needle visualization e prevenzione delle complicanze immediate
- Rischi da posizionamento, monitoraggio in sedazione, prevenzione lesioni e gestione eventi critici di sala
- Anatomia ecografica, tecnica di Seldinger, ECG intracavitario, malposizionamento e complicanze immediate
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nella precisione del gesto tecnico e nel controllo dei passaggi critici; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.

- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

Verifica e sicurezza procedurale

VPSIC1 — Verificare la posizione della punta del catetere mediante metodiche ECG intracavitario o imaging dedicato

Area/Pannello: Impianto di Accessi Vascolari / Dimensione: Verifica e sicurezza procedurale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di verificare la posizione della punta del catetere mediante metodiche ECG intracavitario o imaging dedicato nell'ambito di verifica e sicurezza procedurale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare danni evitabili, deviazioni dagli standard e mancata intercettazione dei fattori di rischio. La sua corretta espressione produce qualità assistenziale, prevenzione del danno e affidabilità organizzativa e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari.

Attitudini

- Cura del patrimonio venoso come bene clinico da preservare nel tempo
- Prudenza professionale e sensibilità verso i segnali di rischio
- Aderenza rigorosa a standard, check-list, bundle e procedure condivise

Motivazioni

- Scegliere il device meno invasivo ma adeguato per ridurre fallimenti e consumo venoso evitabile
- Proteggere la persona assistita da danni evitabili e dall'esposizione a rischi non necessari
- Contribuire a una cultura della sicurezza affidabile, trasparente e non difensiva

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di verificare la posizione della punta del catetere mediante metodiche ECG intracavitario o imaging dedicato
- Applicare protocolli di prevenzione e verificare i punti critici del processo
- Identificare precocemente deviazioni dagli standard e attivare contromisure appropriate
- Documentare eventi, near miss e azioni correttive con tracciabilità

Conoscenze

- Stewardship venosa, scelta del device, ecoguida, Seldinger, conferma punta e complicanze meccaniche/infettive
- Metodi di verifica punta catetere, complicanze precoci e requisiti documentali della procedura
- Principi di risk management, prevenzione del danno e sicurezza delle cure
- Bundle, check-list, procedure e indicatori di processo/esito rilevanti per l'area
- Fattori umani, cause frequenti di errore e strategie di mitigazione del rischio

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica standard, check-list e procedure di sicurezza nei casi previsti nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; individua soprattutto i rischi più evidenti e necessita di supervisione nel problem solving.
- **Principiante avanzato:** Riconosce scostamenti ricorrenti dagli standard e attiva le contromisure più note; richiede supporto per analizzare cause multiple o eventi meno tipici.
- **Competente:** Presidia in autonomia i punti critici dei casi ordinari, applica misure preventive, documenta eventi/near miss e interviene tempestivamente sulle deviazioni più frequenti.
- **Abile:** Anticipa condizioni favorevoli all'errore, integra fattori clinici, tecnici e umani e rinforza attivamente il comportamento sicuro dell'équipe nei contesti complessi.
- **Esperto:** È riferimento per la cultura della sicurezza: legge i rischi in modo sistemico, promuove apprendimento dagli eventi e contribuisce a bundle, audit e miglioramento continuo.

VPSIC2 — Monitorare complicanze immediate post-impianto quali sanguinamento aritmie o dolore persistente

Area/Pannello: Impianto di Accessi Vascolari / Dimensione: Verifica e sicurezza procedurale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare complicanze immediate post-impianto quali sanguinamento aritmie o dolore persistente nell'ambito di verifica e sicurezza procedurale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare danni evitabili, deviazioni dagli standard e mancata intercettazione dei fattori di rischio. La sua corretta espressione produce qualità assistenziale, prevenzione del danno e affidabilità organizzativa e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari. Il controllo del dolore incide direttamente su mobilitazione, partecipazione alle cure, stabilità fisiologica e qualità dell'esperienza assistenziale.

Attitudini

- Sensibilità a un dolore non sempre esplicitato ma clinicamente rilevante
- Prudenza professionale e sensibilità verso i segnali di rischio
- Aderenza rigorosa a standard, check-list, bundle e procedure condivise

Motivazioni

- Trattare il dolore come esito clinico da monitorare e non come effetto collaterale inevitabile
- Proteggere la persona assistita da danni evitabili e dall'esposizione a rischi non necessari
- Contribuire a una cultura della sicurezza affidabile, trasparente e non difensiva

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare complicanze immediate post-impianto quali sanguinamento aritmie o dolore persistente
- Utilizzare scale di valutazione del dolore, monitorare risposta analgesica e riconoscere effetti collaterali
- Applicare protocolli di prevenzione e verificare i punti critici del processo
- Identificare precocemente deviazioni dagli standard e attivare contromisure appropriate

Conoscenze

- Fisiopatologia del dolore acuto, PCA, analgesia epidurale/peridurale e monitoraggio correlato
- Metodi di verifica punta catetere, complicanze precoci e requisiti documentali della procedura
- Principi di risk management, prevenzione del danno e sicurezza delle cure
- Bundle, check-list, procedure e indicatori di processo/esito rilevanti per l'area
- Fattori umani, cause frequenti di errore e strategie di mitigazione del rischio

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica standard, check-list e procedure di sicurezza nei casi previsti nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; individua soprattutto i rischi più evidenti e necessita di supervisione nel problem solving.
- **Principiante avanzato:** Riconosce scostamenti ricorrenti dagli standard e attiva le contromisure più note; richiede supporto per analizzare cause multiple o eventi meno tipici.
- **Competente:** Presidia in autonomia i punti critici dei casi ordinari, applica misure preventive, documenta eventi/near miss e interviene tempestivamente sulle deviazioni più frequenti.
- **Abile:** Anticipa condizioni favorevoli all'errore, integra fattori clinici, tecnici e umani e rinforza attivamente il comportamento sicuro dell'équipe nei contesti complessi.
- **Esperto:** È riferimento per la cultura della sicurezza: legge i rischi in modo sistemico, promuove apprendimento dagli eventi e contribuisce a bundle, audit e miglioramento continuo.

VPSIC3 — Documentare procedura parametri tecnici e caratteristiche del dispositivo garantendo tracciabilità

Area/Pannello: *Impianto di Accessi Vascolari* / Dimensione: *Verifica e sicurezza procedurale*

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di documentare procedura parametri tecnici e caratteristiche del dispositivo garantendo tracciabilità nell'ambito di verifica e sicurezza procedurale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare danni evitabili, deviazioni dagli standard e mancata intercettazione dei fattori di rischio. La sua corretta espressione produce qualità assistenziale, prevenzione del danno e affidabilità organizzativa e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di impianto di Accessi Vascolari.

Attitudini

- Prudenza professionale e sensibilità verso i segnali di rischio
- Aderenza rigorosa a standard, check-list, bundle e procedure condivise
- Attenzione alla prevenzione degli errori e all'apprendimento dagli eventi critici

Motivazioni

- Proteggere la persona assistita da danni evitabili e dall'esposizione a rischi non necessari
- Contribuire a una cultura della sicurezza affidabile, trasparente e non difensiva
- Mantenere elevati standard di qualità come espressione di responsabilità clinica

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di documentare procedura parametri tecnici e caratteristiche del dispositivo garantendo tracciabilità
- Applicare protocolli di prevenzione e verificare i punti critici del processo
- Identificare precocemente deviazioni dagli standard e attivare contromisure appropriate
- Documentare eventi, near miss e azioni correttive con tracciabilità

Conoscenze

- Metodi di verifica punta catetere, complicanze precoci e requisiti documentali della procedura
- Principi di risk management, prevenzione del danno e sicurezza delle cure
- Bundle, check-list, procedure e indicatori di processo/esito rilevanti per l'area
- Fattori umani, cause frequenti di errore e strategie di mitigazione del rischio

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica standard, check-list e procedure di sicurezza nei casi previsti nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; individua soprattutto i rischi più evidenti e necessita di supervisione nel problem solving.
- **Principiante avanzato:** Riconosce scostamenti ricorrenti dagli standard e attiva le contromisure più note; richiede supporto per analizzare cause multiple o eventi meno tipici.

- **Competente:** Presidia in autonomia i punti critici dei casi ordinari, applica misure preventive, documenta eventi/near miss e interviene tempestivamente sulle deviazioni più frequenti.
- **Abile:** Anticipa condizioni favorevoli all'errore, integra fattori clinici, tecnici e umani e rinforza attivamente il comportamento sicuro dell'équipe nei contesti complessi.
- **Esperto:** È riferimento per la cultura della sicurezza: legge i rischi in modo sistemico, promuove apprendimento dagli eventi e contribuisce a bundle, audit e miglioramento continuo.

Competenze di Area delle Sale Operatorie

Preparazione e allestimento della sala

PREP1 — Verificare sanificazione e prontezza della sala predisponendo ambiente e flussi per garantire sicurezza ed efficienza procedurale

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Preparazione e allestimento della sala

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di verificare sanificazione e prontezza della sala predisponendo ambiente e flussi per garantire sicurezza ed efficienza procedurale nell'ambito di preparazione e allestimento della sala. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Anticipazione del fabbisogno tecnico e attenzione alla sequenza del workflow
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Evitare interruzioni, contaminazioni e ritardi che compromettono sicurezza ed efficienza procedurale
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di verificare sanificazione e prontezza della sala predisponendo ambiente e flussi per garantire sicurezza ed efficienza procedurale
- Predisporre ambiente e flussi per garantire sicurezza ed efficienza procedurale
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza
- Eseguire i passaggi tecnici con sequenza corretta e controllo degli esiti immediati

Conoscenze

- Flussi di sala, set-up, materiali sterili, reprocessing, controlli funzionali e tracciabilità dei dispositivi
- Prontezza ambientale, flussi, sterilità, materiali e requisiti di set-up della procedura
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura

- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità
- Complicanze immediate e tardive, con relative strategie di prevenzione e gestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.
- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

PREP2 — Allestire campo e postazione procedurale predisponendo superfici materiali sterili e dispositivi secondo procedura programmata

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Preparazione e allestimento della sala

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di allestire campo e postazione procedurale predisponendo superfici materiali sterili e dispositivi secondo procedura programmata nell'ambito di preparazione e allestimento della sala. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Anticipazione del fabbisogno tecnico e attenzione alla sequenza del workflow
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Evitare interruzioni, contaminazioni e ritardi che compromettono sicurezza ed efficienza procedurale
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di allestire campo e postazione procedurale predisponendo superfici materiali sterili e dispositivi secondo procedura programmata
- Predisporre superfici materiali sterili e dispositivi secondo procedura programmata
- Allestire campo sterile avanzato e mantenere asepsi lungo tutta la procedura
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza

Conoscenze

- Barriere massimali, antisepsi cutanea, tempi di contatto e prevenzione CLABSI
- Flussi di sala, set-up, materiali sterili, reprocessing, controlli funzionali e tracciabilità dei dispositivi
- Prontezza ambientale, flussi, sterilità, materiali e requisiti di set-up della procedura
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.
- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

PREP3 — Organizzare tavolo strumentale e materiali di consumo garantendo completezza e tempestività di utilizzo intra-procedurale

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Preparazione e allestimento della sala

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di organizzare tavolo strumentale e materiali di consumo garantendo completezza e tempestività di utilizzo intra-procedurale nell'ambito di preparazione e allestimento della sala. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare errori tecnici, complicanze immediate e perdita di controllo dei passaggi critici. La sua corretta espressione produce esecuzione sicura, riduzione delle complicanze e affidabilità tecnica del percorso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Anticipazione del fabbisogno tecnico e attenzione alla sequenza del workflow
- Precisione tecnica e rispetto rigoroso delle sequenze procedurali
- Autocontrollo motorio e cognitivo anche in condizioni di pressione

Motivazioni

- Evitare interruzioni, contaminazioni e ritardi che compromettono sicurezza ed efficienza procedurale
- Ricercare un gesto tecnico affidabile, riproducibile e rispettoso della persona
- Ridurre il rischio di complicanze prevenibili attraverso standard elevati di esecuzione

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di organizzare tavolo strumentale e materiali di consumo garantendo completezza e tempestività di utilizzo intra-procedurale
- Garantire completezza e tempestività di utilizzo intra-procedurale
- Preparare setting, materiali e dispositivi secondo procedura e requisiti di sicurezza
- Eseguire i passaggi tecnici con sequenza corretta e controllo degli esiti immediati

Conoscenze

- Flussi di sala, set-up, materiali sterili, reprocessing, controlli funzionali e tracciabilità dei dispositivi
- Prontezza ambientale, flussi, sterilità, materiali e requisiti di set-up della procedura
- Anatomia funzionale, principi tecnici e standard operativi della procedura
- Indicazioni, controindicazioni e criteri di eleggibilità/procedibilità
- Complicanze immediate e tardive, con relative strategie di prevenzione e gestione

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Esegue la procedura seguendo in sequenza passaggi, materiali e standard nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; necessita di supervisione diretta per gestire imprevisti o deviazioni.
- **Principiante avanzato:** Porta a termine la procedura nei casi frequenti con crescente sicurezza; riconosce i problemi più comuni e richiede supporto nelle situazioni tecnicamente complesse.
- **Competente:** Esegue in autonomia i casi ordinari, prepara correttamente setting e verifiche, previene errori prevedibili e gestisce le complicanze iniziali secondo protocollo.
- **Abile:** Adatta tecnica, materiali e timing alle variabili cliniche/organizzative; anticipa i punti critici e rende il workflow più fluido e sicuro anche in contesti complessi.
- **Esperto:** Ha una padronanza fluida della procedura, riconosce precocemente deviazioni sottili, guida i colleghi nei passaggi difficili e migliora standard e addestramento locale.

Gestione assistito e sicurezza peri-procedurale

PRC1 — Gestire posizionamento e mobilizzazione dell'assistito applicando presidi di protezione e prevenzione lesioni da postura

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Gestione assistito e sicurezza peri-procedurale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire posizionamento e mobilizzazione dell'assistito applicando presidi di protezione e prevenzione lesioni da postura nell'ambito di gestione assistito e sicurezza peri-procedurale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare danni evitabili, deviazioni dagli standard e mancata intercettazione dei fattori di rischio. La sua corretta espressione produce qualità assistenziale, prevenzione del danno e affidabilità organizzativa e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Orientamento alla prevenzione attiva delle complicanze da allettamento
- Prudenza professionale e sensibilità verso i segnali di rischio
- Aderenza rigorosa a standard, check-list, bundle e procedure condivise

Motivazioni

- Favorire recupero funzionale precoce e ridurre esiti evitabili da immobilità
- Proteggere la persona assistita da danni evitabili e dall'esposizione a rischi non necessari
- Contribuire a una cultura della sicurezza affidabile, trasparente e non difensiva

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire posizionamento e mobilizzazione dell'assistito applicando presidi di protezione e prevenzione lesioni da postura
- Applicare presidi di protezione e prevenzione lesioni da postura
- Valutare fattori di rischio, timing e tolleranza alla mobilizzazione precoce
- Proteggere l'assistito durante posizionamento, sedazione e fase intra-procedurale con monitoraggio attivo

Conoscenze

- Fisiopatologia tromboembolica, complicanze respiratorie da immobilità e criteri di mobilizzazione sicura
- Rischi da posizionamento, monitoraggio in sedazione, prevenzione lesioni e gestione eventi critici di sala
- Posizionamento sicuro, sedazione/anestesia, prevenzione lesioni e gestione eventi intra-procedurali
- Principi di risk management, prevenzione del danno e sicurezza delle cure
- Bundle, check-list, procedure e indicatori di processo/esito rilevanti per l'area

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica standard, check-list e procedure di sicurezza nei casi previsti nel prevenire deviazioni dagli standard e danni evitabili; individua soprattutto i rischi più evidenti e necessita di supervisione nel problem solving.
- **Principiante avanzato:** Riconosce scostamenti ricorrenti dagli standard e attiva le contromisure più note; richiede supporto per analizzare cause multiple o eventi meno tipici.
- **Competente:** Presidia in autonomia i punti critici dei casi ordinari, applica misure preventive, documenta eventi/near miss e interviene tempestivamente sulle deviazioni più frequenti.
- **Abile:** Anticipa condizioni favorevoli all'errore, integra fattori clinici, tecnici e umani e rinforza attivamente il comportamento sicuro dell'équipe nei contesti complessi.
- **Esperto:** È riferimento per la cultura della sicurezza: legge i rischi in modo sistemico, promuove apprendimento dagli eventi e contribuisce a bundle, audit e miglioramento continuo.

PRC2 — Supportare sedazione o anestesia monitorando parametri clinici e stabilità intra e post-procedurale

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Gestione assistito e sicurezza peri-procedurale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di supportare sedazione o anestesia monitorando parametri clinici e stabilità intra e post-procedurale nell'ambito di gestione assistito e sicurezza peri-procedurale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare danni evitabili, deviazioni dagli standard e mancata intercettazione dei fattori di rischio. La sua corretta espressione produce qualità assistenziale, prevenzione del danno e affidabilità organizzativa e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Prudenza professionale e sensibilità verso i segnali di rischio
- Aderenza rigorosa a standard, check-list, bundle e procedure condivise
- Attenzione alla prevenzione degli errori e all'apprendimento dagli eventi critici

Motivazioni

- Proteggere la persona assistita da danni evitabili e dall'esposizione a rischi non necessari
- Contribuire a una cultura della sicurezza affidabile, trasparente e non difensiva
- Mantenere elevati standard di qualità come espressione di responsabilità clinica

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di supportare sedazione o anestesia monitorando parametri clinici e stabilità intra e post-procedurale
- Monitorare parametri clinici e stabilità intra e post-procedurale
- Proteggere l'assistito durante posizionamento, sedazione e fase intra-procedurale con monitoraggio attivo
- Applicare protocolli di prevenzione e verificare i punti critici del processo

Conoscenze

- Rischi da posizionamento, monitoraggio in sedazione, prevenzione lesioni e gestione eventi critici di sala
- Posizionamento sicuro, sedazione/anestesia, prevenzione lesioni e gestione eventi intra-procedurali
- Principi di risk management, prevenzione del danno e sicurezza delle cure
- Bundle, check-list, procedure e indicatori di processo/esito rilevanti per l'area
- Fattori umani, cause frequenti di errore e strategie di mitigazione del rischio

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica standard, check-list e procedure di sicurezza nei casi previsti nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; individua soprattutto i rischi più evidenti e necessita di supervisione nel problem solving.

- **Principiante avanzato:** Riconosce scostamenti ricorrenti dagli standard e attiva le contromisure più note; richiede supporto per analizzare cause multiple o eventi meno tipici.
- **Competente:** Presidia in autonomia i punti critici dei casi ordinari, applica misure preventive, documenta eventi/near miss e interviene tempestivamente sulle deviazioni più frequenti.
- **Abile:** Anticipa condizioni favorevoli all'errore, integra fattori clinici, tecnici e umani e rinforza attivamente il comportamento sicuro dell'équipe nei contesti complessi.
- **Esperto:** È riferimento per la cultura della sicurezza: legge i rischi in modo sistemico, promuove apprendimento dagli eventi e contribuisce a bundle, audit e miglioramento continuo.

PRC3 — Prevenire e gestire eventi critici intra-procedurali attivando escalation secondo protocolli della sala

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Gestione assistito e sicurezza peri-procedurale

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di prevenire e gestire eventi critici intra-procedurali attivando escalation secondo protocolli della sala nell'ambito di gestione assistito e sicurezza peri-procedurale. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare danni evitabili, deviazioni dagli standard e mancata intercettazione dei fattori di rischio. La sua corretta espressione produce qualità assistenziale, prevenzione del danno e affidabilità organizzativa e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Anticipazione del fabbisogno tecnico e attenzione alla sequenza del workflow
- Prudenza professionale e sensibilità verso i segnali di rischio
- Aderenza rigorosa a standard, check-list, bundle e procedure condivise

Motivazioni

- Evitare interruzioni, contaminazioni e ritardi che compromettono sicurezza ed efficienza procedurale
- Proteggere la persona assistita da danni evitabili e dall'esposizione a rischi non necessari
- Contribuire a una cultura della sicurezza affidabile, trasparente e non difensiva

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di prevenire e gestire eventi critici intra-procedurali attivando escalation secondo protocolli della sala
- Attivare escalation secondo protocolli della sala
- Proteggere l'assistito durante posizionamento, sedazione e fase intra-procedurale con monitoraggio attivo
- Applicare protocolli di prevenzione e verificare i punti critici del processo

Conoscenze

- Flussi di sala, set-up, materiali sterili, reprocessing, controlli funzionali e tracciabilità dei dispositivi
- Rischi da posizionamento, monitoraggio in sedazione, prevenzione lesioni e gestione eventi critici di sala
- Posizionamento sicuro, sedazione/anestesia, prevenzione lesioni e gestione eventi intra-procedurali
- Principi di risk management, prevenzione del danno e sicurezza delle cure
- Bundle, check-list, procedure e indicatori di processo/esito rilevanti per l'area

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica standard, check-list e procedure di sicurezza nei casi previsti nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; individua soprattutto i rischi più evidenti e necessita di supervisione nel problem solving.
- **Principiante avanzato:** Riconosce scostamenti ricorrenti dagli standard e attiva le contromisure più note; richiede supporto per analizzare cause multiple o eventi meno tipici.
- **Competente:** Presidia in autonomia i punti critici dei casi ordinari, applica misure preventive, documenta eventi/near miss e interviene tempestivamente sulle deviazioni più frequenti.
- **Abile:** Anticipa condizioni favorevoli all'errore, integra fattori clinici, tecnici e umani e rinforza attivamente il comportamento sicuro dell'équipe nei contesti complessi.
- **Esperto:** È riferimento per la cultura della sicurezza: legge i rischi in modo sistemico, promuove apprendimento dagli eventi e contribuisce a bundle, audit e miglioramento continuo.

Tecnologie dispositivi e strumentazione

TEC1 — Gestire apparecchiature elettromedicali e sistemi tecnologici della sala impostando parametri specifici per la procedura

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Tecnologie dispositivi e strumentazione

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire apparecchiature elettromedicali e sistemi tecnologici della sala impostando parametri specifici per la procedura nell'ambito di tecnologie dispositivi e strumentazione. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Anticipazione del fabbisogno tecnico e attenzione alla sequenza del workflow
- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati

Motivazioni

- Evitare interruzioni, contaminazioni e ritardi che compromettono sicurezza ed efficienza procedurale
- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire apparecchiature elettromedicali e sistemi tecnologici della sala impostando parametri specifici per la procedura
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza
- Monitorare efficacia clinica e comparsa di eventi avversi o tossicità
- Educare persona assistita e caregiver agli aspetti critici della terapia quando pertinente

Conoscenze

- Flussi di sala, set-up, materiali sterili, reprocessing, controlli funzionali e tracciabilità dei dispositivi
- Principi di wound bed preparation, drenaggi, stomie e gestione della tracheostomia
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.
- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

TEC2 — Verificare funzionamento e sicurezza di strumenti e accessori prima durante e dopo la procedura prevenendo guasti e malfunzionamenti

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Tecnologie dispositivi e strumentazione

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di verificare funzionamento e sicurezza di strumenti e accessori prima durante e dopo la procedura prevenendo guasti e malfunzionamenti nell'ambito di tecnologie dispositivi e strumentazione. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati
- Disciplina nell'aderire a protocolli, doppie verifiche e tracciabilità

Motivazioni

- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili
- Contribuire alla continuità terapeutica attraverso una gestione affidabile della terapia

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di verificare funzionamento e sicurezza di strumenti e accessori prima durante e dopo la procedura prevenendo guasti e malfunzionamenti
- Prevenire guasti e malfunzionamenti
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza
- Monitorare efficacia clinica e comparsa di eventi avversi o tossicità

Conoscenze

- Principi di wound bed preparation, drenaggi, stomie e gestione della tracheostomia
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

TEC3 — Preparare e gestire materiali emostatici dispositivi di sintesi o dispositivi interventistici secondo indicazione procedurale

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Tecnologie dispositivi e strumentazione

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di preparare e gestire materiali emostatici dispositivi di sintesi o dispositivi interventistici secondo indicazione procedurale nell'ambito di tecnologie dispositivi e strumentazione. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati
- Disciplina nell'aderire a protocolli, doppie verifiche e tracciabilità

Motivazioni

- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili
- Contribuire alla continuità terapeutica attraverso una gestione affidabile della terapia

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di preparare e gestire materiali emostatici dispositivi di sintesi o dispositivi interventistici secondo indicazione procedurale
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza
- Monitorare efficacia clinica e comparsa di eventi avversi o tossicità
- Educare persona assistita e caregiver agli aspetti critici della terapia quando pertinente

Conoscenze

- Principi di wound bed preparation, drenaggi, stomie e gestione della tracheostomia
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.

- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

Collaborazione tecnico-procedurale e workflow sterile

WKF1 — Collaborare come secondo operatore nelle fasi procedurali anticipando necessità tecniche e mantenendo continuità del flusso

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Collaborazione tecnico-procedurale e workflow sterile

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di collaborare come secondo operatore nelle fasi procedurali anticipando necessità tecniche e mantenendo continuità del flusso nell'ambito di collaborazione tecnico-procedurale e workflow sterile. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale
- Attenzione ai significati emotivi e relazionali della situazione assistenziale
- Coerenza tra comunicazione verbale, non verbale e intenzionalità terapeutica

Motivazioni

- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura
- Riconoscere la dignità della persona anche nelle condizioni di vulnerabilità o conflitto
- Utilizzare la relazione come strumento clinico e non come semplice scambio informativo

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di collaborare come secondo operatore nelle fasi procedurali anticipando necessità tecniche e mantenendo continuità del flusso
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona
- Adattare linguaggio, tono, postura e tempi comunicativi al contesto
- Gestire colloqui difficili mantenendo contenimento emotivo e chiarezza professionale

Conoscenze

- SBAR e altre strutture di handover/comunicazione clinica
- Dinamiche di team, ruoli e gestione costruttiva dei conflitti
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica
- Aspetti etici e di privacy connessi alla relazione di cura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nell'esecuzione tecnica, nel mantenimento del campo sicuro e nella verifica degli esiti immediati; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

WKF2 — Gestire materiali sterili e non sterili mantenendo integrità del campo e prevenendo contaminazioni

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Collaborazione tecnico-procedurale e workflow sterile

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire materiali sterili e non sterili mantenendo integrità del campo e prevenendo contaminazioni nell'ambito di collaborazione tecnico-procedurale e workflow sterile. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale
- Attenzione ai significati emotivi e relazionali della situazione assistenziale
- Coerenza tra comunicazione verbale, non verbale e intenzionalità terapeutica

Motivazioni

- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura
- Riconoscere la dignità della persona anche nelle condizioni di vulnerabilità o conflitto
- Utilizzare la relazione come strumento clinico e non come semplice scambio informativo

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire materiali sterili e non sterili mantenendo integrità del campo e prevenendo contaminazioni
- Allestire campo sterile avanzato e mantenere asepsi lungo tutta la procedura
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona
- Adattare linguaggio, tono, postura e tempi comunicativi al contesto

Conoscenze

- Barriere massimali, antisepsi cutanea, tempi di contatto e prevenzione CLABSI
- SBAR e altre strutture di handover/comunicazione clinica
- Dinamiche di team, ruoli e gestione costruttiva dei conflitti
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel mantenere un setting terapeutico chiaro, rispettoso e funzionale; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

WKF3 — Gestire campioni biologici garantendo raccolta identificazione conservazione e tracciabilità fino all'invio ai servizi diagnostici

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Collaborazione tecnico-procedurale e workflow sterile

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire campioni biologici garantendo raccolta identificazione conservazione e tracciabilità fino all'invio ai servizi diagnostici nell'ambito di collaborazione tecnico-procedurale e workflow sterile. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale
- Attenzione ai significati emotivi e relazionali della situazione assistenziale
- Coerenza tra comunicazione verbale, non verbale e intenzionalità terapeutica

Motivazioni

- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura
- Riconoscere la dignità della persona anche nelle condizioni di vulnerabilità o conflitto
- Utilizzare la relazione come strumento clinico e non come semplice scambio informativo

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire campioni biologici garantendo raccolta identificazione conservazione e tracciabilità fino all'invio ai servizi diagnostici
- Garantire raccolta identificazione conservazione e tracciabilità fino all'invio ai servizi diagnostici
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona
- Adattare linguaggio, tono, postura e tempi comunicativi al contesto

Conoscenze

- SBAR e altre strutture di handover/comunicazione clinica
- Dinamiche di team, ruoli e gestione costruttiva dei conflitti
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica
- Aspetti etici e di privacy connessi alla relazione di cura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel mantenere un setting terapeutico chiaro, rispettoso e funzionale; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

Reprocessing tracciabilità e controllo del rischio

REP1 — Gestire percorso sporco-pulito garantendo separazione funzionale e sicurezza ambientale della sala e delle aree dedicate

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Reprocessing tracciabilità e controllo del rischio

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire percorso sporco-pulito garantendo separazione funzionale e sicurezza ambientale della sala e delle aree dedicate nell'ambito di reprocessing tracciabilità e controllo del rischio. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare danni evitabili, deviazioni dagli standard e mancata intercettazione dei fattori di rischio. La sua corretta espressione produce qualità assistenziale, prevenzione del danno e affidabilità organizzativa e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Anticipazione del fabbisogno tecnico e attenzione alla sequenza del workflow
- Prudenza professionale e sensibilità verso i segnali di rischio
- Aderenza rigorosa a standard, check-list, bundle e procedure condivise

Motivazioni

- Evitare interruzioni, contaminazioni e ritardi che compromettono sicurezza ed efficienza procedurale
- Proteggere la persona assistita da danni evitabili e dall'esposizione a rischi non necessari
- Contribuire a una cultura della sicurezza affidabile, trasparente e non difensiva

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire percorso sporco-pulito garantendo separazione funzionale e sicurezza ambientale della sala e delle aree dedicate
- Garantire separazione funzionale e sicurezza ambientale della sala e delle aree dedicate
- Applicare protocolli di prevenzione e verificare i punti critici del processo
- Identificare precocemente deviazioni dagli standard e attivare contromisure appropriate

Conoscenze

- Flussi di sala, set-up, materiali sterili, reprocessing, controlli funzionali e tracciabilità dei dispositivi
- Reprocessing manuale/automatizzato, stoccaggio, microbiologia di processo e tracciabilità
- Principi di risk management, prevenzione del danno e sicurezza delle cure
- Bundle, check-list, procedure e indicatori di processo/esito rilevanti per l'area
- Fattori umani, cause frequenti di errore e strategie di mitigazione del rischio

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica standard, check-list e procedure di sicurezza nei casi previsti nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; individua soprattutto i rischi più evidenti e necessita di supervisione nel problem solving.
- **Principiante avanzato:** Riconosce scostamenti ricorrenti dagli standard e attiva le contromisure più note; richiede supporto per analizzare cause multiple o eventi meno tipici.
- **Competente:** Presidia in autonomia i punti critici dei casi ordinari, applica misure preventive, documenta eventi/near miss e interviene tempestivamente sulle deviazioni più frequenti.
- **Abile:** Anticipa condizioni favorevoli all'errore, integra fattori clinici, tecnici e umani e rinforza attivamente il comportamento sicuro dell'équipe nei contesti complessi.
- **Esperto:** È riferimento per la cultura della sicurezza: legge i rischi in modo sistemico, promuove apprendimento dagli eventi e contribuisce a bundle, audit e miglioramento continuo.

REP2 — Eseguire reprocessing manuale e automatizzato di strumenti e dispositivi secondo procedure standard e requisiti di qualità

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Reprocessing tracciabilità e controllo del rischio

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di eseguire reprocessing manuale e automatizzato di strumenti e dispositivi secondo procedure standard e requisiti di qualità nell'ambito di reprocessing tracciabilità e controllo del rischio. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare danni evitabili, deviazioni dagli standard e mancata intercettazione dei fattori di rischio. La sua corretta espressione produce qualità assistenziale, prevenzione del danno e affidabilità organizzativa e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Anticipazione del fabbisogno tecnico e attenzione alla sequenza del workflow
- Prudenza professionale e sensibilità verso i segnali di rischio
- Aderenza rigorosa a standard, check-list, bundle e procedure condivise

Motivazioni

- Evitare interruzioni, contaminazioni e ritardi che compromettono sicurezza ed efficienza procedurale
- Proteggere la persona assistita da danni evitabili e dall'esposizione a rischi non necessari
- Contribuire a una cultura della sicurezza affidabile, trasparente e non difensiva

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di eseguire reprocessing manuale e automatizzato di strumenti e dispositivi secondo procedure standard e requisiti di qualità
- Applicare protocolli di prevenzione e verificare i punti critici del processo
- Identificare precocemente deviazioni dagli standard e attivare contromisure appropriate
- Documentare eventi, near miss e azioni correttive con tracciabilità

Conoscenze

- Flussi di sala, set-up, materiali sterili, reprocessing, controlli funzionali e tracciabilità dei dispositivi
- Reprocessing manuale/automatizzato, stoccaggio, microbiologia di processo e tracciabilità
- Principi di risk management, prevenzione del danno e sicurezza delle cure
- Bundle, check-list, procedure e indicatori di processo/esito rilevanti per l'area
- Fattori umani, cause frequenti di errore e strategie di mitigazione del rischio

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica standard, check-list e procedure di sicurezza nei casi previsti nel prevenire deviazioni dagli standard e danni evitabili; individua soprattutto i rischi più evidenti e necessita di supervisione nel problem solving.
- **Principiante avanzato:** Riconosce scostamenti ricorrenti dagli standard e attiva le contromisure più note; richiede supporto per analizzare cause multiple o eventi meno tipici.
- **Competente:** Presidia in autonomia i punti critici dei casi ordinari, applica misure preventive, documenta eventi/near miss e interviene tempestivamente sulle deviazioni più frequenti.
- **Abile:** Anticipa condizioni favorevoli all'errore, integra fattori clinici, tecnici e umani e rinforza attivamente il comportamento sicuro dell'équipe nei contesti complessi.
- **Esperto:** È riferimento per la cultura della sicurezza: legge i rischi in modo sistemico, promuove apprendimento dagli eventi e contribuisce a bundle, audit e miglioramento continuo.

REP3 — Garantire tracciabilità del ricondizionamento e dello stoccaggio degli strumenti includendo controlli microbiologici o funzionali previsti

Area/Pannello: Gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità / Dimensione: Reprocessing tracciabilità e controllo del rischio

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di garantire tracciabilità del ricondizionamento e dello stoccaggio degli strumenti includendo controlli microbiologici o funzionali previsti nell'ambito di reprocessing tracciabilità e controllo del rischio. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare danni evitabili, deviazioni dagli standard e mancata intercettazione dei fattori di rischio. La sua corretta espressione produce qualità assistenziale, prevenzione del danno e affidabilità organizzativa e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di gestione Sale Operatorie ad Alta Complessità.

Attitudini

- Anticipazione del fabbisogno tecnico e attenzione alla sequenza del workflow
- Prudenza professionale e sensibilità verso i segnali di rischio
- Aderenza rigorosa a standard, check-list, bundle e procedure condivise

Motivazioni

- Evitare interruzioni, contaminazioni e ritardi che compromettono sicurezza ed efficienza procedurale
- Proteggere la persona assistita da danni evitabili e dall'esposizione a rischi non necessari
- Contribuire a una cultura della sicurezza affidabile, trasparente e non difensiva

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di garantire tracciabilità del ricondizionamento e dello stoccaggio degli strumenti includendo controlli microbiologici o funzionali previsti
- Applicare protocolli di prevenzione e verificare i punti critici del processo
- Identificare precocemente deviazioni dagli standard e attivare contromisure appropriate
- Documentare eventi, near miss e azioni correttive con tracciabilità

Conoscenze

- Flussi di sala, set-up, materiali sterili, reprocessing, controlli funzionali e tracciabilità dei dispositivi
- Reprocessing manuale/automatizzato, stoccaggio, microbiologia di processo e tracciabilità
- Principi di risk management, prevenzione del danno e sicurezza delle cure
- Bundle, check-list, procedure e indicatori di processo/esito rilevanti per l'area
- Fattori umani, cause frequenti di errore e strategie di mitigazione del rischio

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica standard, check-list e procedure di sicurezza nei casi previsti nel prevenire deviazioni dagli standard e danni evitabili; individua soprattutto i rischi più evidenti e necessita di supervisione nel problem solving.
- **Principiante avanzato:** Riconosce scostamenti ricorrenti dagli standard e attiva le contromisure più note; richiede supporto per analizzare cause multiple o eventi meno tipici.
- **Competente:** Presidia in autonomia i punti critici dei casi ordinari, applica misure preventive, documenta eventi/near miss e interviene tempestivamente sulle deviazioni più frequenti.
- **Abile:** Anticipa condizioni favorevoli all'errore, integra fattori clinici, tecnici e umani e rinforza attivamente il comportamento sicuro dell'équipe nei contesti complessi.
- **Esperto:** È riferimento per la cultura della sicurezza: legge i rischi in modo sistemico, promuove apprendimento dagli eventi e contribuisce a bundle, audit e miglioramento continuo.

Valutazione clinica psichiatrica avanzata

PSI1 — Condurre valutazione dello stato mentale in acuzie utilizzando framework e strumenti di emergenza raccogliendo dati e formulando valutazione infermieristica e interventi condivisi con équipe e rete

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Valutazione clinica psichiatrica avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di condurre valutazione dello stato mentale in acuzie utilizzando framework e strumenti di emergenza raccogliendo dati e formulando valutazione infermieristica e interventi condivisi con équipe e rete nell'ambito di valutazione clinica psichiatrica avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Tolleranza all'ambiguità clinica e capacità di osservazione non giudicante

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Comprendere il significato del comportamento e ridurre risposte impulsive o stigmatizzanti
- Spostare il focus dal solo contenimento del sintomo alla partecipazione e alla cittadinanza possibile

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di condurre valutazione dello stato mentale in acuzie utilizzando framework e strumenti di emergenza raccogliendo dati e formulando valutazione infermieristica e interventi condivisi con équipe e rete
- Utilizzare framework e strumenti di emergenza
- Raccogliere dati e formulando valutazione infermieristica e interventi condivisi con équipe e rete
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- Esame dello stato mentale, urgenza psichiatrica, rischio suicidario/aggressivo e setting terapeutico
- Recovery, riabilitazione psicosociale, gruppi terapeutici, rete formale/informale e prevenzione ricadute
- Esame dello stato mentale, valutazione del rischio, setting terapeutico, privacy e urgenza psichiatrica
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

PSI2 — Costruire un setting terapeutico dinamico adattato a condizioni emotive e psicopatologiche garantendo riservatezza e applicazione della normativa privacy

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Valutazione clinica psichiatrica avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di costruire un setting terapeutico dinamico adattato a condizioni emotive e psicopatologiche garantendo riservatezza e applicazione della normativa privacy nell'ambito di valutazione clinica psichiatrica avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Tolleranza all'ambiguità clinica e capacità di osservazione non giudicante
- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale
- Attenzione ai significati emotivi e relazionali della situazione assistenziale

Motivazioni

- Comprendere il significato del comportamento e ridurre risposte impulsive o stigmatizzanti
- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura
- Riconoscere la dignità della persona anche nelle condizioni di vulnerabilità o conflitto

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di costruire un setting terapeutico dinamico adattato a condizioni emotive e psicopatologiche garantendo riservatezza e applicazione della normativa privacy
- Garantire riservatezza e applicazione della normativa privacy
- Raccogliere dati osservativi, anamnestici e relazionali per formulare valutazione infermieristica condivisa
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona

Conoscenze

- Esame dello stato mentale, urgenza psichiatrica, rischio suicidario/aggressivo e setting terapeutico
- Esame dello stato mentale, valutazione del rischio, setting terapeutico, privacy e urgenza psichiatrica
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica
- Aspetti etici e di privacy connessi alla relazione di cura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel mantenere un setting terapeutico chiaro, rispettoso e funzionale; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

PSI3 — Definire grado di urgenza e priorità assistenziale evitando decisioni affrettate e rivalutando dinamicamente rischio e bisogni clinici

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Valutazione clinica psichiatrica avanzata

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di definire grado di urgenza e priorità assistenziale evitando decisioni affrettate e rivalutando dinamicamente rischio e bisogni clinici nell'ambito di valutazione clinica psichiatrica avanzata. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Capacità di decidere rapidamente senza perdere metodo e rivalutazione critica
- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale
- Attenzione ai significati emotivi e relazionali della situazione assistenziale

Motivazioni

- Allocare con giustizia clinica tempi e risorse in base a gravità e rischio evolutivo
- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura
- Riconoscere la dignità della persona anche nelle condizioni di vulnerabilità o conflitto

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di definire grado di urgenza e priorità assistenziale evitando decisioni affrettate e rivalutando dinamicamente rischio e bisogni clinici
- Classificare, rivalutare e ridefinire la priorità sulla base dell'evoluzione clinica
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona
- Adattare linguaggio, tono, postura e tempi comunicativi al contesto

Conoscenze

- Discriminatori di triage, red flags, percorsi tempo-dipendenti e principi di rivalutazione
- Esame dello stato mentale, valutazione del rischio, setting terapeutico, privacy e urgenza psichiatrica
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica
- Aspetti etici e di privacy connessi alla relazione di cura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel mantenere un setting terapeutico chiaro, rispettoso e funzionale; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

Gestione crisi e rischio psichiatrico

CRI1 — Identificare con l'équipe segni prodromici di crisi e rischi prevedibili impostando un problem setting orientato alla riduzione del rischio e al recupero di controllo

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Gestione crisi e rischio psichiatrico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di identificare con l'équipe segni prodromici di crisi e rischi prevedibili impostando un problem setting orientato alla riduzione del rischio e al recupero di controllo nell'ambito di gestione crisi e rischio psichiatrico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze. La competenza ha un forte impatto sulla qualità del coordinamento e sulla riduzione delle omissioni informative.

Attitudini

- Disponibilità al confronto professionale e alla negoziazione delle priorità
- Chiarezza nel condividere informazioni rilevanti senza ambiguità
- Presenza calma, regolata e capace di non entrare in escalation simmetrica

Motivazioni

- Sostenere coesione operativa e affidabilità reciproca all'interno del team
- Ridurre coercizione e danno relazionale mantenendo sicurezza per persona, operatori e ambiente
- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di identificare con l'équipe segni prodromici di crisi e rischi prevedibili impostando un problem setting orientato alla riduzione del rischio e al recupero di controllo
- Utilizzare modalità strutturate di passaggio informazioni e condivisione del piano di lavoro
- Utilizzare de-escalation verbale e non verbale, modulare setting e richiedere supporto al momento opportuno
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona

Conoscenze

- Ruoli, responsabilità e interdipendenze tra professionisti nel contesto assistenziale
- Tecniche di de-escalation, segnali prodromici, gestione dell'aggressività e contenimento relazionale
- Segni prodromici di crisi, tecniche di de-escalation, prossemica e valutazione del rischio
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel modulare la relazione, contenere il rischio e scegliere il livello di intervento più adeguato; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

CR12 — Attuare tecniche di de-escalation mantenendo prossemica e postura adeguate evitando simmetria richiedendo supporto quando necessario e modulando presenza di persone significative

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Gestione crisi e rischio psichiatrico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di attuare tecniche di de-escalation mantenendo prossemica e postura adeguate evitando simmetria richiedendo supporto quando necessario e modulando presenza di persone significative nell'ambito di gestione crisi e rischio psichiatrico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Presenza calma, regolata e capace di non entrare in escalation simmetrica
- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale
- Attenzione ai significati emotivi e relazionali della situazione assistenziale

Motivazioni

- Ridurre coercizione e danno relazionale mantenendo sicurezza per persona, operatori e ambiente
- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura
- Riconoscere la dignità della persona anche nelle condizioni di vulnerabilità o conflitto

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di attuare tecniche di de-escalation mantenendo prossemica e postura adeguate evitando simmetria richiedendo supporto quando necessario e modulando presenza di persone significative
- Modulare presenza di persone significative
- Utilizzare de-escalation verbale e non verbale, modulare setting e richiedere supporto al momento opportuno
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona

Conoscenze

- Tecniche di de-escalation, segnali prodromici, gestione dell'aggressività e contenimento relazionale
- Segni prodromici di crisi, tecniche di de-escalation, prossemica e valutazione del rischio
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica
- Aspetti etici e di privacy connessi alla relazione di cura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel modulare la relazione, contenere il rischio e scegliere il livello di intervento più adeguato; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

CRI3 — Accogliere e contenere emotivamente assistito e familiari attuando interventi terapeutici tempestivi per limitare rischi per la persona l'ambiente e la rete e prestando primo soccorso in caso di lesioni significative

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Gestione crisi e rischio psichiatrico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di accogliere e contenere emotivamente assistito e familiari attuando interventi terapeutici tempestivi per limitare rischi per la persona l'ambiente e la rete e prestando primo soccorso in caso di lesioni significative nell'ambito di gestione crisi e rischio psichiatrico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Presenza calma, regolata e capace di non entrare in escalation simmetrica
- Orientamento alle potenzialità della persona e del contesto di vita
- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale

Motivazioni

- Ridurre coercizione e danno relazionale mantenendo sicurezza per persona, operatori e ambiente
- Spostare il focus dal solo contenimento del sintomo alla partecipazione e alla cittadinanza possibile
- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di accogliere e contenere emotivamente assistito e familiari attuando interventi terapeutici tempestivi per limitare rischi per la persona l'ambiente e la rete e prestando primo soccorso in caso di lesioni significative
- Utilizzare de-escalation verbale e non verbale, modulare setting e richiedere supporto al momento opportuno
- Costruire obiettivi riabilitativi, lavorare con rete e attivare risorse comunitarie
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona

Conoscenze

- Tecniche di de-escalation, segnali prodromici, gestione dell'aggressività e contenimento relazionale
- Recovery, riabilitazione psicosociale, gruppi terapeutici, rete formale/informale e prevenzione ricadute
- Segni prodromici di crisi, tecniche di de-escalation, prossemica e valutazione del rischio
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

Terapie psicofarmacologiche e trattamenti specialistici

PSF1 — Monitorare efficacia e tollerabilità dei trattamenti psicofarmacologici valutando risposta clinica e effetti indesiderati

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Terapie psicofarmacologiche e trattamenti specialistici

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di monitorare efficacia e tollerabilità dei trattamenti psicofarmacologici valutando risposta clinica e effetti indesiderati nell'ambito di terapie psicofarmacologiche e trattamenti specialistici. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati
- Disciplina nell'aderire a protocolli, doppie verifiche e tracciabilità

Motivazioni

- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili
- Contribuire alla continuità terapeutica attraverso una gestione affidabile della terapia

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di monitorare efficacia e tollerabilità dei trattamenti psicofarmacologici valutando risposta clinica e effetti indesiderati
- Valutare risposta clinica e effetti indesiderati
- Monitorare risposta clinica, effetti indesiderati, aderenza e condizioni di sicurezza dei trattamenti
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza

Conoscenze

- Antipsicotici, stabilizzatori, benzodiazepine, sindromi da sospensione, CIWA/COWS se applicabili, interazioni e tossicità
- Classi psicofarmacologiche, effetti collaterali, sindromi da sospensione, tossicità e trattamenti long acting
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi

- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella corretta gestione del trattamento, nella prevenzione del rischio e nel monitoraggio della risposta; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.
- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

PSF2 — Gestire terapie long acting e contenimento farmacologico secondo protocolli monitorando parametri clinici sicurezza ed esiti

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Terapie psicofarmacologiche e trattamenti specialistici

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire terapie long acting e contenimento farmacologico secondo protocolli monitorando parametri clinici sicurezza ed esiti nell'ambito di terapie psicofarmacologiche e trattamenti specialistici. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati
- Disciplina nell'aderire a protocolli, doppie verifiche e tracciabilità

Motivazioni

- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili
- Contribuire alla continuità terapeutica attraverso una gestione affidabile della terapia

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire terapie long acting e contenimento farmacologico secondo protocolli monitorando parametri clinici sicurezza ed esiti
- Monitorare parametri clinici sicurezza ed esiti
- Monitorare risposta clinica, effetti indesiderati, aderenza e condizioni di sicurezza dei trattamenti
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza

Conoscenze

- Antipsicotici, stabilizzatori, benzodiazepine, sindromi da sospensione, CIWA/COWS se applicabili, interazioni e tossicità
- Classi psicofarmacologiche, effetti collaterali, sindromi da sospensione, tossicità e trattamenti long acting
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.
- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

PSF3 — Riconoscere e gestire sindromi da sospensione o tossicità o accumulo di farmaci e interazioni farmacologiche

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Terapie psicofarmacologiche e trattamenti specialistici

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere e gestire sindromi da sospensione o tossicità o accumulo di farmaci e interazioni farmacologiche nell'ambito di terapie psicofarmacologiche e trattamenti specialistici. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati
- Disciplina nell'aderire a protocolli, doppie verifiche e tracciabilità

Motivazioni

- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili
- Contribuire alla continuità terapeutica attraverso una gestione affidabile della terapia

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere e gestire sindromi da sospensione o tossicità o accumulo di farmaci e interazioni farmacologiche
- Riconoscere pattern di tossicità acuta/tardiva e attivare escalation secondo grading e severità
- Monitorare risposta clinica, effetti indesiderati, aderenza e condizioni di sicurezza dei trattamenti
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza

Conoscenze

- CTCAE o sistemi analoghi di grading, late effects, triage tossicità e criteri di invio specialistico
- Antipsicotici, stabilizzatori, benzodiazepine, sindromi da sospensione, CIWA/COWS se applicabili, interazioni e tossicità
- Classi psicofarmacologiche, effetti collaterali, sindromi da sospensione, tossicità e trattamenti long acting
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella corretta gestione del trattamento, nella prevenzione del rischio e nel monitoraggio della risposta; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.
- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

PSF4 — Riconoscere e gestire i pazienti con sintomi di astinenza da alcol o sostanze attraverso un approccio strutturato

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Terapie psicofarmacologiche e trattamenti specialistici

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere e gestire i pazienti con sintomi di astinenza da alcol o sostanze attraverso un approccio strutturato nell'ambito di terapie psicofarmacologiche e trattamenti specialistici. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare eventi avversi, errori di somministrazione e ridotta efficacia del trattamento. La sua corretta espressione produce appropriatezza terapeutica, continuità del trattamento e contenimento della tossicità e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Accuratezza nell'applicazione della prescrizione e nella verifica dei passaggi critici
- Attenzione alla risposta della persona assistita e agli effetti attesi o indesiderati
- Disciplina nell'aderire a protocolli, doppie verifiche e tracciabilità

Motivazioni

- Garantire appropriatezza e sicurezza del trattamento come priorità non negoziabile
- Mantenere elevata sensibilità verso il rischio farmacologico e i danni evitabili
- Contribuire alla continuità terapeutica attraverso una gestione affidabile della terapia

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere e gestire i pazienti con sintomi di astinenza da alcol o sostanze attraverso un approccio strutturato
- Monitorare risposta clinica, effetti indesiderati, aderenza e condizioni di sicurezza dei trattamenti
- Verificare indicazioni, dosaggi, compatibilità, tempi e parametri di sicurezza
- Monitorare efficacia clinica e comparsa di eventi avversi o tossicità

Conoscenze

- Antipsicotici, stabilizzatori, benzodiazepine, sindromi da sospensione, CIWA/COWS se applicabili, interazioni e tossicità
- Classi psicofarmacologiche, effetti collaterali, sindromi da sospensione, tossicità e trattamenti long acting
- Farmacologia clinica di base e principi di sicurezza nella gestione terapeutica
- Interazioni, incompatibilità, monitoraggi richiesti ed eventi avversi attesi
- Procedure di tracciabilità, segnalazione e gestione degli incidenti correlati alla terapia

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica la terapia o il trattamento seguendo prescrizione, protocolli e verifiche standard nella gestione sicura del trattamento e nel monitoraggio degli esiti; necessita di supervisione per valutare effetti e anomalie.
- **Principiante avanzato:** Gestisce i trattamenti più ricorrenti e identifica reazioni attese o problemi frequenti; ha ancora bisogno di confronto per tossicità, interazioni o situazioni non standard.
- **Competente:** Conduce in autonomia i trattamenti ordinari, verifica requisiti di sicurezza, monitora efficacia/effetti indesiderati ed educa la persona sugli aspetti essenziali.
- **Abile:** Personalizza la gestione terapeutica in base a fragilità, comorbidità e risposta clinica; anticipa criticità e coordina gli adattamenti necessari con il team.
- **Esperto:** Governa trattamenti complessi con elevata accuratezza, riconosce segnali precoci di tossicità o fallimento e orienta prassi, formazione e gestione del rischio nel servizio.

Riabilitazione psicosociale e recovery

RECV1 — Condurre o co-condurre attività di gruppo psicoeducative social skills training o centrate su compito adattando setting e obiettivi riabilitativi

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Riabilitazione psicosociale e recovery

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di condurre o co-condurre attività di gruppo psicoeducative social skills training o centrate su compito adattando setting e obiettivi riabilitativi nell'ambito di riabilitazione psicosociale e recovery. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare cronicizzazione passiva, perdita di autonomie e frammentazione della rete di supporto. La sua corretta espressione produce recovery, partecipazione e mantenimento del funzionamento nel contesto di vita e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Orientamento alle potenzialità della persona e del contesto di vita
- Orientamento alle capacità residue e alle risorse della persona e della rete
- Pazienza clinica e continuità nell'accompagnare processi di cambiamento graduale

Motivazioni

- Spostare il focus dal solo contenimento del sintomo alla partecipazione e alla cittadinanza possibile
- Favorire partecipazione, inclusione e qualità di vita oltre il controllo del sintomo
- Sostenere percorsi di autonomia realistica e di reintegrazione nei contesti di vita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di condurre o co-condurre attività di gruppo psicoeducative social skills training o centrate su compito adattando setting e obiettivi riabilitativi
- Adattare setting e obiettivi riabilitativi
- Costruire obiettivi riabilitativi, lavorare con rete e attivare risorse comunitarie
- Definire obiettivi realistici e condivisi con persona, famiglia e rete

Conoscenze

- Recovery, riabilitazione psicosociale, gruppi terapeutici, rete formale/informale e prevenzione ricadute
- Gruppi psicoeducativi, social skills training, piano terapeutico riabilitativo individuale e rete sociale
- Modelli di recovery, riabilitazione psicosociale e funzionamento
- Strumenti di valutazione del funzionamento, partecipazione e obiettivi personalizzati
- Interventi evidence-based per inclusione, autonomie e prevenzione delle ricadute

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa agli interventi riabilitativi seguendo obiettivi e setting già definiti nel trasformare gli obiettivi clinici in funzionamento e partecipazione; osserva soprattutto bisogni evidenti e richiede guida nella lettura della rete e del funzionamento.
- **Principiante avanzato:** Riconosce risorse e ostacoli ricorrenti e contribuisce a obiettivi semplici; necessita di supporto per integrare contesto di vita, partecipazione e prevenzione delle ricadute.
- **Competente:** Definisce e realizza in autonomia programmi ordinari, valuta esiti funzionali/partecipativi e coordina in modo appropriato le risorse della rete.
- **Abile:** Personalizza obiettivi e interventi in base a funzionamento, motivazione e contesto; previene frammentazione e favorisce recovery e inclusione anche in situazioni complesse.
- **Esperto:** È riferimento nella progettazione di percorsi riabilitativi complessi, sviluppa lavoro di rete avanzato e orienta l'équipe a una lettura centrata su recovery e comunità.

RECV2 — Integrare progetti terapeutici e socio-riabilitativi attivando azioni partecipative orientate al fare comunità e alla continuità dei percorsi

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Riabilitazione psicosociale e recovery

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di integrare progetti terapeutici e socio-riabilitativi attivando azioni partecipative orientate al fare comunità e alla continuità dei percorsi nell'ambito di riabilitazione psicosociale e recovery. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare cronicizzazione passiva, perdita di autonomie e frammentazione della rete di supporto. La sua corretta espressione produce recovery, partecipazione e mantenimento del funzionamento nel contesto di vita e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Sguardo allargato ai determinanti sociali e ambientali della salute
- Orientamento alle potenzialità della persona e del contesto di vita
- Orientamento alle capacità residue e alle risorse della persona e della rete

Motivazioni

- Intercettare precocemente fragilità che tendono a restare invisibili ai servizi
- Spostare il focus dal solo contenimento del sintomo alla partecipazione e alla cittadinanza possibile
- Favorire partecipazione, inclusione e qualità di vita oltre il controllo del sintomo

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di integrare progetti terapeutici e socio-riabilitativi attivando azioni partecipative orientate al fare comunità e alla continuità dei percorsi
- Attivare azioni partecipative orientate al fare comunità e alla continuità dei percorsi
- Leggere dati di popolazione e segnali di vulnerabilità per orientare interventi mirati
- Costruire obiettivi riabilitativi, lavorare con rete e attivare risorse comunitarie

Conoscenze

- Epidemiologia di comunità, indicatori di vulnerabilità, reti territoriali e meccanismi di tutela
- Recovery, riabilitazione psicosociale, gruppi terapeutici, rete formale/informale e prevenzione ricadute
- Gruppi psicoeducativi, social skills training, piano terapeutico riabilitativo individuale e rete sociale
- Modelli di recovery, riabilitazione psicosociale e funzionamento
- Strumenti di valutazione del funzionamento, partecipazione e obiettivi personalizzati

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa agli interventi riabilitativi seguendo obiettivi e setting già definiti nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; osserva soprattutto bisogni evidenti e richiede guida nella lettura della rete e del funzionamento.
- **Principiante avanzato:** Riconosce risorse e ostacoli ricorrenti e contribuisce a obiettivi semplici; necessita di supporto per integrare contesto di vita, partecipazione e prevenzione delle ricadute.
- **Competente:** Definisce e realizza in autonomia programmi ordinari, valuta esiti funzionali/partecipativi e coordina in modo appropriato le risorse della rete.
- **Abile:** Personalizza obiettivi e interventi in base a funzionamento, motivazione e contesto; previene frammentazione e favorisce recovery e inclusione anche in situazioni complesse.
- **Esperto:** È riferimento nella progettazione di percorsi riabilitativi complessi, sviluppa lavoro di rete avanzato e orienta l'équipe a una lettura centrata su recovery e comunità.

RECV3 — Attuare interventi di consolidamento nei punti fragili della rete prevenendo frammentazione e garantendo continuità in contesti territoriali e residenziali

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Riabilitazione psicosociale e recovery

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di attuare interventi di consolidamento nei punti fragili della rete prevenendo frammentazione e garantendo continuità in contesti territoriali e residenziali nell'ambito di riabilitazione psicosociale e recovery. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare cronicizzazione passiva, perdita di autonomie e frammentazione della rete di supporto. La sua corretta espressione produce recovery, partecipazione e mantenimento del funzionamento nel contesto di vita e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Orientamento alle potenzialità della persona e del contesto di vita
- Orientamento alle capacità residue e alle risorse della persona e della rete
- Pazienza clinica e continuità nell'accompagnare processi di cambiamento graduale

Motivazioni

- Spostare il focus dal solo contenimento del sintomo alla partecipazione e alla cittadinanza possibile
- Favorire partecipazione, inclusione e qualità di vita oltre il controllo del sintomo
- Sostenere percorsi di autonomia realistica e di reintegrazione nei contesti di vita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di attuare interventi di consolidamento nei punti fragili della rete prevenendo frammentazione e garantendo continuità in contesti territoriali e residenziali
- Garantire continuità in contesti territoriali e residenziali
- Costruire obiettivi riabilitativi, lavorare con rete e attivare risorse comunitarie
- Definire obiettivi realistici e condivisi con persona, famiglia e rete

Conoscenze

- Recovery, riabilitazione psicosociale, gruppi terapeutici, rete formale/informale e prevenzione ricadute
- Gruppi psicoeducativi, social skills training, piano terapeutico riabilitativo individuale e rete sociale
- Modelli di recovery, riabilitazione psicosociale e funzionamento
- Strumenti di valutazione del funzionamento, partecipazione e obiettivi personalizzati
- Interventi evidence-based per inclusione, autonomie e prevenzione delle ricadute

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa agli interventi riabilitativi seguendo obiettivi e setting già definiti nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; osserva soprattutto bisogni evidenti e richiede guida nella lettura della rete e del funzionamento.
- **Principiante avanzato:** Riconosce risorse e ostacoli ricorrenti e contribuisce a obiettivi semplici; necessita di supporto per integrare contesto di vita, partecipazione e prevenzione delle ricadute.
- **Competente:** Definisce e realizza in autonomia programmi ordinari, valuta esiti funzionali/partecipativi e coordina in modo appropriato le risorse della rete.
- **Abile:** Personalizza obiettivi e interventi in base a funzionamento, motivazione e contesto; previene frammentazione e favorisce recovery e inclusione anche in situazioni complesse.
- **Esperto:** È riferimento nella progettazione di percorsi riabilitativi complessi, sviluppa lavoro di rete avanzato e orienta l'équipe a una lettura centrata su recovery e comunità.

Tutela legale e misure restrittive

TUTL1 — Coordinare i percorsi di accesso ai servizi in urgenza nel rispetto di diritti umani e civili applicando riferimenti etico-giuridici inclusa normativa su tso quando indicato

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Tutela legale e misure restrittive

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di coordinare i percorsi di accesso ai servizi in urgenza nel rispetto di diritti umani e civili applicando riferimenti etico-giuridici inclusa normativa su tso quando indicato nell'ambito di tutela legale e misure restrittive. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni non proporzionate, tutela insufficiente dei diritti e criticità documentali. La sua corretta espressione produce sicurezza, trasparenza e tutela bilanciata di persona, équipe e organizzazione e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Equilibrio tra fermezza clinica e tutela rigorosa dei diritti della persona
- Fermezza professionale unita a rispetto dei diritti e della dignità della persona
- Accuratezza documentale e consapevolezza del peso clinico-legale delle decisioni

Motivazioni

- Fare in modo che ogni misura restrittiva sia ultima scelta, motivata e rivalutata
- Garantire che gli interventi limitativi siano davvero necessari, proporzionati e tracciati
- Tutelare contemporaneamente sicurezza, diritti e trasparenza del percorso assistenziale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di coordinare i percorsi di accesso ai servizi in urgenza nel rispetto di diritti umani e civili applicando riferimenti etico-giuridici inclusa normativa su tso quando indicato
- Applicare riferimenti etico-giuridici inclusa normativa su tso quando indicato
- Applicare criteri clinico-legali, monitorare esiti e garantire documentazione completa delle restrizioni
- Applicare riferimenti normativi e criteri clinici nelle decisioni a rilevanza legale

Conoscenze

- Normativa su contenzione e diritti, criteri di necessità/proporzionalità, rivalutazione e tracciabilità
- Normativa su diritti, contenzione, TSO/ASO se rilevanti, documentazione e rivalutazione
- Quadro normativo, procedure aziendali e responsabilità professionali pertinenti
- Criteri di proporzionalità, necessità, consenso/informazione e tutela dei diritti
- Requisiti documentali e di tracciabilità nelle situazioni a rilievo medico-legale

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica norme, procedure e criteri di base seguendo indicazioni definite nel governo dei passaggi di cura, delle interfacce organizzative e delle priorità del percorso; necessita di supervisione per valutare proporzionalità, documentazione o implicazioni etico-legali.
- **Principiante avanzato:** Riconosce i principali profili di tutela e rischio giuridico nei casi frequenti; richiede confronto quando la situazione presenta conflitti di diritti, rischio elevato o forte pressione emotiva.
- **Competente:** Gestisce in autonomia i casi ordinari, documenta in modo accurato motivazioni e rivalutazioni e coinvolge i soggetti competenti secondo procedura.
- **Abile:** Bilancia in modo maturo sicurezza, diritti, contesto e conseguenze organizzative; anticipa criticità documentali/legali e sostiene il team nelle decisioni complesse.
- **Esperto:** È punto di riferimento per la lettura etico-legale del caso, promuove scelte proporzionate e contribuisce a procedure, audit e cultura della tutela nel servizio.

TUTL2 — Gestire contenzione ambientale meccanica relazionale e farmacologica applicando criteri clinici legali e di sicurezza con monitoraggio e rivalutazione della criticità

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Tutela legale e misure restrittive

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di gestire contenzione ambientale meccanica relazionale e farmacologica applicando criteri clinici legali e di sicurezza con monitoraggio e rivalutazione della criticità nell'ambito di tutela legale e misure restrittive. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni non proporzionate, tutela insufficiente dei diritti e criticità documentali. La sua corretta espressione produce sicurezza, trasparenza e tutela bilanciata di persona, équipe e organizzazione e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Equilibrio tra fermezza clinica e tutela rigorosa dei diritti della persona
- Fermezza professionale unita a rispetto dei diritti e della dignità della persona
- Accuratezza documentale e consapevolezza del peso clinico-legale delle decisioni

Motivazioni

- Fare in modo che ogni misura restrittiva sia ultima scelta, motivata e rivalutata
- Garantire che gli interventi limitativi siano davvero necessari, proporzionati e tracciati
- Tutelare contemporaneamente sicurezza, diritti e trasparenza del percorso assistenziale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di gestire contenzione ambientale meccanica relazionale e farmacologica applicando criteri clinici legali e di sicurezza con monitoraggio e rivalutazione della criticità
- Applicare criteri clinici legali e di sicurezza con monitoraggio e rivalutazione della criticità
- Applicare criteri clinico-legali, monitorare esiti e garantire documentazione completa delle restrizioni
- Applicare riferimenti normativi e criteri clinici nelle decisioni a rilevanza legale

Conoscenze

- Normativa su contenzione e diritti, criteri di necessità/proporzionalità, rivalutazione e tracciabilità
- Normativa su diritti, contenzione, TSO/ASO se rilevanti, documentazione e rivalutazione
- Quadro normativo, procedure aziendali e responsabilità professionali pertinenti
- Criteri di proporzionalità, necessità, consenso/informazione e tutela dei diritti
- Requisiti documentali e di tracciabilità nelle situazioni a rilievo medico-legale

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica norme, procedure e criteri di base seguendo indicazioni definite nella lettura corretta dei dati, dei trend e del loro significato clinico; necessita di supervisione per valutare proporzionalità, documentazione o implicazioni etico-legali.
- **Principiante avanzato:** Riconosce i principali profili di tutela e rischio giuridico nei casi frequenti; richiede confronto quando la situazione presenta conflitti di diritti, rischio elevato o forte pressione emotiva.
- **Competente:** Gestisce in autonomia i casi ordinari, documenta in modo accurato motivazioni e rivalutazioni e coinvolge i soggetti competenti secondo procedura.
- **Abile:** Bilancia in modo maturo sicurezza, diritti, contesto e conseguenze organizzative; anticipa criticità documentali/legali e sostiene il team nelle decisioni complesse.
- **Esperto:** È punto di riferimento per la lettura etico-legale del caso, promuove scelte proporzionate e contribuisce a procedure, audit e cultura della tutela nel servizio.

TUTL3 — Documentare eventi critici e interventi restrittivi garantendo tracciabilità motivazione clinica tempi rivalutazioni e esiti secondo standard normativi

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Tutela legale e misure restrittive

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di documentare eventi critici e interventi restrittivi garantendo tracciabilità motivazione clinica tempi rivalutazioni e esiti secondo standard normativi nell'ambito di tutela legale e misure restrittive. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni non proporzionate, tutela insufficiente dei diritti e criticità documentali. La sua corretta espressione produce sicurezza, trasparenza e tutela bilanciata di persona, équipe e organizzazione e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Equilibrio tra fermezza clinica e tutela rigorosa dei diritti della persona
- Fermezza professionale unita a rispetto dei diritti e della dignità della persona
- Accuratezza documentale e consapevolezza del peso clinico-legale delle decisioni

Motivazioni

- Fare in modo che ogni misura restrittiva sia ultima scelta, motivata e rivalutata
- Garantire che gli interventi limitativi siano davvero necessari, proporzionati e tracciati
- Tutelare contemporaneamente sicurezza, diritti e trasparenza del percorso assistenziale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di documentare eventi critici e interventi restrittivi garantendo tracciabilità motivazione clinica tempi rivalutazioni e esiti secondo standard normativi
- Garantire tracciabilità motivazione clinica tempi rivalutazioni e esiti secondo standard normativi
- Applicare criteri clinico-legali, monitorare esiti e garantire documentazione completa delle restrizioni
- Applicare riferimenti normativi e criteri clinici nelle decisioni a rilevanza legale

Conoscenze

- Normativa su contenzione e diritti, criteri di necessità/proporzionalità, rivalutazione e tracciabilità
- Normativa su diritti, contenzione, TSO/ASO se rilevanti, documentazione e rivalutazione
- Quadro normativo, procedure aziendali e responsabilità professionali pertinenti
- Criteri di proporzionalità, necessità, consenso/informazione e tutela dei diritti
- Requisiti documentali e di tracciabilità nelle situazioni a rilievo medico-legale

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica norme, procedure e criteri di base seguendo indicazioni definite nel bilanciare tutela, sicurezza, diritti e requisiti documentali; necessita di supervisione per valutare proporzionalità, documentazione o implicazioni etico-legali.
- **Principiante avanzato:** Riconosce i principali profili di tutela e rischio giuridico nei casi frequenti; richiede confronto quando la situazione presenta conflitti di diritti, rischio elevato o forte pressione emotiva.
- **Competente:** Gestisce in autonomia i casi ordinari, documenta in modo accurato motivazioni e rivalutazioni e coinvolge i soggetti competenti secondo procedura.
- **Abile:** Bilancia in modo maturo sicurezza, diritti, contesto e conseguenze organizzative; anticipa criticità documentali/legali e sostiene il team nelle decisioni complesse.
- **Esperto:** È punto di riferimento per la lettura etico-legale del caso, promuove scelte proporzionate e contribuisce a procedure, audit e cultura della tutela nel servizio.

Lavoro di rete

RET1 — Individua,ricerca e applica forme di azione collettiva e forme di azioni partecipativa volte al fare "Comunità",convolgendo tutti gli attori presenti nel territorio di riferimento

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Lavoro di rete

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di individua,ricerca e applica forme di azione collettiva e forme di azioni partecipativa volte al fare "Comunità",convolgendo tutti gli attori presenti nel territorio di riferimento nell'ambito di lavoro di rete. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare cronicizzazione passiva, perdita di autonomie e frammentazione della rete di supporto. La sua corretta espressione produce recovery, partecipazione e mantenimento del funzionamento nel contesto di vita e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Atteggiamento critico verso routine non supportate da evidenze
- Sguardo allargato ai determinanti sociali e ambientali della salute
- Orientamento alle capacità residue e alle risorse della persona e della rete

Motivazioni

- Trasformare l'aggiornamento professionale in miglioramento concreto della pratica
- Intercettare precocemente fragilità che tendono a restare invisibili ai servizi
- Favorire partecipazione, inclusione e qualità di vita oltre il controllo del sintomo

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di individua,ricerca e applica forme di azione collettiva e forme di azioni partecipativa volte al fare "Comunità",convolgendo tutti gli attori presenti nel territorio di riferimento
- Valutare affidabilità delle fonti e trasferibilità delle evidenze al contesto locale
- Leggere dati di popolazione e segnali di vulnerabilità per orientare interventi mirati
- Definire obiettivi realistici e condivisi con persona, famiglia e rete

Conoscenze

- Quesiti clinico-assistenziali, PICO, criteri di qualità metodologica e applicabilità dei risultati
- Epidemiologia di comunità, indicatori di vulnerabilità, reti territoriali e meccanismi di tutela
- Rete dei servizi, integrazione socio-sanitaria, partecipazione comunitaria e continuità dei percorsi
- Modelli di recovery, riabilitazione psicosociale e funzionamento
- Strumenti di valutazione del funzionamento, partecipazione e obiettivi personalizzati

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa agli interventi riabilitativi seguendo obiettivi e setting già definiti nell'uso rigoroso delle evidenze, dei protocolli e della documentazione; osserva soprattutto bisogni evidenti e richiede guida nella lettura della rete e del funzionamento.
- **Principiante avanzato:** Riconosce risorse e ostacoli ricorrenti e contribuisce a obiettivi semplici; necessita di supporto per integrare contesto di vita, partecipazione e prevenzione delle ricadute.
- **Competente:** Definisce e realizza in autonomia programmi ordinari, valuta esiti funzionali/partecipativi e coordina in modo appropriato le risorse della rete.
- **Abile:** Personalizza obiettivi e interventi in base a funzionamento, motivazione e contesto; previene frammentazione e favorisce recovery e inclusione anche in situazioni complesse.
- **Esperto:** È riferimento nella progettazione di percorsi riabilitativi complessi, sviluppa lavoro di rete avanzato e orienta l'équipe a una lettura centrata su recovery e comunità.

RET2 — Integra i progetti per la salute mentale unificando percorsi clinici riabilitativi nei contesti di vita e istituzionali ,superando la dicotomia tra cura e reinserimento sociale

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Lavoro di rete

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di integra i progetti per la salute mentale unificando percorsi clinici riabilitativi nei contesti di vita e istituzionali ,superando la dicotomia tra cura e reinserimento sociale nell’ambito di lavoro di rete. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare cronicizzazione passiva, perdita di autonomie e frammentazione della rete di supporto. La sua corretta espressione produce recovery, partecipazione e mantenimento del funzionamento nel contesto di vita e rende più affidabile il contributo infermieristico all’interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Orientamento alle potenzialità della persona e del contesto di vita
- Orientamento alle capacità residue e alle risorse della persona e della rete
- Pazienza clinica e continuità nell’accompagnare processi di cambiamento graduale

Motivazioni

- Spostare il focus dal solo contenimento del sintomo alla partecipazione e alla cittadinanza possibile
- Favorire partecipazione, inclusione e qualità di vita oltre il controllo del sintomo
- Sostenere percorsi di autonomia realistica e di reintegrazione nei contesti di vita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di integra i progetti per la salute mentale unificando percorsi clinici riabilitativi nei contesti di vita e istituzionali ,superando la dicotomia tra cura e reinserimento sociale
- Costruire obiettivi riabilitativi, lavorare con rete e attivare risorse comunitarie
- Definire obiettivi realistici e condivisi con persona, famiglia e rete
- Attuare interventi strutturati di riabilitazione/abilitazione e valutarne gli esiti

Conoscenze

- Recovery, riabilitazione psicosociale, gruppi terapeutici, rete formale/informale e prevenzione ricadute
- Rete dei servizi, integrazione socio-sanitaria, partecipazione comunitaria e continuità dei percorsi
- Modelli di recovery, riabilitazione psicosociale e funzionamento
- Strumenti di valutazione del funzionamento, partecipazione e obiettivi personalizzati
- Interventi evidence-based per inclusione, autonomie e prevenzione delle ricadute

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa agli interventi riabilitativi seguendo obiettivi e setting già definiti nel trasformare gli obiettivi clinici in funzionamento e partecipazione; osserva soprattutto bisogni evidenti e richiede guida nella lettura della rete e del funzionamento.
- **Principiante avanzato:** Riconosce risorse e ostacoli ricorrenti e contribuisce a obiettivi semplici; necessita di supporto per integrare contesto di vita, partecipazione e prevenzione delle ricadute.
- **Competente:** Definisce e realizza in autonomia programmi ordinari, valuta esiti funzionali/partecipativi e coordina in modo appropriato le risorse della rete.
- **Abile:** Personalizza obiettivi e interventi in base a funzionamento, motivazione e contesto; previene frammentazione e favorisce recovery e inclusione anche in situazioni complesse.
- **Esperto:** È riferimento nella progettazione di percorsi riabilitativi complessi, sviluppa lavoro di rete avanzato e orienta l'équipe a una lettura centrata su recovery e comunità.

RET3 — Utilizzare un approccio strutturato per valutare e dare priorità iniziale ai pazienti con problemi di salute mentale acuta (triage),utilizzando strumenti di valutazione concordati localmente

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Lavoro di rete

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di utilizzare un approccio strutturato per valutare e dare priorità iniziale ai pazienti con problemi di salute mentale acuta (triage),utilizzando strumenti di valutazione concordati localmente nell'ambito di lavoro di rete. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare cronicizzazione passiva, perdita di autonomie e frammentazione della rete di supporto. La sua corretta espressione produce recovery, partecipazione e mantenimento del funzionamento nel contesto di vita e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Capacità di decidere rapidamente senza perdere metodo e rivalutazione critica
- Orientamento alle capacità residue e alle risorse della persona e della rete
- Pazienza clinica e continuità nell'accompagnare processi di cambiamento graduale

Motivazioni

- Allocare con giustizia clinica tempi e risorse in base a gravità e rischio evolutivo
- Favorire partecipazione, inclusione e qualità di vita oltre il controllo del sintomo
- Sostenere percorsi di autonomia realistica e di reintegrazione nei contesti di vita

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di utilizzare un approccio strutturato per valutare e dare priorità iniziale ai pazienti con problemi di salute mentale acuta (triage),utilizzando strumenti di valutazione concordati localmente
- Utilizzare strumenti di valutazione concordati localmente
- Classificare, rivalutare e ridefinire la priorità sulla base dell'evoluzione clinica
- Definire obiettivi realistici e condivisi con persona, famiglia e rete

Conoscenze

- Discriminatori di triage, red flags, percorsi tempo-dipendenti e principi di rivalutazione
- Rete dei servizi, integrazione socio-sanitaria, partecipazione comunitaria e continuità dei percorsi
- Modelli di recovery, riabilitazione psicosociale e funzionamento
- Strumenti di valutazione del funzionamento, partecipazione e obiettivi personalizzati
- Interventi evidence-based per inclusione, autonomie e prevenzione delle ricadute

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Partecipa agli interventi riabilitativi seguendo obiettivi e setting già definiti nell'uso rigoroso delle evidenze, dei protocolli e della documentazione; osserva soprattutto bisogni evidenti e richiede guida nella lettura della rete e del funzionamento.
- **Principiante avanzato:** Riconosce risorse e ostacoli ricorrenti e contribuisce a obiettivi semplici; necessita di supporto per integrare contesto di vita, partecipazione e prevenzione delle ricadute.
- **Competente:** Definisce e realizza in autonomia programmi ordinari, valuta esiti funzionali/partecipativi e coordina in modo appropriato le risorse della rete.
- **Abile:** Personalizza obiettivi e interventi in base a funzionamento, motivazione e contesto; previene frammentazione e favorisce recovery e inclusione anche in situazioni complesse.
- **Esperto:** È riferimento nella progettazione di percorsi riabilitativi complessi, sviluppa lavoro di rete avanzato e orienta l'équipe a una lettura centrata su recovery e comunità.

Relazione

REL1 — Realizza un clima di accettazione ,apertura e accoglienza,instaurando una relazione terapeutica

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Relazione

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di realizzare un clima di accettazione ,apertura e accoglienza,instaurando una relazione terapeutica nell'ambito di relazione. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Sensibilità ai bisogni emotivi e informativi espressi o impliciti
- Capacità di mantenere coerenza tra contenuto, tono e postura professionale
- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale

Motivazioni

- Rendere comprensibile il percorso di cura e favorire scelte realmente consapevoli
- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura
- Riconoscere la dignità della persona anche nelle condizioni di vulnerabilità o conflitto

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di realizzare un clima di accettazione ,apertura e accoglienza,instaurando una relazione terapeutica
- Verificare comprensione, dubbi, consenso e necessità di rinforzo informativo
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona
- Adattare linguaggio, tono, postura e tempi comunicativi al contesto

Conoscenze

- Principi di comunicazione efficace, decisione condivisa, consenso e adattamento del linguaggio
- Alleanza terapeutica, comunicazione verbale/non verbale e gestione della partecipazione emotiva
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica
- Aspetti etici e di privacy connessi alla relazione di cura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel modulare la relazione, contenere il rischio e scegliere il livello di intervento più adeguato; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.
- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

REL2 — Adatta le tecniche comunicative verbali e non verbali in relazione all'intellocutore

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Relazione

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di adattare le tecniche comunicative verbali e non verbali in relazione all'intellocutore nell'ambito di relazione. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell'alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Sensibilità ai bisogni emotivi e informativi espressi o impliciti
- Capacità di mantenere coerenza tra contenuto, tono e postura professionale
- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale

Motivazioni

- Rendere comprensibile il percorso di cura e favorire scelte realmente consapevoli
- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura
- Riconoscere la dignità della persona anche nelle condizioni di vulnerabilità o conflitto

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di adattare le tecniche comunicative verbali e non verbali in relazione all'intellocutore
- Verificare comprensione, dubbi, consenso e necessità di rinforzo informativo
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona
- Adattare linguaggio, tono, postura e tempi comunicativi al contesto

Conoscenze

- Principi di comunicazione efficace, decisione condivisa, consenso e adattamento del linguaggio
- Alleanza terapeutica, comunicazione verbale/non verbale e gestione della partecipazione emotiva
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l'alleanza terapeutica
- Aspetti etici e di privacy connessi alla relazione di cura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel modulare la relazione, contenere il rischio e scegliere il livello di intervento più adeguato; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.

- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

REL3 — Partecipa e condivide, con la giusta distanza emotiva, le sensazioni del paziente ,per aiutarlo a vedere più chiaramente le proprie preoccupazioni e difficoltà

Area/Pannello: Area della Salute Mentale e Dipendenze / Dimensione: Relazione

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di partecipa e condivide, con la giusta distanza emotiva, le sensazioni del paziente ,per aiutarlo a vedere più chiaramente le proprie preoccupazioni e difficoltà nell’ambito di relazione. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare rottura dell’alleanza terapeutica, incomprensioni e aumento della vulnerabilità relazionale. La sua corretta espressione produce fiducia, alleanza e migliore possibilità di lavoro terapeutico condiviso e rende più affidabile il contributo infermieristico all’interno di area della Salute Mentale e Dipendenze.

Attitudini

- Presenza autentica, rispetto e capacità di modulare la distanza professionale
- Attenzione ai significati emotivi e relazionali della situazione assistenziale
- Coerenza tra comunicazione verbale, non verbale e intenzionalità terapeutica

Motivazioni

- Costruire una relazione che renda possibile fiducia, alleanza e adesione al percorso di cura
- Riconoscere la dignità della persona anche nelle condizioni di vulnerabilità o conflitto
- Utilizzare la relazione come strumento clinico e non come semplice scambio informativo

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di partecipa e condivide, con la giusta distanza emotiva, le sensazioni del paziente ,per aiutarlo a vedere più chiaramente le proprie preoccupazioni e difficoltà
- Stabilire un setting relazionale sicuro e coerente con il bisogno della persona
- Adattare linguaggio, tono, postura e tempi comunicativi al contesto
- Gestire colloqui difficili mantenendo contenimento emotivo e chiarezza professionale

Conoscenze

- Alleanza terapeutica, comunicazione verbale/non verbale e gestione della partecipazione emotiva
- Principi di comunicazione terapeutica, ascolto attivo e gestione del colloquio
- Meccanismi di difesa, reazioni emotive e fattori che influenzano l’alleanza terapeutica
- Aspetti etici e di privacy connessi alla relazione di cura

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Utilizza modalità relazionali di base seguendo indicazioni e cornici già definite nel mantenere un setting terapeutico chiaro, rispettoso e funzionale; fatica ancora a leggere significati complessi o a modulare la distanza professionale.

- **Principiante avanzato:** Riconosce dinamiche emotive e comunicative ricorrenti e adatta parzialmente la propria postura; nei colloqui o nelle crisi più complesse richiede sostegno.
- **Competente:** Conduce in autonomia relazioni terapeutiche ordinarie, mantiene un setting chiaro, raccoglie dati utili e usa la comunicazione in modo intenzionale e documentato.
- **Abile:** Legge la relazione come parte del quadro clinico, anticipa escalation o rotture dell'alleanza e modula presenza, parole e setting in modo fine e coerente.
- **Esperto:** Gestisce con padronanza situazioni relazionali ad alta complessità, sostiene l'équipe nel contenimento emotivo e contribuisce a modelli condivisi di lavoro terapeutico.

Gestione del rischio ostetrico ginecologico

RSK1 — Individuare le situazioni di fragilità e di rischio psicosociale, abuso e maltrattamento e se necessario, intervenire e coinvolgere le autorità preposte

Area/Pannello: Area Ostetrico-Ginecologica / Dimensione: Gestione del rischio ostetrico ginecologico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di individuare le situazioni di fragilità e di rischio psicosociale, abuso e maltrattamento e se necessario, intervenire e coinvolgere le autorità preposte nell'ambito di gestione del rischio ostetrico ginecologico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni non proporzionate, tutela insufficiente dei diritti e criticità documentali. La sua corretta espressione produce sicurezza, trasparenza e tutela bilanciata di persona, équipe e organizzazione e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Ostetrico-Ginecologica.

Attitudini

- Tolleranza all'ambiguità clinica e capacità di osservazione non giudicante
- Capacità di cogliere segnali di vulnerabilità senza colpevolizzare né banalizzare
- Fermezza professionale unita a rispetto dei diritti e della dignità della persona

Motivazioni

- Comprendere il significato del comportamento e ridurre risposte impulsive o stigmatizzanti
- Proteggere la donna da ulteriori danni e attivare percorsi di tutela appropriati e tempestivi
- Garantire che gli interventi limitativi siano davvero necessari, proporzionati e tracciati

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di individuare le situazioni di fragilità e di rischio psicosociale, abuso e maltrattamento e se necessario, intervenire e coinvolgere le autorità preposte
- Raccogliere dati osservativi, anamnestici e relazionali per formulare valutazione infermieristica condivisa
- Rilevare indicatori di violenza/abuso, garantire setting protetto e coinvolgere servizi/autorità competenti
- Applicare riferimenti normativi e criteri clinici nelle decisioni a rilevanza legale

Conoscenze

- Esame dello stato mentale, urgenza psichiatrica, rischio suicidario/aggressivo e setting terapeutico
- Indicatori di abuso/maltrattamento, percorso rosa o equivalenti, raccolta/protezione delle evidenze e tutela della privacy

- Emergenze ostetrico-ginecologiche, rischio psicosociale, IVG, violenza sessuale e continuità nascita-puerperio
- Quadro normativo, procedure aziendali e responsabilità professionali pertinenti
- Criteri di proporzionalità, necessità, consenso/informazione e tutela dei diritti

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica norme, procedure e criteri di base seguendo indicazioni definite nel bilanciare tutela, sicurezza, diritti e requisiti documentali; necessita di supervisione per valutare proporzionalità, documentazione o implicazioni etico-legali.
- **Principiante avanzato:** Riconosce i principali profili di tutela e rischio giuridico nei casi frequenti; richiede confronto quando la situazione presenta conflitti di diritti, rischio elevato o forte pressione emotiva.
- **Competente:** Gestisce in autonomia i casi ordinari, documenta in modo accurato motivazioni e rivalutazioni e coinvolge i soggetti competenti secondo procedura.
- **Abile:** Bilancia in modo maturo sicurezza, diritti, contesto e conseguenze organizzative; anticipa criticità documentali/legali e sostiene il team nelle decisioni complesse.
- **Esperto:** È punto di riferimento per la lettura etico-legale del caso, promuove scelte proporzionate e contribuisce a procedure, audit e cultura della tutela nel servizio.

RSK2 — Valutare il fabbisogno educativo-informativo della donna e pianificare in interventi orientati al sostegno, all'autocura ed al recupero funzionale. Promozione dell'autonomia e delle capacità di autocura della donna e della coppia, nel rispetto dei valori etici, religiosi, culturali e delle risorse di sponibili

Area/Pannello: Area Ostetrico-Ginecologica / Dimensione: Gestione del rischio ostetrico ginecologico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di valutare il fabbisogno educativo-informativo della donna e pianificare in interventi orientati al sostegno, all'autocura ed al recupero funzionale. Promozione dell'autonomia e delle capacità di autocura della donna e della coppia, nel rispetto dei valori etici, religiosi, culturali e delle risorse di sponibili nell'ambito di gestione del rischio ostetrico ginecologico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni non proporzionate, tutela insufficiente dei diritti e criticità documentali. La sua corretta espressione produce sicurezza, trasparenza e tutela bilanciata di persona, équipe e organizzazione e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Ostetrico-Ginecologica.

Attitudini

- Orientamento a valorizzare risorse, priorità e tempi di apprendimento della persona
- Attenzione alle dimensioni cliniche, relazionali e culturali che attraversano il percorso della donna
- Fermezza professionale unita a rispetto dei diritti e della dignità della persona

Motivazioni

- Favorire autonomia sostenibile e ridurre dipendenza evitabile dal sistema sanitario
- Sostenere sicurezza, autonomia informata e continuità lungo gravidanza, parto e puerperio
- Garantire che gli interventi limitativi siano davvero necessari, proporzionati e tracciati

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di valutare il fabbisogno educativo-informativo della donna e pianificare in interventi orientati al sostegno, all'autocura ed al recupero funzionale. Promozione dell'autonomia e delle capacità di autocura della donna e della coppia, nel rispetto dei valori etici, religiosi, culturali e delle risorse di sponibili
- Strutturare messaggi prioritari, rinforzi educativi e verifica del ritorno informativo
- Applicare riferimenti normativi e criteri clinici nelle decisioni a rilevanza legale
- Documentare motivazioni, tempi, rivalutazioni ed esiti con precisione

Conoscenze

- Health literacy, teach-back, aderenza terapeutica e strategie di rinforzo dell'autogestione
- Fisiologia e rischio ostetrico-ginecologico, educazione alla donna/coppia e continuità del percorso nascita
- Emergenze ostetrico-ginecologiche, rischio psicosociale, IVG, violenza sessuale e continuità nascita-puerperio
- Quadro normativo, procedure aziendali e responsabilità professionali pertinenti
- Criteri di proporzionalità, necessità, consenso/informazione e tutela dei diritti

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica norme, procedure e criteri di base seguendo indicazioni definite nella personalizzazione dei messaggi, nella verifica della comprensione e nel sostegno all'autonomia; necessita di supervisione per valutare proporzionalità, documentazione o implicazioni etico-legali.
- **Principiante avanzato:** Riconosce i principali profili di tutela e rischio giuridico nei casi frequenti; richiede confronto quando la situazione presenta conflitti di diritti, rischio elevato o forte pressione emotiva.
- **Competente:** Gestisce in autonomia i casi ordinari, documenta in modo accurato motivazioni e rivalutazioni e coinvolge i soggetti competenti secondo procedura.
- **Abile:** Bilancia in modo maturo sicurezza, diritti, contesto e conseguenze organizzative; anticipa criticità documentali/legali e sostiene il team nelle decisioni complesse.
- **Esperto:** È punto di riferimento per la lettura etico-legale del caso, promuove scelte proporzionate e contribuisce a procedure, audit e cultura della tutela nel servizio.

RSK3 — Capacità di riconoscere e gestire situazioni di emergenza ginecologica e ostetrica, protocolli di sicurezza clinica.

Area/Pannello: Area Ostetrico-Ginecologica / Dimensione: Gestione del rischio ostetrico ginecologico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere e gestire situazioni di emergenza ginecologica e ostetrica, protocolli di sicurezza clinica nell'ambito di gestione del rischio ostetrico ginecologico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni non proporzionate, tutela insufficiente dei diritti e criticità documentali. La sua corretta espressione produce sicurezza, trasparenza e tutela bilanciata di persona, équipe e organizzazione e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Ostetrico-Ginecologica.

Attitudini

- Attenzione alle dimensioni cliniche, relazionali e culturali che attraversano il percorso della donna
- Fermezza professionale unita a rispetto dei diritti e della dignità della persona
- Accuratezza documentale e consapevolezza del peso clinico-legale delle decisioni

Motivazioni

- Sostenere sicurezza, autonomia informata e continuità lungo gravidanza, parto e puerperio
- Garantire che gli interventi limitativi siano davvero necessari, proporzionati e tracciati
- Tutelare contemporaneamente sicurezza, diritti e trasparenza del percorso assistenziale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere e gestire situazioni di emergenza ginecologica e ostetrica, protocolli di sicurezza clinica
- Applicare riferimenti normativi e criteri clinici nelle decisioni a rilevanza legale
- Documentare motivazioni, tempi, rivalutazioni ed esiti con precisione
- Coinvolgere équipe, autorità o servizi competenti secondo le procedure previste

Conoscenze

- Fisiologia e rischio ostetrico-ginecologico, educazione alla donna/coppia e continuità del percorso nascita
- Emergenze ostetrico-ginecologiche, rischio psicosociale, IVG, violenza sessuale e continuità nascita-puerperio
- Quadro normativo, procedure aziendali e responsabilità professionali pertinenti
- Criteri di proporzionalità, necessità, consenso/informazione e tutela dei diritti
- Requisiti documentali e di tracciabilità nelle situazioni a rilievo medico-legale

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica norme, procedure e criteri di base seguendo indicazioni definite nel bilanciare tutela, sicurezza, diritti e requisiti documentali; necessita di supervisione per valutare proporzionalità, documentazione o implicazioni etico-legali.
- **Principiante avanzato:** Riconosce i principali profili di tutela e rischio giuridico nei casi frequenti; richiede confronto quando la situazione presenta conflitti di diritti, rischio elevato o forte pressione emotiva.
- **Competente:** Gestisce in autonomia i casi ordinari, documenta in modo accurato motivazioni e rivalutazioni e coinvolge i soggetti competenti secondo procedura.
- **Abile:** Bilancia in modo maturo sicurezza, diritti, contesto e conseguenze organizzative; anticipa criticità documentali/legali e sostiene il team nelle decisioni complesse.
- **Esperto:** È punto di riferimento per la lettura etico-legale del caso, promuove scelte proporzionate e contribuisce a procedure, audit e cultura della tutela nel servizio.

RSK5 — Condividere il percorso nascita nei programmi di continuità assistenziale previsti per gravidanza, puerperio ed allattamento e nella prevenzione della depressione post partum

Area/Pannello: Area Ostetrico-Ginecologica / Dimensione: Gestione del rischio ostetrico ginecologico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di condividere il percorso nascita nei programmi di continuità assistenziale previsti per gravidanza, puerperio ed allattamento e nella prevenzione della depressione post partum nell'ambito di gestione del rischio ostetrico ginecologico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni non proporzionate, tutela insufficiente dei diritti e criticità documentali. La sua corretta espressione produce sicurezza, trasparenza e tutela bilanciata di persona, équipe e organizzazione e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Ostetrico-Ginecologica.

Attitudini

- Attenzione alle dimensioni cliniche, relazionali e culturali che attraversano il percorso della donna
- Fermezza professionale unita a rispetto dei diritti e della dignità della persona
- Accuratezza documentale e consapevolezza del peso clinico-legale delle decisioni

Motivazioni

- Sostenere sicurezza, autonomia informata e continuità lungo gravidanza, parto e puerperio
- Garantire che gli interventi limitativi siano davvero necessari, proporzionati e tracciati
- Tutelare contemporaneamente sicurezza, diritti e trasparenza del percorso assistenziale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di condividere il percorso nascita nei programmi di continuità assistenziale previsti per gravidanza, puerperio ed allattamento e nella prevenzione della depressione post partum
- Osservare attacco, trasferimento di latte, coordinazione suzione-deglutizione-respirazione e segni di efficacia della poppata
- Applicare riferimenti normativi e criteri clinici nelle decisioni a rilevanza legale
- Documentare motivazioni, tempi, rivalutazioni ed esiti con precisione

Conoscenze

- Fisiologia della lattazione, segnali di poppata efficace, difficoltà di attacco e sostegno alla diade
- Fisiologia e rischio ostetrico-ginecologico, educazione alla donna/coppia e continuità del percorso nascita
- Emergenze ostetrico-ginecologiche, rischio psicosociale, IVG, violenza sessuale e continuità nascita-puerperio
- Quadro normativo, procedure aziendali e responsabilità professionali pertinenti
- Criteri di proporzionalità, necessità, consenso/informazione e tutela dei diritti

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica norme, procedure e criteri di base seguendo indicazioni definite nella personalizzazione dei messaggi, nella verifica della comprensione e nel sostegno all'autonomia; necessita di supervisione per valutare proporzionalità, documentazione o implicazioni etico-legali.
- **Principiante avanzato:** Riconosce i principali profili di tutela e rischio giuridico nei casi frequenti; richiede confronto quando la situazione presenta conflitti di diritti, rischio elevato o forte pressione emotiva.
- **Competente:** Gestisce in autonomia i casi ordinari, documenta in modo accurato motivazioni e rivalutazioni e coinvolge i soggetti competenti secondo procedura.
- **Abile:** Bilancia in modo maturo sicurezza, diritti, contesto e conseguenze organizzative; anticipa criticità documentali/legali e sostiene il team nelle decisioni complesse.
- **Esperto:** È punto di riferimento per la lettura etico-legale del caso, promuove scelte proporzionate e contribuisce a procedure, audit e cultura della tutela nel servizio.

RSK7 — Conoscere ed utilizza i protocolli specifici ed i termini di legge relativi all'interruzione di gravidanza volontaria ed alla gestione della paziente con aborto spontaneo

Area/Pannello: Area Ostetrico-Ginecologica / Dimensione: Gestione del rischio ostetrico ginecologico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di conoscere ed utilizza i protocolli specifici ed i termini di legge relativi all'interruzione di gravidanza volontaria ed alla gestione della paziente con aborto spontaneo nell'ambito di gestione del rischio ostetrico ginecologico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni non proporzionate, tutela insufficiente dei diritti e criticità documentali. La sua corretta espressione produce sicurezza, trasparenza e tutela bilanciata di persona, équipe e organizzazione e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Ostetrico-Ginecologica.

Attitudini

- Attenzione alle dimensioni cliniche, relazionali e culturali che attraversano il percorso della donna
- Rispetto rigoroso dell'autodeterminazione e dei vissuti emotivi della donna
- Fermezza professionale unita a rispetto dei diritti e della dignità della persona

Motivazioni

- Sostenere sicurezza, autonomia informata e continuità lungo gravidanza, parto e puerperio
- Offrire un'assistenza competente, non giudicante e aderente ai riferimenti di legge
- Garantire che gli interventi limitativi siano davvero necessari, proporzionati e tracciati

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di conoscere ed utilizza i protocolli specifici ed i termini di legge relativi all'interruzione di gravidanza volontaria ed alla gestione della paziente con aborto spontaneo
- Applicare protocolli, tempi e informazioni necessarie nei percorsi di IVG o aborto spontaneo
- Applicare riferimenti normativi e criteri clinici nelle decisioni a rilevanza legale
- Documentare motivazioni, tempi, rivalutazioni ed esiti con precisione

Conoscenze

- Fisiologia e rischio ostetrico-ginecologico, educazione alla donna/coppia e continuità del percorso nascita
- Quadro normativo IVG, protocolli clinico-assistenziali, supporto emotivo e follow-up
- Emergenze ostetrico-ginecologiche, rischio psicosociale, IVG, violenza sessuale e continuità nascita-puerperio
- Quadro normativo, procedure aziendali e responsabilità professionali pertinenti
- Criteri di proporzionalità, necessità, consenso/informazione e tutela dei diritti

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica norme, procedure e criteri di base seguendo indicazioni definite nel bilanciare tutela, sicurezza, diritti e requisiti documentali; necessita di supervisione per valutare proporzionalità, documentazione o implicazioni etico-legali.
- **Principiante avanzato:** Riconosce i principali profili di tutela e rischio giuridico nei casi frequenti; richiede confronto quando la situazione presenta conflitti di diritti, rischio elevato o forte pressione emotiva.
- **Competente:** Gestisce in autonomia i casi ordinari, documenta in modo accurato motivazioni e rivalutazioni e coinvolge i soggetti competenti secondo procedura.
- **Abile:** Bilancia in modo maturo sicurezza, diritti, contesto e conseguenze organizzative; anticipa criticità documentali/legali e sostiene il team nelle decisioni complesse.
- **Esperto:** È punto di riferimento per la lettura etico-legale del caso, promuove scelte proporzionate e contribuisce a procedure, audit e cultura della tutela nel servizio.

RSK8 — Riconoscere e avviare le procedure riguardanti l'impatto emotivo e fisico di violenza sessuale o stupro

Area/Pannello: Area Ostetrico-Ginecologica / Dimensione: Gestione del rischio ostetrico ginecologico

Razionale

Questa competenza presidia la capacità di riconoscere e avviare le procedure riguardanti l'impatto emotivo e fisico di violenza sessuale o stupro nell'ambito di gestione del rischio ostetrico ginecologico. È rilevante perché, in questo contesto, richiede di integrare valutazione, decisione assistenziale e responsabilità professionale per evitare decisioni non proporzionate, tutela insufficiente dei diritti e criticità documentali. La sua corretta espressione produce sicurezza, trasparenza e tutela bilanciata di persona, équipe e organizzazione e rende più affidabile il contributo infermieristico all'interno di area Ostetrico-Ginecologica.

Attitudini

- Capacità di cogliere segnali di vulnerabilità senza colpevolizzare né banalizzare
- Fermezza professionale unita a rispetto dei diritti e della dignità della persona
- Accuratezza documentale e consapevolezza del peso clinico-legale delle decisioni

Motivazioni

- Proteggere la donna da ulteriori danni e attivare percorsi di tutela appropriati e tempestivi
- Garantire che gli interventi limitativi siano davvero necessari, proporzionati e tracciati
- Tutelare contemporaneamente sicurezza, diritti e trasparenza del percorso assistenziale

Skills

- Presidiare operativamente la capacità di riconoscere e avviare le procedure riguardanti l'impatto emotivo e fisico di violenza sessuale o stupro
- Rilevare indicatori di violenza/abuso, garantire setting protetto e coinvolgere servizi/autorità competenti
- Applicare riferimenti normativi e criteri clinici nelle decisioni a rilevanza legale
- Documentare motivazioni, tempi, rivalutazioni ed esiti con precisione

Conoscenze

- Indicatori di abuso/maltrattamento, percorso rosa o equivalenti, raccolta/protezione delle evidenze e tutela della privacy
- Emergenze ostetrico-ginecologiche, rischio psicosociale, IVG, violenza sessuale e continuità nascita-puerperio
- Quadro normativo, procedure aziendali e responsabilità professionali pertinenti
- Criteri di proporzionalità, necessità, consenso/informazione e tutela dei diritti
- Requisiti documentali e di tracciabilità nelle situazioni a rilievo medico-legale

Definizione situata della competenza secondo Benner

- **Novizio:** Applica norme, procedure e criteri di base seguendo indicazioni definite nel bilanciare tutela, sicurezza, diritti e requisiti documentali; necessita di supervisione per valutare proporzionalità, documentazione o implicazioni etico-legali.
- **Principiante avanzato:** Riconosce i principali profili di tutela e rischio giuridico nei casi frequenti; richiede confronto quando la situazione presenta conflitti di diritti, rischio elevato o forte pressione emotiva.
- **Competente:** Gestisce in autonomia i casi ordinari, documenta in modo accurato motivazioni e rivalutazioni e coinvolge i soggetti competenti secondo procedura.
- **Abile:** Bilancia in modo maturo sicurezza, diritti, contesto e conseguenze organizzative; anticipa criticità documentali/legali e sostiene il team nelle decisioni complesse.
- **Esperto:** È punto di riferimento per la lettura etico-legale del caso, promuove scelte proporzionate e contribuisce a procedure, audit e cultura della tutela nel servizio.